UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE PSICOLOGIA
Cátedra I de Teoría y Técnica de Exploración y Diagnóstico Mod. I. (Prof. Dra. Mikulic)

Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota para Adultos

MMPI-2

Guía Práctica de Administración, Procesamiento, e Interpretación

ISIDRO A. E. SANZ

2008

PRIMERA PARTE

Introducción histórica y descriptiva del instrumento

1. - INTRODUCCIÓN

El MMPI-2 es uno de los más conocidos y respetados instrumentos para la evaluación psicológica multidimensional de sujetos adultos, y se lo considera una de las técnicas más poderosas para evaluar la personalidad en la actualidad, particularmente en los contextos clínico y forense. Consiste en un inventario autoadministrable de 567 ítems con opción dicotómica de respuesta (verdadero o falso). Los ítems son frases que expresan sentimientos, creencias, o conductas abarcan y que permite evaluar síndromes clínicos, características de la personalidad, y diversos problemas significativos en la conducta o el entorno, incluyendo dificultades laborales, familiares, y académicas.

El MMPI-2 –al igual que su par para adolescentes, el MMPI-A- es el resultado de la revisión y actualización del MMPI (Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota) (Hathaway y McKinley, 1940, 1942). El MMPI comenzó a ser desarrollado en 1939 por el psicólogo Starke Hathaway con la colaboración de J. C. McKinley, como un instrumento para la evaluación y diagnóstico de pacientes atendidos en las dependencias hospitalarias de la Universidad de Minnesota (Butcher y Williams, 2000). El criterio de selección de los ítems verbales componentes para cada escala fue empírico, a fin de asegurar que las escalas identificaran correctamente a los diferentes grupos clínicos, independientemente del contenido de esos ítems. Con el tiempo, fue alcanzando progresivamente una gran aceptación entre los psicólogos de todo Estados Unidos, y de a poco se convirtió en el inventario objetivo de evaluación de personalidad más ampliamente utilizado y más investigado en todo el mundo. Fue empleado extensamente no sólo para evaluar pacientes psiquiátricos, sino también pacientes de otros servicios médicos, estudiantes, internos penitenciarios, personal militar, y postulantes para trabajos de alto riesgo (Butcher y Williams, 2000; Greene, 2000).

Durante los años 50 el MMPI trascendió las fronteras de EE.UU. y fue adaptado y aplicado en numerosos países, con rotundo éxito. En 1989 fue revisado por la comisión de investigadores de Minnesota y actualizado, siendo entonces subdividido en dos nuevos inventarios: el MMPI-A (para población adolescente) y el MMPI-2 (para adultos) (Butcher et al, 1989). Tal actualización también fue extendida a los otros países, incluyendo Argentina, donde fue inicialmente adaptado por M. M. Casullo y colaboradores de la Universidad de Buenos Aires (Brenlla, Maristany, y Diuk, 1992; Casullo, 1999). Posteriores revisiones fueron hechas en nuestro país (Gómez Dupertuis, 1998), incluyendo la actual que se acompaña con esta ficha, realizada por el autor y utilizada en la cátedra I de Técnicas de Exploración y Diagnóstico a cargo de la Dra. Mikulic.

La validez y confiabilidad del instrumento han sido reiteradamente probadas a lo largo de los años y en diferentes poblaciones, habiéndose acumulado una literatura científica de más de 12.000 publicaciones sobre esta técnica (Friedman et al., 2001). En sucesivas encuestas realizadas a profesionales de Estados Unidos, se ha encontrado que es uno de los tests más usados en evaluación psicológica y comparte los primeros lugares junto con el WAIS-R/WAIS-III y el Test de Rorschach (Archer, Buffington-Vollum, Vauter Stredny, y Handel, 2006; Watkins, Campbell, Nieberding, y Hallmark, 1995). Es asimismo uno de los más recomendados por los psicólogos forenses en los Estados Unidos para determinar inimputabilidad, riesgo de violencia, y fingimiento (Archer, 2006; Bow, Flens, Gould, y Greenhut, 2005).

Las razones por las cuales se argumenta la conveniencia de usar el MMPI-2 pueden resumirse como sigue, de acuerdo con Butcher y Williams (2000):

- Es fácil de administrar, tomando alrededor de 90 minutos
- Los ítems se responden simplemente eligiendo una de dos opciones de respuesta (verdadero/falso) y son de fácil lectura.
- El método de puntuación es mecánico y sencillo, e incluso existe computarizado.
- Tiene modos de evaluar la actitud del sujeto ante el test, para determinar cualquier intento de manipulación de las respuestas.
- La interpretación de los resultados es objetiva y está sólidamente apoyada en numerosas investigaciones.
- Las escalas del test tienen buena confiabilidad (sus puntuaciones son precisas y estables en el

tiempo).

- Las descripciones que se extraen de las interpretaciones de un perfil acerca de la personalidad y psicopatología del examinado son válidas, claras y dan información clínicamente útil, e incluso permiten predecir futuras conductas y respuestas a tratamientos.

2. - ELABORACIÓN Y ESTRUCTURA DEL MMPI

Historia

El MMPI (Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota) nació en 1939 con los trabajos de Hathaway y McKinley (1942), como un test objetivo verbal para evaluación psicológica y diagnóstico clínico de pacientes tanto adolescentes como adultos (Butcher y Williams, 2000). Hathaway era un talentoso psicólogo que se desempeñaba en el hospital de la Universidad de Minnesota y que se propuso incorporar un instrumento para complementar a las entrevistas de admisión de los pacientes psiquiátricos de dicho hospital, con el fin de objetivizar el diagnóstico. Para ello, en primer lugar había estado explorando los tests que en esa época existían, y al no hallar alguno que le convenciera por la relación costo/efectividad que él deseaba, decidió crear uno nuevo, contando con la colaboración de McKinley.

En la época en que surgía el MMPI, los pocos instrumentos objetivos de evaluación de personalidad que habían disponibles estaban demasiado ligados a teorías psicológicas específicas sobre la estructura de personalidad, al punto que resultaban poco prácticos para el uso general y habían sido desarrollados por estudiantes universitarios, o bien eran inventarios que evaluaban atributos no relacionados con la psicopatología. Esto motivó a Hathaway y McKinley (1942) a pensar un nuevo test que cumpliera con el cometido de (a) evaluar las múltiples dimensiones de la personalidad y su patología, y (b) evaluar desde una base estrictamente empírica y clínica, sin relación directa con una teoría específica de la personalidad.

Para la construcción del "Minnesota Multiphasic Personality Schedule" –así lo bautizaron en un principio- se partió originalmente de un conjunto (técnicamente denominado "pool") de alrededor de mil ítems, de los cuales se seleccionaron 550. La forma final de 1940 contaba 566 ítems[1] de respuesta dicotómica (Verdadero/Falso) cuyo contenido había sido inspirado en el de instrumentos existentes en esa época, así como en manuales y textos de psiquiatría, representando frases características de todo tipo de pacientes en atención de salud mental.

Hathaway y McKinley (1940) construyeron las escalas del MMPI sobre la base de las respuestas a esos ítems dadas por varias muestras de pacientes de la dependencia psiquiátrica del hospital universitario de Minnesota. Aquellos ítems que en conjunto podían discriminar pacientes con determinado trastorno o síndrome psiquiátrico en contraste con las respuestas de un grupo de referencia de sujetos no pacientes, eran adoptados para conformar una escala específica de ese trastorno. Por ejemplo, el ítem cuyo contenido dice: *"Soy feliz la mayor parte del tiempo"* fue contestado con una frecuencia significativamente más alta como *falso* dentro del grupo de pacientes depresivos que en el grupo normativo de sujetos no pacientes, por lo cual pasó a conformar la escala clínica número 2 del test, también llamada escala de *Depresión*. Hathaway y McKinley (1942) hicieron hincapié en la necesidad de asegurarse que los ítems fueran empíricamente representativos de los atributos que operacionalizaran, independientemente del contenido verbal que tuvieran. Por ejemplo, el ítem *"Me gustan los niños"* no parece tener -a primera vista- mucha relación con la psicosis (lo que le resta validez aparente y de contenido), pero la respuesta *falso* a este ítem fue más frecuente entre pacientes esquizofrénicos, por lo cual se lo incluyó en la escala clínica número 8, denominada escala de *Esquizofrenia*. Este procedimiento de validación del instrumento hace del MMPI posiblemente uno de los principales ejemplos de lo que se conoce como validez de criterio.

No obstante su nacimiento dentro del contexto psiquiátrico, el MMPI devino con el tiempo en el inventario de personalidad más aplicado e investigado en el mundo (Lees-Haley, Smith, Williams, y Dunn, 1996). Al poco tiempo, el MMPI fue usado también con pacientes de clínica médica general, adolescentes en escuelas, internos de institutos correccionales, pacientes en rehabilitación por adicciones, personal militar y policial, pilotos aéreos, personal operario de plantas nucleares, etc. A su vez fue progresivamente más utilizado como medida de referencia para investigaciones sobre salud mental y salud general.

Con el avance de su investigación y desarrollo, el inventario original fue traducido y adaptado a múltiples idiomas y aplicado a cientos de miles de personas en todo el mundo, adultos y adolescentes. A lo largo del tiempo y en numerosas dependencias universitarias, fue traducido y adaptado para Arabia, China, Holanda, Canadá, Francia, Alemania, Grecia, Israel, Italia, Japón, Corea, Noruega, Rusia, España, Chile, México, Tailandia, Turquía, Vietnam. Para 1989, ya se

[1] Si bien los ítems eran los 550 seleccionados, dieciséis de ellos fueron repetidos y agregados para que quedara un total de 566, solamente debido a una conveniencia técnica para su corrección mecanizada.

habían realizado más de 140 traducciones a utilizar en 46 países (Butcher y Williams, 2000).

Luego de cincuenta años de empleo e investigación, un grupo de notables de la universidad de Minnesota inició un importante programa de investigación denominado *Proyecto de re-estandarización del MMPI* (Butcher, Dahlstrom, Graham, Tellegen, y Kaemmer, 1989). Este trabajo se dedicó al objetivo de modernizar el contenido verbal de los ítems, debido a que muchos de ellos estaban quedando "fuera de época", a pesar de su demostrado poder predictivo. Asimismo, muchos otros ítems fueron modificados o eliminados, debido a objeciones posibles de tipo religioso o ideológico. Además, el proceso de reformulación de la técnica condujo a producir nuevos ítems y escalas con fines de evaluar atributos o síndromes de importancia contemporánea, como los trastornos de personalidad y los problemas escolares. En particular, muchos investigadores habían señalado la escasa presencia en el test original de ítems con contenido relevante y específico para población adolescente. De hecho, se fueron comprobando tendencias diferentes de respuesta al test comparando adolescentes con adultos. Por tales motivos, en el proyecto de re-estandarización de 1989 se decidió reemplazar al MMPI tradicional por dos nuevas versiones, una para adultos, el MMPI-2, con 567 reactivos, y otra para adolescentes, el MMPI-A, con 478 reactivos.

Este proyecto también implicaba una actualización estadística. Los baremos de referencia del inventario original estaban hechos sobre una población relativamente sesgada (blancos rurales oriundos de Minnesota), lo cual motivó muchas críticas sobre su aplicabilidad a otras poblaciones, incluso de EE.UU. Desde el momento de la re-estandarización, para el inventario de adultos se construyó una nueva muestra normativa de 2.600 sujetos de siete regiones de EE.UU., balanceada y estratificada en cuanto al género y características demográficas como edad, raza, educación, etc.

En 1992 la versión actualizada para adultos (MMPI-2) fue adaptada para la Argentina por primera vez por la cátedra de Técnicas Psicométricas de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, a cargo de la Dra. Martina Casullo (Brenla, Maristany, y Diuk, 1992). Posteriormente, Gómez Dupertuis (1998) hizo una revisión de aquella adaptación. La versión que acompaña esta ficha fue elaborada por Isidro Sanz, para uso en investigación, sobre la base de la comparación entre los ítems originales y las adaptaciones al español de la Universidad de Minnesota (para población hispana de EE.UU.) y la ya mencionada de Casullo.

Descripción estructural del test

El MMPI-2 (al igual que el MMPI original) es un inventario autoadministrable, por lo cual se provee al examinado de un cuadernillo conteniendo un instructivo con los ítems y una hoja de respuestas donde para cada ítem (identificado con su número de orden) se ofrecen dos casilleros de opción: verdadero y falso. El examinado completa el test contestando a cada ítem de acuerdo con el grado en que él supone que lo describe a sí mismo. La versión en cuadernillo para contestar en hoja de papel rellenando casilleros con lápiz es la más usada, pero también se aplica de modo computarizado, presentando al sujeto los ítems en pantalla. Cada ítem puntúa en una o más escalas según la dirección en que hubiese sido contestado. Dichas puntuaciones se vuelcan en numerosas escalas. Podemos diferenciar, a grandes rasgos, dos grupos de escalas: las ***básicas*** y las ***adicionales***. Las primeras constituyen el núcleo fundamental de la interpretación y se puntúan con los primeros 370 ítems del inventario. Las adicionales, por su parte, aportan información extra que enriquece al perfil obtenido con las escalas básicas, y requieren que el inventario haya sido completado hasta el último ítem. En total, hay ***trece escalas básicas***: tres escalas de validez del protocolo y diez escalas clínicas (que, en rigor, son ocho escalas clínicas más dos escalas de rasgos de personalidad, pero para simplificar se las suele llamar clínicas a las diez). A su vez, existen decenas de ***escalas adicionales***, incluyendo al menos siete de validez, quince de contenido, quince suplementarias, diez de trastornos de personalidad, y más.

Panorama de las escalas básicas del MMPI-2

Escalas básicas de validez. Las escalas de validez tienen por objeto evaluar la credibilidad del protocolo, esto es, determinan si existió algún sesgo marcado en el sujeto al responder al cuestionario. El sesgo puede haber sido dado por una necesidad de mostrar una imagen socialmente deseable, lo cual se evalúa con la escala *Mentiras* (L); o bien por una tendencia a exagerar los padecimientos, que se sondea con la escala de *Infrecuencia* (F); o bien por una actitud negadora defensiva, que se explora con la escala *Defensividad* (K).

Escalas básicas clínicas. Las otras diez escalas evalúan características y síntomas de la personalidad. La primera (Hs, *Hipocondría*) detecta las tendencias a generar síntomas somáticos en respuesta a estresores. La segunda (D, *Depresión*) es sensible a los estados anímicos depresivos desde los más leves y agudos a los más graves y crónicos. La escala 3 (Hy, *Histeria*) se relaciona con personalidades socialmente superficiales, egocéntricas, emocionalmente lábiles, y con pobre insight. La escala 4 (Pd, *Desviación psicopática*) tiene que ver con impulsividad y desacato a las normas. La escala 5 (Mf, *Masculinidad-Feminidad*) no es clínica, y se refiere a las tendencias tradicionalmente masculinas o femeninas en los hábitos del sujeto. La sexta escala (Pa, *Paranoia*) contiene ítems que aluden a suspicacia y procesos de pensamiento patológicos. La séptima (Pt, *Psicastenia*) se asocia con ansiedad, cavilaciones, e introspección. La escala 8 (Sc, *Esquizofrenia*) correlaciona con trastornos del pensamiento, conductas inadecuadas, y alucinaciones. La novena (Ma, *Hipomanía*) también explora trastornos del pensamiento, pero además impulsividad, desinhibiciones, y euforia. Por último, la escala 0 (Si, *Introversión social*) no es clínica, y evalúa la dimensión introversión-extraversión social de la personalidad. A su vez, ocho de las escalas básicas (Depresión, Histeria, Desviación psicopática, Masculinidad-Feminidad, Paranoia, Esquizofrenia, Hipomanía, e Introversión social) se subdividen en subescalas que evalúan atributos específicos dentro del compuesto de cada escala. Por ejemplo, *Aceleración psicomotriz* es una subescala de la escala Hipomanía. Es importante destacar que los nombres de las escalas fueron inspirados en rótulos diagnósticos de la época de Hathaway, impulsado también por el propósito de hacer de éste un test diagnóstico objetivo. Sin embargo, con lo que en la actualidad se sabe por las investigaciones, la interpretación de las escalas ***no se corresponde exactamente con esos diagnósticos***, así como tampoco con diagnósticos actuales del DSM-IV-TR. Antes bien, los correlatos empíricos estudiados señalan que estas escalas se asocian con modalidades conductuales, emocionales, cognitivas, sociales y de afrontamiento cuya comprensión permite describir la personalidad y sintomatología clínica (de haberla) del sujeto.

Panorama de las escalas adicionales del MMPI-2

En la estructura del MMPI-2, las trece escalas básicas (al igual que en el viejo MMPI) continúan siendo la esencia de la interpretación. Pero otras escalas (llamadas ***adicionales***) fueron desarrolladas o actualizadas para enriquecer el trabajo interpretativo. Algunas son de validez del perfil y otras son relativas a características clínicas o de personalidad.

Escalas adicionales de validez. Para evaluar la consistencia del perfil de respuestas, fueron incluidas dos escalas (VRIN, *Inconsistencia de Respuesta Variable*, y TRIN, *Inconsistencia de Respuesta Verdadera*). Estas escalas se componen de pares de ítems asociados, cuyas respuestas deben ser coherentes entre sí. Valores altos en estas escalas sugieren una tendencia de respuesta aleatoria o descuidada e invalidan el protocolo. Por su parte, además de conservar la vieja escala F (*Infrecuencia*) se incluye una segunda escala, la Fb (*F back*) que recopila las respuestas menos frecuentes de los últimos 200 ítems, con lo cual puede compararse la validez de las respuestas a la segunda mitad del test con la de la primera parte. Además de los controles con las escalas de validez mencionadas (L, F, Fb, K, VRIN, y TRIN), también se computa la cantidad de ítems a los que se omitió responder por algún motivo. En el caso de haber 26 o más ítems sin responder, se da por inválido el protocolo.

Escalas adicionales de personalidad o clínicas. También se incluyen dos tipos de escalas denominadas adicionales, es decir, que agregan información a las escalas básicas. Ellas son las ***escalas de contenido*** y las ***suplementarias***. Las escalas de ***contenido*** son escalas adicionales que por el contenido verbal de los ítems son fáciles de asociar con lo que evalúan. Por ejemplo, "*Frecuentemente me encuentro preocupado/a por algo*" es un ítem de la escala de Contenido Ansiedad (ANX). Otras escalas de contenido son: Obsesividad (OBS), Depresión (DEP), Preocupaciones por la Salud (HEA), Pensamiento bizarro (BIZ), Enojo (ANG), Cinismo (CYN), Baja Autoestima (LSE), Incomodidad social (SOD), Problemas familiares (FAM), e Indicadores negativos hacia el tratamiento (TRT). La elevación significativa de cualquiera de estas escalas sugiere la presencia de los síntomas, conductas, o actitudes a los que el nombre de la escala alude. Por otro lado, sin embargo, los sujetos reticentes a sincerarse en la evaluación, *pueden no elevar estas escalas* aún cuando padezcan de hecho alguno de esos síntomas.
Las otras escalas adicionales, además de las de contenido recién mencionadas, se denominan escalas ***suplementarias***. Estas escalas, a diferencia de las de contenido, no son tan fáciles de manipular porque su interpretación no se delata en el contenido de los ítems. Varias de estas escalas también estaban en el viejo MMPI. Las principales conocidas son: Ansiedad (*A*) (una

medida de malestar general), Represión (*R*) (una medida de constricción emocional y de los impulsos), Fortaleza del yo (*Es*) (sensible a la tolerancia al estrés y el buen pronóstico), y la escala revisada de Alcoholismo de MacAndrew (*MAC-R*) (muy relacionada con control de impulsos y adicciones).
Existen aún varias escalas más, como las de trastornos de personalidad y las de los cinco factores psicopatológicos, que también colaboran con la interpretación.

¿Qué evaluamos con el MMPI-2?

En síntesis, la estructura básica del MMPI-2 permite evaluar primeramente si el protocolo es ***aceptable para interpretar***, y si es así, describir las ***características básicas de la personalidad***, subrayando la presencia de ***síntomas psicopatológicos*** en el caso de existir éstos. Además de las trece escalas básicas descriptas y las subescalas, el inventario contiene numerosos ítems adicionales que puntúan en otras escalas, aportando información extra muy útil para integrar a la interpretación. En la re-estandarización de 1989, las escalas básicas se mantuvieron en gran medida, sufriendo escasas eliminaciones de ítems y leves modificaciones en algunos de sus componentes. Las escalas adicionales, en cambio, tuvieron mayores modificaciones, incluyendo la eliminación de varios ítems y hasta de escalas enteras, y el agregado de nuevas escalas. En la actualidad, el MMPI-2 (de adultos) y el MMPI-A (de adolescentes) tienen el mismo formato (inventario con ítems a responder como verdadero o falso) pero bastantes diferencias en el contenido, particularmente en lo que hace a los ítems de las escalas adicionales.

¿Cómo se corrige un protocolo?

Cada ítem puntúa para una o más escalas, según la dirección en que hubiese sido contestado. La mayoría de las escalas se componen de varias decenas de ítems de los cuales algunos son claves cuando se los responde como verdaderos y otros cuando son tildados como falsos. Se suman los ítems respondidos en la dirección clave de cada escala; a dichas sumas se las llama ***puntajes brutos***. Una vez extraídos los puntajes brutos correspondientes a cada escala, éstos deben ser convertidos a ***puntajes T***, para lo cual los manuales proveen de una tabla, al igual que como se hace en otros tests, como por ejemplo, las escalas de inteligencia Wechsler. Esta tarea de suma de puntuaciones y conversiones a valores T es algo que puede hacerse manualmente, por medio de plantillas transparentes, o bien a través de software específicos. Dadas las diferencias entre las respuestas de hombres y mujeres, las conversiones a puntuaciones T cambian según el sexo del examinado, tanto en adolescentes como en adultos. Por tal razón hay tablas de conversión separadas para confeccionar perfiles femeninos o masculinos. Los gráficos de perfiles del MMPI-2 tienen una puntuación T mínima de 30 y máxima de 120, con una media ajustada en 50 y una desviación estándar de 10.

SEGUNDA PARTE

Administración y corrección

3. – ADMINISTRACIÓN

Prerrequisitos

Preparación y condiciones clínicas. El cliente debe estar preparado por el psicólogo acerca de la importancia de evaluar su personalidad, ya sea en un contexto clínico ambulatorio, en una internación psiquiátrica o en una pericia forense. De este modo nos aseguraremos de contar con su colaboración. Pacientes en estado maníaco, o con alucinaciones extremadamente perturbadoras, o clientes simplemente demasiado reticentes, no podrán hacer el test hasta que tales condiciones clínicas desaparezcan. Los sujetos con un funcionamiento cognitivo y lingüístico muy deficitario, particularmente quienes tengan retardo mental, demencias, o lesiones cerebrales que afecten el lenguaje, tendrían demasiadas dificultades para completar el test y tampoco se recomienda su uso en esos casos.

Educación. Es necesario un nivel de estudios primarios completos para leer y comprender los ítems del inventario, por lo cual es inconveniente aplicar el MMPI-2 a sujetos que no hayan completado la escuela primaria, y en especial los que no hayan llegado a sexto grado.

Edad. El cliente debe tener como mínimo 18 años de edad. Si tiene exactamente 18 y todavía se encuentra cursando la escuela, es preferible tomarle el MMPI-A.

Materiales

Se trata de un inventario autoadministrable; por lo tanto, debe proveerse al examinado de un cuadernillo con los ítems y una hoja de respuestas que tenga los pares de opciones para contestar cada ítem. También existen versiones computarizadas que presentan cada ítem por vez en pantalla y el sujeto contesta con el teclado o el *mouse*. Para clientes ciegos o con serios problemas visuales, existen versiones grabadas en casete.

Al momento de administrar el test, hay que suministrarle al sujeto el siguiente material:
1) Inventario con las 567 frases.
2) Hoja de respuestas con las opciones verdadero/falso para cada ítem.
3) Lápiz blando (N°2) y goma blanca.

Procedimiento

Antes de citar al sujeto para administrar la prueba, siempre es importante asegurarse de que: (a) ese día cuente con dos horas de tiempo, y (b) lleve anteojos si los usa para leer. El sujeto tiene que estar cómodamente sentado con algún apoyo para escribir, en un ambiente tranquilo y con buena iluminación. Debe prepararse al sujeto indicándole que va a leer una serie de frases (señalándole el cuadernillo) a las que tendrá que contestar como verdaderas o falsas (señalándole las opciones en la hoja de respuestas). Puede instruírsele de este modo:

Las frases de este cuadernillo pueden o no describir cómo es Ud., cómo se siente, y cómo piensa. Si la frase expresa lo que a Ud. le pasa o lo que Ud. piensa, entonces contéstela como verdadera (V), rellenando el círculo izquierdo correspondiente al número de esa frase. Si en cambio, Ud. no está de acuerdo con esa frase aplicada a Ud. mismo, entonces márquela como falsa (F), rellenando el otro círculo. Trate de contestar todas las frases y asegúrese de que el número de cada frase que contesta coincida con el de la hoja de respuesta. Si se equivoca, borre con la goma y luego rellene el círculo que corresponda.

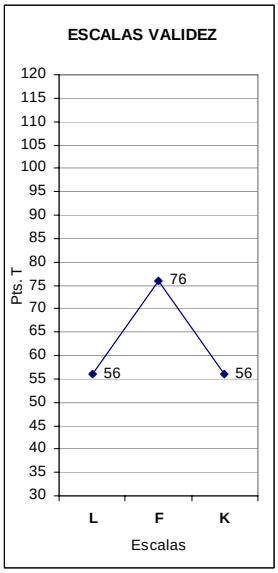
Conviene hacer entender la diferencia entre Verdadero/Falso y Sí/No. La gente que considera sus respuestas como Sí/No corre el riesgo de equivocarse al contestar las frases redactadas en negativo. Por ejemplo, si una frase dijera: "No estoy triste" y el sujeto cree que efectivamente él no está triste, puede cometer el error de pensar "claro, no estoy triste, contesto que no", cuando la respuesta adecuada sería Verdadero (es *verdad que no* estoy triste). Es recomendable hacer los primeros tres o cuatro ítems junto con el sujeto, para asegurarse de que haya comprendido el procedimiento. También es importante, en caso de necesitar aclararlo, que las frases no tienen respuestas correctas o incorrectas *per se*, sino que son verdaderas o falsas según cómo es cada persona y que lo fundamental es que nos responda lo que él o ella sienta como descriptivo de sí mismo.

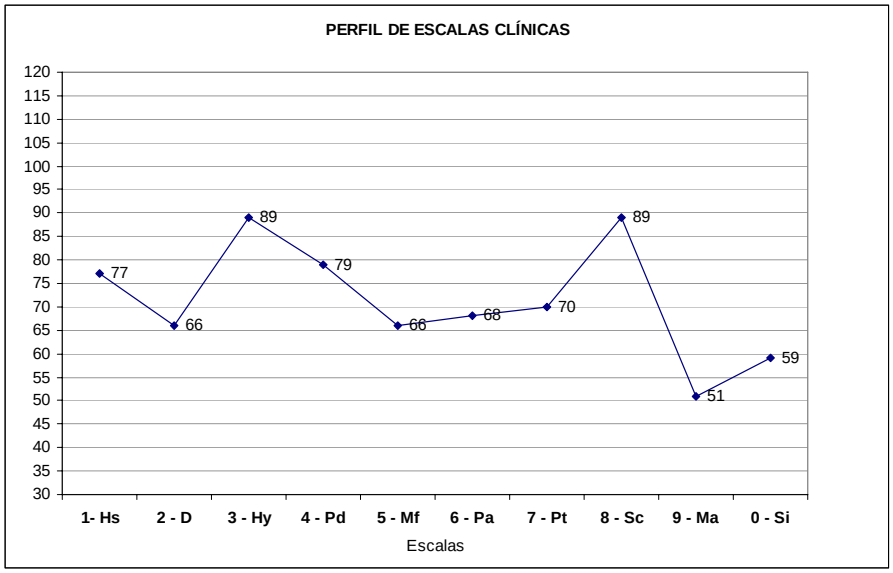
4. – CORRECCIÓN

En la gran mayoría de las escalas, se suman los ítems que fueron contestados en la dirección clave, y a esa suma se la llama ***puntaje bruto***. Algunas escalas tienen un procedimiento algo más complicado, y son las escalas clínicas 1, 4, 7, 8, y 9 (a las que hay que sumar parte o el total del puntaje bruto de la escala K) y las escalas de consistencia VRIN y TRIN (que suman pares de ítems inconsistentes).

Una vez obtenidos los puntajes brutos, se busca en las tablas de conversión a qué ***puntajes T*** corresponden. Las tablas están confeccionadas por género. Los puntajes T van de un mínimo de 30 a un máximo de 120 y permiten no sólo situar al sujeto en relación a la población, sino también ***equiparar a todas las escalas*** independientemente de la longitud de cada una. Si no fuera así, sería imposible compararlas porque hay una gran variación en la cantidad de ítems que tiene cada escala y, por consiguiente, en el número de puntajes brutos que puede alcanzar. La población general distribuye sus puntuaciones T entre 41 y 64 para todas las escalas.

Al exponer los resultados de la conversión de los puntajes brutos en puntajes T, se estila utilizar un gráfico de líneas, como el que se ve abajo:





TERCERA PARTE

Interpretación

Lo que se expone a continuación tiene el propósito de orientar al lector en el procedimiento de la interpretación del MMPI-2, basándose en las indicaciones de autores mundialmente reconocidos por su experticia en la técnica, en particular Butcher y Wiliams (2000), Friedman, Lewak, Nichols, y Webb (2001), Graham (2005), y Greene (2000). Para mayor profundización se recomienda la lectura directa de tales fuentes, que figuran en las referencias bibliográficas.

5. – VALIDEZ DEL PROTOCOLO

Con las escalas de validez se pretende evaluar si el perfil del protocolo representa realmente el funcionamiento psicológico del cliente o si hay grandes distorsiones debido a descuidos o inconsistencias en las respuestas o intentos de manipulación de imagen.

Omisiones
Se señala con el signo **?** el número de ítems sin contestar, y también los que hubiesen sido contestados en ambas direcciones. Este dato del test no es una escala, sino un simple valor bruto que sirve para saber si el cliente contestó un número suficiente de frases como para interpretar con confianza el protocolo. El criterio es el siguiente:

Cantidad de omisiones	Interpretación
0-2	Protocolo confiable
3-5	Protocolo aún confiable, pero se recomienda leer los ítems omitidos por su temática
6-25	Torna dudosa la interpretación, conviene pedirle al cliente que complete los ítems faltantes
26+	Muy probablemente inválido, por falta de cooperación o extrema patología. Conviene pedirle al cliente que complete los ítems faltantes

Consistencia

Otra de las variables que hay que examinar es la consistencia interna de las respuestas. Para ello existen dos tipos de escalas: las que comparan pares de ítems y las escalas con ítems infrecuentes. Ambos recursos, usados en conjunto, son muy eficaces para detectar patrones aleatorios de respuesta.
Hay dos escalas formadas por pares de ítems asociados por su contenido. Esas escalas son la ***VRIN***, *Inconsistencia de Respuesta Variable*, y la ***TRIN***, *Inconsistencia de Respuesta Verdadera*. Los ítems deben ser contestados de manera coherente para que el protocolo sea confiable, de lo contrario, a mayor cantidad de incoherencias, más subirá el puntaje de estas escalas. Por ejemplo, un par de ítems es:

- *Casi siempre me siento triste.*
- *Soy feliz la mayor parte del tiempo.*

Si ambos son contestados como verdadero (o como falso), se advierte una inconsistencia.
Las otras variables útiles para explorar consistencia son las escalas de infrecuencia ***F*** y ***Fb***, y la comparación entre ellas.

Escala VRIN (*Inconsistencia de Respuesta Variable*)
Contiene 67 pares de ítems. Totales brutos *mayores a 13* tornan cuestionable la consistencia del protocolo. Conviene examinar con cuidado el perfil y ver si efectivamente se corresponde con la observación clínica del caso. A veces pacientes psicóticos en episodio agudo pueden elevarla debido a su intensa confusión mental, la cual debería ser verificable clínicamente.

Escala TRIN, *Inconsistencia de Respuesta Verdadera*)
Contiene 23 pares de ítems. A diferencia de la ***VRIN***, que detecta cualquier inconsistencia, la ***TRIN*** evalúa específicamente la presencia de inconsistencias debidas a una tendencia a contestar todo Verdadero o todo Falso. Valores elevados en esta escala (Puntaje T >65) no invalidan necesariamente el protocolo (a menos que la ***VRIN*** esté también elevada), pero indican una tendencia aquiescente (contestar todo "verdadero") o bien negadora (contestar todo "falso").

Escala F
La escala ***F*** (*Infrecuencias*) reúne 60 ítems que raramente (menos de un 10% de las veces) puntúan de ese modo en población general. Ej.: *Aparentemente oigo tan bien como la mayoría de las personas. (Falso)*. Los ítems de esta escala llegan hasta el n° 361.
Por azar, la mitad de esos ítems serían contestados significativamente. Es decir, que un valor bruto cercano a 30 indicaría que muy probablemente el cliente no está fijándose en lo que responde.

Escala Fb
La escala ***Fb*** (*F back*) es similar a la ***F*** pero fue pensada para la segunda mitad del inventario. Por lo tanto, ***Fb*** incluye a los 40 ítems menos frecuentes de responderse en el sentido clave que aparecen a partir del ítem n° 281. Al igual que con la ***F***, por puro azar podrían contestarse significativamente la mitad de los componentes de esta escala. Por lo tanto, un valor bruto próximo a 20 sugiere que la segunda mitad del test fue contestada de modo aleatorio o incoherente. Esto puede ocurrir en clientes que a lo largo de la evaluación se fatigan y se confunden al responder los últimos ítems.

Relación F-Fb
Si restamos (usando los valores brutos, no los puntajes T) la escala ***F*** menos la ***Fb***, tenemos la fórmula ***F-Fb***. Se espera que haya poca diferencia entre una escala y otra. Si la resta da 7 o más, es posible que el test haya sido contestado inconsistentemente. Si da 10 o más, el protocolo es definitivamente inconsistente.

Reporte sintomatológico exagerado

Escala F y Escala Fb

Las escalas ***F*** (*Infrecuencias*) y ***Fb*** (*F back*) se componen de ítems que puntúan normalmente de modo inverso en población general. Por eso es común que sus valores sean bajos o moderados (menos de 60 puntos T). A mayor elevación, mayor desajuste, sintomatología y malestar tiene el sujeto. No es raro que se eleven en pacientes psiquiátricos, particularmente entre los internados y los psicóticos (estos últimos levantan más aún la ***F*** que la ***Fb***). Desórdenes agudos, aún no psicóticos, también la elevan. Quienes intentan exagerar sintomatología por conveniencia (como puede ocurrir en prisioneros) también tienden a puntuar muchos de estos ítems. Se sugiere esta guía para interpretar ambas escalas:

Puntaje T	Interpretación
< 46	Intento de negar problemas o bien indicación de personalidad normal muy convencional.
46-58	Valor normal. El cliente reconoce tener algunos problemas.
59-80	Elevación típica del ambiente clínico. El paciente se queja y reconoce síntomas varios que motivan su consulta.
81-110	Elevación excesiva, potencialmente invalidante del protocolo. Si (a) no hay motivo para exagerar, (b) la escala ***VRIN*** está normal, y (c) el paciente es psicótico o con otro trastorno grave, el perfil es realista y aceptable.
>110	Puede tratarse de un paciente psicótico sumamente productivo y clínicamente ostensible. De lo contrario, el protocolo es inválido.

Escala F(p)
Esta escala, denominada escala de *Frecuencia Psicopatológica*, también esta formada por ítems respondidos en la dirección significativa con baja frecuencia, pero no en población general, sino

en población psiquiátrica. El objetivo es detectar a quienes intentan fingir enfermedades psiquiátricas. La siguiente tabla resume la interpretación (usando los valores brutos):

Valores brutos	Interpretación
0-1	Escaso o nulo malestar emocional y ausencia (o negación) de síntomas.
2-3	Protocolo confiable.
4-8	El paciente sufre un malestar que, o bien es importante, o bien lo exagera.
>8	Exageración de la gravedad del cuadro.

Índice F-K
El *índice de Simulación* de Gough se basa en restar el valor bruto de ***F*** menos el de la escala ***K*** (*Defensividad*). Por ejemplo, alguien que obtuvo 12 ítems significativos en la escala ***F*** y 5 en la escala ***K***, tiene un índice Gough igual a 7 (*12 – 5 = 7*). Los sujetos que elevan la escala ***F*** por intentar mostrarse enfermos suelen bajar a su vez la escala ***K*** para reportar pobreza de recursos. Esto lleva a dilatar la diferencia entre ambas escalas. Por eso, cuando aplicamos este índice, entendemos que, a mayor valor positivo, mayor probabilidad de exageración. La siguiente tabla indica los valores para la interpretación:

F - K	Interpretación
< –11	Escaso o nulo malestar emocional y ausencia (o negación) de síntomas.
Entre –11 y +1	Protocolo confiable.
Entre 2 y 20	El paciente sufre un malestar que, o bien es importante, o bien lo exagera.
>20	Exageración de la gravedad del cuadro.

Escalas Ds y Ds-r
Las escalas ***Ds*** (*Disimulación*) y ***Ds-r*** (*Disimulación-Revisada*) fueron creadas para distinguir a quienes pretender exagerar síntomas neuróticos. La segunda es una versión más corta de la primera. Se requiere más investigación sobre ellas, pero puede considerarse que en la ***Ds*** valores brutos mayores a 27 (en población general) o 39 (en pacientes) son muy significativos.

Reporte sintomatológico minimizado

Escala L
Esta escala (*Mentiras*) evalúa la tendencia a presentar una imagen de sí deseable y moralmente irreprochable. Todos sus ítems son significativos cuando se contestan como falso. Por ejemplo, "*No siempre digo la verdad*". A mayor elevación, mayor intento de crear una imagen favorable de sí mismo. Los clientes de menor nivel socio educativo tienden a levantar la escala un poco más. A continuación se resumen los cortes para interpretar:

Valores brutos	Interpretación
0-2	Si las escalas de exageración no revelan simulación, este valor indica sinceridad y reconocimiento de pequeñas faltas.
3-5	Delata cierto equilibrio entre reconocer faltas menores y negar otras. En personas muy educadas, indica probable manejo de imagen.
6-7	Si no hay sesgos en las otras escalas de validez, puede indicar un uso exagerado de la negación o una persona muy moralista.
>7	Sugiere varias alternativas: - Un cliente normal pero muy autocontrolado y con poco insight. - Alguien muy conservador y moralista que niega faltas menores. - Una persona sencilla que intenta crear ingenuamente una imagen demasiado favorable (por ejemplo, en selección de personal). - Empleo excesivo de la negación (Ej.: en histriónicos y en somatomorfos). - Un paciente psicótico, cuando todas las escalas clínicas están debajo de 60.

Escala K
Esta escala, de *Defensividad*, o también llamada de *Corrección*, fue creada a partir de protocolos de sujetos con cuadros psicopatológicos definidos pero que puntuaban las escalas clínicas dentro del rango normal. Un ejemplo es "*A veces me siento inútil*" (*Falso*). Las personas saludables puntúan de moderado a alto en esta escala, pero también lo hacen quienes deliberadamente

pretenden mostrarse más sanos. Cuando el protocolo es contestado sinceramente, indica el potencial de recursos de la persona. La tabla adjunta abajo presenta las claves interpretativas.

Valores brutos	Interpretación
<9	Posible exageración de dolencias y de incapacidades. Puede indicar un episodio psicótico. El pronóstico es reservado.
9-12	Limitados recursos y malestar severo. Pobre autoconcepto e insatisfacción consigo mismo. En pacientes de bajo nivel socioeconómico, indica malestar moderado, pero en pacientes de mayor nivel, implica severo malestar. El pronóstico para una intervención terapéutica es limitado.
13-17	Balance adecuado entre exponer limitaciones personales y poseer recursos de afrontamiento. Estos clientes cuentan con recursos como para tolerar las demandas de un tratamiento y comprometerse. En sujetos de mayor nivel socioeconómico, indica moderado malestar. Buen pronóstico.
18-22	Indica defensividad y baja disposición a admitir problemas psicológicos. Negación y defensas histéricas pueden ser mecanismos comunes, particularmente en sujetos de clase baja.
>22	Extrema defensividad y nula disposición a admitir problemas psicológicos. Carencia de insight y/o manejo de imagen. Pronóstico malo.

Escala Sd – Escala Wiggins de Deseabilidad Social

Esta escala nació de una comparación entre estudiantes que hicieron el test honestamente y otros que lo respondieron simulando deliberadamente una imagen deseable. A mayor elevación, mayor intento de manipular las respuestas del test. A continuación se sintetiza la interpretación de esta escala:

Valores brutos	Interpretación
< 11	Reporta alto malestar emocional y numerosos síntomas.
11-15	Perfil confiable.
16-20	Puede indicar un sub-reporte de problemas psicológicos y malestar. Si es un paciente, hay que evaluar el motivo de esta actitud. Y aún no siendo paciente, este rango de respuesta indica negación de incluso las mínimas molestias o perturbaciones esperables en cualquier persona.
> 20	El cliente reporta mucho menos sintomatología o malestar que lo esperable. Puede implicar una negación deliberada o carencia de insight.

Escala S - Superlativo

Es una escala creada a partir de tendencias típicas en protocolos de aspirantes a pilotos aéreos en comparación con los hombres del grupo normativo. Quienes puntúan alto se presentan como bien adaptados y virtuosos; y son descriptos por sus cónyuges como personas con autoconfianza, relajadas y animosas. Si bien los ítems representan buen ajuste, la elevación significativa de esta escala reporta más virtudes y fortalezas que lo normal. En el ámbito clínico, no es de esperar elevaciones en esta escala. Se presenta abajo la interpretación de los distintos rangos de valores brutos:

Valores brutos	Interpretación
< 21	Reporta alto malestar emocional y numerosos síntomas.
21-34	Perfil confiable.
35-42	Puede indicar un sub-reporte de problemas psicológicos y malestar. Si es un paciente, hay que evaluar el motivo de esta actitud. Y aún no siendo paciente, este rango de respuesta indica negación de incluso las mínimas molestias o perturbaciones esperables en cualquier persona.
>42	No es un valor raro en selección de personal. El cliente reporta mucho menos sintomatología o malestar que lo esperable. Puede implicar una negación deliberada o carencia de insight.

Escala So – Escala Edwards de Deseabilidad Social

Edwards desarrolló esta escala a partir de ítems seleccionados por jueces y luego por estudios discriminativos para representar tendencias a generar una buena imagen. Valores brutos por encima de 34 son significativos de intentos de manipulación de las respuestas.

6. – ESCALAS CLÍNICAS

Existen importantes correlatos clínicos investigados extensamente hasta la fecha para cada una de las escalas clínicas. Los más numerosos han sido encontrados para las elevaciones (más de 65 puntos T) de las escalas, pero también hay interpretaciones posibles para otros rangos de puntuación. A continuación se describen las respectivas interpretaciones de cada rango para cada escala.

Escala 1 - Hs (Hipocondría)

La escala representa temores y preocupaciones en torno al estado físico, potencial inmadurez, dependencia y carencia de insight.

Rangos de puntuación
Alto (>65)
Preocupaciones sobre miedos a enfermedades, quejas y ansiedades somáticas. Este patrón es resistente al cambio a lo largo del tiempo. Sensación de displacer corporal. Ven al cuerpo como fuente de dolores. Egocentrismo y tendencia a usar sus dolencias para manipular a otros. Dificultad para expresar el enojo, tozudez, bajo perfil, y escaso impulso vital. Actitud cínica hacia la vida, incluso en pacientes con reales problemas físicos. Generalmente la sintomatología de malestar físico no es respuesta directa a un estresor reciente, sino resultado de una disfunción crónica para manejar el estrés cotidiano. Si el puntaje T llega a 75, los temores somáticos se tornan dominantes. El pronóstico es reservado o malo, suelen abandonar psicoterapias y consultan a varios médicos. Convienen tratamientos de contención, para la asertividad y manejo del enojo.
Medio (55-65)
Posible reacción a un real problema físico, lo cual puede ser acompañado de una elevación en la escala ***2***. Aún así, revela una tendencia pesimista sobre la salud, cierta dificultad para expresar el enojo, y una potencial reacción somática al estrés.
Bajo (35-45)
Generalmente buena salud y alto nivel de energía, siempre que no hayan escalas clínicas elevadas.
Muy bajo (<35)
Puede indicar una reacción a una historia familiar con hipocondríacos, o un descuido general sobre el estado de salud física. En caso de estar elevada la escala ***2***, representa la dejadez o indiferencia depresiva sobre los cuidados físicos.

Escala 2 - D (Depresión)

Cuando se eleva, suele estar acompañada de otra/s escala/s elevada/s (típicamente la ***7***, la ***8***, la ***1***, y la ***0***). Refleja malestar emocional, particularmente el actual, y es sensible a los cambios de estados anímicos. También tiende a subir con la edad.

Rangos de puntuación
Alto (>65)
Representa depresión, ansiedad, preocupaciones, baja autoestima, y pesimismo. Reducción del rango de intereses, baja tolerancia a la frustración, sentimientos de inutilidad, culpa, y desazón. Cuanto más alta sea, más deprimida está la persona y más síntomas cognitivos tiene (desconcentración, desmoralización) y demuestra menos eficiencia general. Si no supera los 85 puntos T y no hay otras escalas elevadas, tiende a ser de buen pronóstico. Buena respuesta a terapias cognitivas y a intervenciones breves conductuales sobre el motivo de consulta. Elevaciones mayores, en cambio, indican cronicidad y mayor gravedad, con dificultoso tratamiento.
Medio (55-65)

Moderada inhibición, introspección, y tendencia a sentirse fácilmente culpable. Baja autoconfianza y actitudes pasivas ante los conflictos. Proclividad a ser responsables, evitar riesgos y a pensar en términos dicotómicos de bien/mal, especialmente si está elevada la escala ***L***.
Bajo a Muy bajo (<45)
Tendencia a ser animoso, confiado en sí mismo, activo, con sentido del humor, y extraversión social (siempre que no haya elevaciones en otras escalas clínicas). En ciertos casos, más si está elevada la escala ***4*** o la ***9***, o la ***K*** está baja, indica impulsividad y desinhibición. Debajo de 40 puede indicar negación de la depresión en un paciente bipolar o ciclotímico, más si se eleva la escala ***9***.

Escala 3 - Hy (Histeria)

Refleja la negación de los conflictos, y la tendencia a quitar la atención de lo doloroso y ponerla sobre algo positivo. Este rasgo puede ser parte del funcionamiento de la personalidad o bien el modo predominante de afrontamiento. Representa un clásico patrón neurótico, y generalmente contraindica psicosis.

Rangos de puntuación
Alto (>65)
Los clientes que elevan esta escala muestran una o más de estas tres condiciones: uso de la represión y la negación; ingenuidad e inmadurez; y síntomas somáticos relacionados con la ansiedad. Son demandantes de afecto y de aprobación, y tienen vida social activa, aunque la cercanía íntima los asusta. La necesidad de atención y aprobación los lleva a comprometerse en situaciones que más tarde les pueden resultar demandantes, y entonces reaccionan con resistencia pasiva y somatizaciones que le sirven para renunciar a los compromisos. Su insight es escaso, en la medida que se defienden con negación y somatización. Suelen buscar llamar la atención, incluso algunos son exhibicionistas, y pueden tener actings out sexuales o agresivos debidos a la represión continua. Las actuaciones agresivas no son probables en el caso de que ésta sea la única escala elevada. El pronóstico es reservado por tratarse de una estructura con sólidas defensas y baja percepción de estrés. Los tratamientos breves conductuales focalizados son mejor recibidos por estos pacientes, que tienden a abandonar una vez aliviados. No es de esperar cambios significativos a menos que se apliquen terapias de largo plazo, en las cuales difícilmente se mantengan hasta el final.
Medio (55-65)
Optimismo ante la vida. Extraversión social y orientación al logro. Propensión a negar conflictos, complacer a otros, y consecuente vulnerabilidad de desarrollar sintomatología física ante la acumulación de estresores. Puede haber negación o represión de emociones negativas en algunas áreas.
Bajo a Muy bajo (<45)
Refleja a alguien con mirada cruda de la vida, algo cáustico y chato afectivamente. Escasa represión y reducción del radio de intereses. Mirada cínica y misantrópica. Si no hay escalas elevadas en el perfil, indica que el cliente se ve a sí mismo como alguien realista que llama a las cosas por su nombre, con trato directo y tosco, aunque no necesariamente hostil. No se comprometerá en lo que no quiera y no hará halagos a nadie a menos que realmente lo sienta. Si, en cambio, hubiera otras escalas elevadas, la escala ***3*** en este rango señala que el cliente sufre por ser conciente de su malestar y de la dificultad para frenar ideas e impulsos.

Escala 4 - Pd (Desviación psicopática)

Se trata de una escala de composición heterogénea, por lo cual no necesariamente va a indicar rasgos antisociales o agresivos para todos los casos. Pero sí indica tendencia a la independencia, oposición a las reglas convenidas, cautela en el trato cercano, y desconfianza. Quienes puntúan alto generalmente son manipuladores y mantienen distancia emocional como forma de protección personal. El nivel socioeconómico y educativo tiene impacto en la interpretación de esta escala, porque los sujetos de mayor nivel con puntaje alto en la escala también pueden ser delincuentes de "guante blanco". La historia vital es además muy importante para interpretar esta escala: antecedentes de acting out frecuente, problemas con la agresividad y el contacto emocional, y

rebeldía sugieren un perfil crónico. En cambio, si el cliente está atravesando un momento crítico interpersonal, como un divorcio, la elevación de la escala puede ser situacional.

Rangos de puntuación
Alto (>65)
Representa rebeldía, resistencia a las reglas y dificultades con la autoridad, enojo e irritabilidad. El resentimiento puede ser hacia la familia y/o hacia la sociedad. Si no se trata de una situación crítica, puede indicar oposicionismo adolescente o la rebeldía y la sensación de pertenecer a un grupo minoritario. El modo en que el enojo pueda expresarse varía en función de lo que indiquen otras escalas. Si se acompaña de elevaciones de la escala ***9***, será probablemente con acting out, el cual puede ser bizarro si también está elevada la escala ***8*** y baja la escala ***K***. Si bien pueden ser personas sociables, e incluso tener carisma (especialmente cuando la escala ***0*** es muy baja) sus vínculos son superficiales y breves. Hay dificultad para hacer empatía y aceptar las demandas de otro, lo cual obstaculiza relaciones duraderas. Muestran baja tolerancia a la frustración, inhabilidad para postergar las gratificaciones, y tendencias muy hedonistas, particularmente cuando baja la escala ***K***. A su vez, si la escala ***K*** está por encima de 60 puntos T, las mismas conductas aparecerán de un modo más controlado. En la vida íntima puede haber historias de infidelidades y comportamientos sexuales poco convencionales. Como defensa típica usan la externalización, responsabilizando a otros de sus problemas. Aún cuando estos clientes mencionen sentir culpa o malestar, tales sentimientos son transitorios y no modifican su patrón de conducta. También es probable la presencia de alcoholismo o tal vez abuso de otras sustancias, más aún cuando se eleva la escala ***MAC-R***. Esto último puede no ser reportado e incluso ser negado por el cliente, dada su tendencia a fijarse bien en lo que habla. La historia muchas veces indica una familia poco continente que forzó al cliente a desarrollar tendencias egoístas para preservarse. Pronóstico reservado por su bajo nivel de malestar y por su pretensión de que sean los demás quienes tienen que cambiar para acomodarse a sus expectativas. La carencia de insight y la externalización atentan también contra la terapia. Suele darse en sujetos derivados a tratamiento por terceros, raramente consultan por sí mismos, y rápidamente abandonan. A veces, la simple maduración con la edad y una educación que ayude a canalizar sus talentos pueden favorecer un cambio positivo. Si el puntaje de la escala ***2*** es menor a 50 puntos T, las probabilidades de cambio son mínimas. Los únicos tratamientos posibles son los breves conductuales focalizados en el motivo de consulta.
Medio (55-65)
Indica tendencias a la aventura, conductas riesgosas y emocionantes, asertividad, energía, sociabilidad, e independencia de ideas. Generalmente estos rasgos son positivos en tanto implican impulso vital, iniciativa, e independencia. No obstante, ante las frustraciones, el cliente puede tornarse irritable, agresivo e inadaptado socialmente. En este rango todavía se observan tendencias manipulativas, pero a un nivel de rasgo de personalidad.
Bajo a Muy bajo (<45)
Convencionalidad, pasividad, estabilidad, y falta de asertividad. El cliente es demasiado conformista y dependiente, aferrándose a reglas rígidamente. No son activos buscadores de intimidad pero sí de aprobación y consejo por parte de los otros.

Escala 5 - Mf (Masculinidad-Feminidad)

Esta escala fue pensada para detectar homosexualidad, pero resultó más eficaz para reflejar la tendencia a un patrón de intereses y comportamientos tradicionalmente asociados con el género opuesto.

Rangos de puntuación
Alto (>65)
En hombres, indica introspección, amplio espectro de intereses y apertura a la experiencia estética e intelectual. Suelen ser hombres imaginativos, idealistas, y con sensibilidad social. No es raro en altos niveles educativos, especialmente entre científicos sociales, artistas, y docentes. En algunos hombres puede sugerir un perfil reactivo hacia estereotipos masculinos y una inclinación por la pasividad y la no competitividad, particularmente si se acompaña de una escala ***4*** baja. Si bien este perfil no es suficiente para indicar homosexualidad masculina, la elevación por encima de los 75 puntos T junto con una educación menor que terciaria/universitaria o bajo interés cultural señala un perfil de comportamiento poco masculino.

Mujeres con este puntaje generalmente son asertivas, competitivas, y poco preocupadas por mostrar una conducta típicamente femenina. Suelen ser independientes, con autoconfianza, y hasta agresivas. Pueden interesarse por ocupaciones, actividades, y deportes comúnmente elegidos por varones, e incluso tener una orientación sexual lesbiana. Muchas de estas mujeres se sienten incómodas cuando no pueden tener el control.
En cuanto a pronóstico, es reservado debido a que el bajo malestar sentido limita la motivación para un cambio. Refleja incluso resistencia a tocar temas personales, aún con un psicólogo. Se recomiendan tratamientos breves conductuales focalizados.
Bajo (35-45)
En hombres, refleja patrones de interés y comportamiento típicamente masculinos y sus intereses generalmente están circunscriptos a esas áreas. Les agradan las actividades físicas y al aire libre, y ocupaciones relacionadas con la competición o la mecánica. Suelen tener un perfil bajo en cuanto a ambiciones laborales.
En mujeres, representa una especial sensibilidad con respecto a las relaciones interpersonales, especialmente con hombres. Tienden a ser contenedoras pero pasivas y sumisas. Comúnmente tratan de mostrarse físicamente atractivas y femeninas, y tienen interés en temas académicos, estéticos, u hogareños. Las mujeres con educación terciaria suelen puntuar entre 40 y 50 en esta escala.
Muy bajo (<35)
Alta preocupación por aparentar roles masculinos tradicionales, incluso con exhibiciones narcisistas de fuerza y resistencia. Tal preocupación suele tener una base de inseguridad sobre sí mismo. En jóvenes, puede estar asociado con conductas delictivas o problemas de disciplina.
En mujeres, refleja constricción emocional. Parecen necesitar reasegurarse a sí mismas de su propia valía sobrecargándose de responsabilidades. Si no se sienten valoradas, tienden a generar lástima y culpa en los otros. Puede ir acompañado de insatisfacción sexual, dolores de cabeza o espalda, y sensación de que no pueden disfrutar de las cosas por tener que cumplir con muchos deberes.

Escala 6 - Pa (Paranoia)

Evalúa pensamientos y actitudes paranoides tanto crónicos como agudos, incluyendo hipersensibilidad, negación rígida del cinismo, proyección, externalización, e hipervigilancia. Puede implicar procesos psicóticos. Esta escala puede descomponerse en las tres principales dimensiones que explora: ideas persecutorias o referenciales, hipersensibilidad al mal trato, y preocupación por juzgar éticamente la conducta de los otros.

Rangos de puntuación
Alto (>65)
Representa a alguien suspicaz, enojadizo, resentido rumiante, y con tendencia a sobreinterpretar las situaciones autorreferencialmente. No reporta malestar emocional. Muy frecuentemente sus conductas son claramente paranoides, con ideas de referencia, proyección como principal mecanismo, examen de la realidad muy tendencioso, y hasta delirios de persecución o grandiosidad. Algunos casos, si tienen altas puntuaciones en las escalas ***K*** y ***Es***, pueden funcionar bien pero demostrando sensibilidad paranoide con celos injustificados y hasta episodios francamente paranoides, sin caer en la psicosis. El pronóstico es reservado por su bajo o nulo malestar emocional y su incredulidad sobre tener problemas psicológicos. La alianza terapéutica es muy difícil de establecer por su suspicacia y distancia interpersonal. Se recomiendan tratamientos breves conductuales focalizados que, de ser exitosos, pueden dar lugar a un tratamiento prolongado para trabajar sobre los aspectos más caracterológicos.
Medio (55-65)
Refleja sensibilidad, sentimientos fáciles de herir, y propensión a tomar las cosas a título personal y a malinterpretar las intenciones de los otros. Todavía en este rango hay un uso de defensas paranoides con proyección, negación, formación reactiva, y celos irracionales reactivos al estrés. Suelen sentirse injustamente tratados por otros. Puede haber episodios paranoides, sin caer en la psicosis. Su comportamiento puede aparentar normal en situaciones inocuas, pero bajo presión pueden tener problemas para reconocer y modular su expresión del enojo. En sus relaciones interpersonales son susceptibles, desconfiados, y proclives a juzgar al otro. Se sienten controlados por las expectativas de los demás y muestran un resentimiento racionalizado.
Muy bajo (<35)

Este rango se da en dos tipos de sujetos: (a) los que carecen de sensibilidad hacia los otros, y (b) los que realmente son tan suspicaces y astutos que evitaron contestar significativamente los ítems de esta escala. Los que corresponden al segundo caso reciben la misma interpretación que los que obtienen puntaje alto, pero con el agregado de mostrar bastante inteligencia. La mayor parte de los que caen en este rango corresponden al primer caso, y suelen ser convencionales, insensibles, ingenuos y confiados.

Escala 7 - Pt (Psicastenia)

Es básicamente una escala de ansiedad que representa cavilaciones y preocupaciones, y conductas varias destinadas a reducir el malestar. También tiene relación con el insight terapéutico, lo cual implica generalmente buen pronóstico.

Rangos de puntuación
Alto (>65)
Aparece en personas con tensión y ansiedad. Son introspectivos, pero con una penosa sensación de inseguridad, culpa, inadecuación e inferioridad. Sufren de pobre autoconfianza, indecisión, problemas de concentración, y aprensión. A mayor elevación, mayor tendencia a la autocrítica, rigidez, perfeccionismo, y hasta características obsesivas o compulsivas. El pronóstico es bueno para tratamientos a largo plazo, lo cual es necesario por tratarse de patrones de personalidad muy estables. Es improbable que requiera internación, aunque sí puede requerir psicofármacos (más en los casos con puntuación mayor a 90) por el nivel de interferencia que suelen traer sus síntomas sobre el trabajo y otras áreas de su vida. Las terapias de entrenamiento en habilidades sociales y asertividad son de mucha ayuda para entablar la alianza terapéutica.
Medio (55-65)
Si la escala ***K*** no está elevada, implica propensión a tomarse la vida seriamente, a preocuparse, y con episodios de ansiedad ocasionales, especialmente ante muchos estresores. En algunos casos puede señalar rasgos OC pero no desorganizantes, o miedos y fobias. En casos con la escala ***K*** elevada, implica que las ansiedades y fobias son egosintónicas y acopladas crónicamente a la estructura.
Bajo (35-45)
Implica que el sujeto está relajado, cómodo y sin malestares. La mayoría tienen buena autoconfianza, son adaptables y eficientes, aunque den la imagen de ser poco motivados.
Muy bajo (<35)
Sugiere una negación de las molestias o ansiedades mínimas que pueden darse normalmente en los momentos frustrantes cotidianos.

Escala 8 - Sc (Esquizofrenia)

Es una de las escalas más graves. Predice baja autoestima, indecisión y confusión mental, dificultades de comunicación y de expresión del enojo, y problemas para las relaciones interpersonales cercanas. A niveles muy altos suele reflejar reacciones agudas al estrés o crisis severas de identidad, más que un genuino trastorno del pensamiento. Esto último, como en el caso de la esquizofrenia, es más detectable dentro del rango 70-85.

Rangos de puntuación
Extremo (>85)
Si bien es posible la presencia de un episodio psicótico, típicamente este puntaje contraindica esquizofrenia. El cliente está bajo un estrés agudo y severo o padeciendo una crisis de identidad. Requiere intervenciones de contención urgentes.
Muy alto (75-85)
El sujeto se siente alienado y con dificultad para pensar con claridad. Tiene pensamientos y conductas no convencionales, incluso potencialmente desviados socialmente, y es resistente a involucrarse afectivamente con otros. Tiene preocupaciones sobre su identidad y siente que no pertenece a esta sociedad. Se siente herido y no amado, y carente de la humanidad necesaria para relacionarse íntimamente con otros. Sufre dificultades para pensar con claridad y coherencia, con pensamientos intrusivos o desorganizados y preocupaciones sobre sí mismo. Si la escala ***K*** está muy elevada, el cliente puede tener muchas áreas de funcionamiento conservadas, excepto los

problemas de autoimagen y relaciones personales íntimas. El pronóstico es reservado. En general las elevaciones de esta escala contraindican terapias de insight, y se recomiendan tratamientos estructurantes, organizadores, teniendo presente la actitud poco favorable del paciente para una alianza terapéutica. Los modelos de tratamiento paternalistas, o de construcción de la autoestima y de reestructuración cognitiva también son efectivos.
Alto (65-75)
Este rango sugiere distancia e incomodidad interpersonal, pensamiento centrado en temas abstractos y no convencional, e insatisfacción consigo mismo, con los demás y/o con los valores sociales. Si la escala ***K*** está muy elevada, puede haber signos sutiles de autoimagen negativa, pero sin perturbaciones del pensamiento.
Medio (55-65)
Revela un pensamiento diferente a lo común, con creatividad, o también procesos de tipo esquizoide. Tendencia a evitar la realidad por medio de la fantasía.
Normal (45-55)
Indica preocupaciones típicas sobre sí mismo y sobre los otros. Algunos esquizofrénicos crónicos adaptados pueden puntuar en este rango.
Bajo a Muy bajo (<45)
Señala convencionalidad, conservadurismo, realismo, y tendencia a temas concretos. Responsabilidad, conformismo, prudencia. Escasa imaginación y dificultad para aceptar otros puntos de vista.

Escala 9 - Ma (Hipomanía)

Esta escala representa energía tanto física como psíquica, excitabilidad emocional, y expansividad. Quienes puntúan alto muestran gran resistencia para mantenerse por mucho tiempo haciendo esfuerzos y actividades, que pueden ser desorganizadas si el puntaje es demasiado alto. Se observa euforia especialmente al estar activo, pero cuando se frustran o constriñen sus actividades aparece la sensación de estar deprimido. En algunos casos, la energía se manifiesta como tensión, egocentrismo, e irritabilidad.

Rangos de puntuación
Alto (>65)
Es característico de cuadros maníacos de leves a moderados. Pueden mostrar verborragia, grandiosidad, y dificultades para inhibir o controlar sus pensamientos y consecuentes acciones. Puede implicar un intento de protegerse de una depresión incipiente. Tienden a ser excitables, super productivos logorreicos, con un humor hostil en tono bromista, y propensos a comprometerse en demasiadas cosas. El sueño puede verse reducido en horas y puede haber consumo de sustancias (chequear con la escala ***MAC-R***). El pronóstico es generalmente malo por su escaso malestar emocional. Puede ser necesario medicación si las características maníacas son clínicamente evidentes. Los tratamientos psicológicos deben ser breves y focalizados.
Medio (60-65)
Sugiere a alguien enérgico, sociable, visto como feliz y eficiente. No es raro entre gente joven y activa. Muestra concentración en el logro para ganar reconocimiento y tiende a ser independiente en pensamiento y acción. Reacciona mal ante restricciones a su actividad.
Normal (45-60)
Nivel normal de actividad.
Bajo (35-45)
Bajo nivel de energía, falta de impulso, apatía y fatiga. Refleja pobre autoconfianza y metas limitadas.
Muy bajo (<35)
Representa estados depresivos, independientemente del nivel de la escala ***2***, especialmente en sujetos de menos de 45 años. Este rango de puntuación también aparece en gente de edad avanzada, posiblemente indicando parte del proceso normal de envejecimiento.

Escala 0 - Si (Introversión social)

Evalúa la dimensión introversión – extroversión de la personalidad, y cuanto más alto el puntaje, más introvertido es el cliente. En este último caso, hay incomodidad y retraimiento social, preferencia por actividades solitarias o pocos vínculos, y limitadas habilidades sociales. En el caso

opuesto, el sujeto es gregario, sociable, y busca relacionarse con otros. Las elevaciones en esta escala tienden a reducir la probabilidad de acting out que pudieran sugerir elevaciones en otras escalas, pero incrementa las rumiaciones sugeridas por escalas como la ***2***, la ***7***, y la ***8***.

Rangos de puntuación
Alto (>65)
Si es la única escala elevada, señala la preferencia por estar solo, timidez, incomodidad social, introversión, pobre autoconfianza, inseguridad, y sumisión. El malestar afectivo es leve y generalmente se siente feliz, a pesar de reportar algún grado de disforia. Es alguien fácil de asustar y puede padecer fobias. No aparecen problemas en el funcionamiento cognitivo, pero sí tendencias a rumiar y dificultad para decidir. Si el puntaje es >75 indica ausencia de contención social, dificultad seria para establecer relaciones cercanas y distancia interpersonal hasta el punto de la posible esquizoidía.
Medio (55-65)
Estilo temperamental de ser auto-contenido, autónomo, y fácilmente adaptable a actividades solitarias. Si bien no tiene problemas de habilidades sociales, prefiere involucrarse con poca gente.
Normal (45-55)
Tendencias equilibradas entre comportamientos sociales extravertidos e introvertidos.
Bajo a Muy bajo (<45)
Extroversión social, gregarismo, versatilidad y apertura para las relaciones. Suele participar en muchas actividades sociales. Puede tener dificultades para demorar las gratificaciones y para controlarse emocionalmente. Si el puntaje es extremadamente bajo (<35) indica vínculos demasiado superficiales y carentes de real intimidad. Esto último se reconfirma si además se eleva la escala ***3*** o la ***4***.

7. – SUBESCALAS DE LAS ESCALAS BÁSICAS

Algunas de las escalas básicas han sido descompuestas en subescalas que llevan componentes interpretativos por el contenido de sus ítems y son muy útiles para refinar la interpretación de su escala madre. Se recomienda generalmente interpretarlas cuando la escala madre también esté elevada. A continuación se exponen las interpretaciones básicas de puntuaciones altas (T > 65) en cada una de ellas.

Subescalas

2 – Depresión (Harris-Lingoes)

D1 - Depresión subjetiva
Infelicidad, melancolía, depresión, falta de energía, dificultad para concentrarse, sentimientos de inferioridad, sensibilidad a la crítica.

D2 - Lentitud psicomotora
Lentitud, inercia, falta de energía, negación de impulsos agresivos.

D3 - Malfuncionamiento físico
Quejas somáticas, preocupación por el funcionamiento corporal.

D4 - Torpeza mental
Tensión, pobre autoconfianza, dificultades de concentración y de memoria.

D5 - Preocupación
Marcada tendencia a cavilar y lamentarse excesivamente.

3 – Histeria (Harris-Lingoes)

Hy1 - Negación de ansiedad social
Extroversión, comodidad interpersonal, y comunicabilidad.

Hy2 - Necesidad de Afecto
Ingenuidad y confianza excesiva en los demás; necesidad de atención y afecto.

Hy3 - Decaimiento / malestar
Debilidad física, fatiga, cansancio, infelicidad y tristeza.

Hy4 - Quejas somáticas
Quejas diversas sobre dolores (de cabeza, del pecho), debilidad física, náuseas, problemas gástricos. Mecanismos de represión y conversión. Ausencia de actitudes hostiles hacia otros.

Hy5 - Inhibición de la agresión
Negación de impulsos hostiles o agresivos.

4 – Desviación psicopática (Harris-Lingoes)

Pd1 - Desavenencias familiares
Hogar y familia displacenteros, carentes de amor o apoyo. Sensación de que los allegados son hostiles y no le permiten ser independiente.

Pd2 - Problemas con la autoridad
Resentimiento y oposición hacia las normas sociales. Reconocimiento de antecedentes de indisciplina escolar y/o legal.

Pd3 - Imperturbabilidad social
Facilidad para las relaciones interpersonales, pero con carga agresiva, caracterizada por cinismo, y con tendencia a intimidar, explotar y manipular a otros.

Pd4 - Alienación Social
Resentimiento de tipo paranoide. Sensación de aislamiento y extrañeza. Se siente incomprendido y culpa a otros de su malestar.

Pd5 - Auto-alienación
Esta subescala representa el componente anhedónico de la escala ***4***. Infelicidad y disconformidad consigo mismo. Culpa y remordimiento.

6 – Paranoia (Harris-Lingoes)

Pa1 - Ideas Persecutorias
Percepción del mundo como hostil y amenazador. Se siente maltratado por la vida. En pacientes graves puede implicar delirios de persecución.

Pa2 - Sufrimiento
Alta sensibilidad, tensión y sensación de ser incomprendido.

Pa3 - Ingenuidad
Optimismo e ingenuidad con respecto a los demás. No reconocimiento de hostilidad e impulsos negativos.

8 – Esquizofrenia (Harris-Lingoes)

Sc1 - Alienación Social
Sentimientos de soledad y vacío, y sensación de ser incomprendido. Vida familiar carente de amor y apoyo.

Sc2 - Alienación emocional
Desesperanza, apatía, temores. Retraimiento emocional con respecto a la vida. Necesidades sádicas o masoquistas.

Sc3 - Falta de control del yo, Cognitivo
Problemas cognitivos en concentración, memoria, atención, y presencia de pensamientos intrusivos y extraños. Implica mayor malestar por el déficit cognitivo que el de la subescala ***D4***. Su puntaje debe superar al de la escala de contenido ***HEA*** para asegurarnos de que esta interpretación es específica. De lo contrario, los problemas cognitivos pueden ser parte de las preocupaciones de la salud del cliente.

Sc4 - Falta de control del yo, Emotivo (motivacional)
Tensión, aburrimiento, falta de disfrute. Refugio en fantasías. Carencia de capacidad y motivación para actuar con propósito.

Sc5 - Falta de control inhibitorio del yo
Sentimiento de pérdida del control de las emociones e impulsos. Posible inquietud, hiperactividad, y sensación de irrealidad.

Sc6 - Disociación sensomotora (antes: Experiencias sensoriales bizarras)
Sensación de que el cuerpo ha cambiado extrañamente, alucinaciones, disociación y despersonalización, pensamiento de contenido inusual e ideas de influencia.

9 – Hipomanía (Harris-Lingoes)

Ma1 – Amoralidad
Percibe a los otros como egoístas, deshonestos y oportunistas, lo que le da la justificación para actuar de ese mismo modo. Manipulación abusiva de los vínculos.

Ma2 - Aceleración psicomotora
Aceleración del habla, del pensamiento y de la actividad motriz. Excitación e inquietud injustificadas.

Ma3 – Imperturbabilidad
Comodidad, seguridad y negación de ansiedad social. No se siente molestado por distracciones ni tensiones, ni le importan las opiniones ajenas.

Ma4 - Megalomanía
Exagerada sobreestimación de las propias habilidades y virtudes. Resentimiento hacia la falta de reconocimiento de los otros para con su importancia.

0 – Introversión social (subescalas Si)

Si1 - Timidez / Autoconsciencia
Timidez y facilidad para sentir vergüenza. Incomodidad en situaciones sociales nuevas y evitación del contacto con gente.

Si2 - Evitación social
Incomodidad y evitación de interacciones en grupos sociales de todo tipo, y mantenimiento activo de la distancia interpersonal.

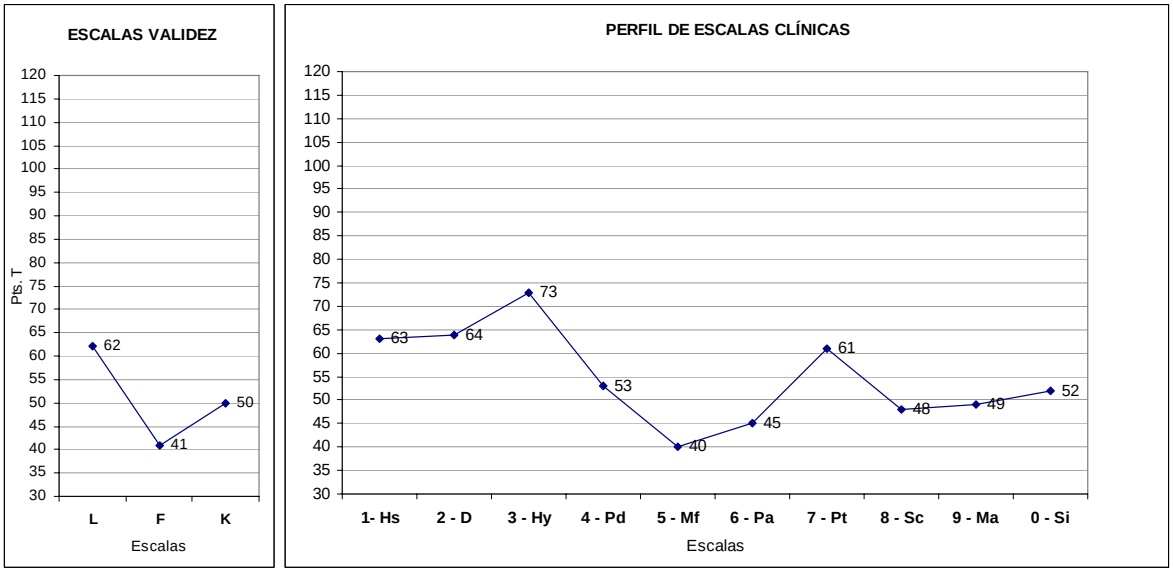
Si 3 - Alienación de sí mismo y de otros
Baja autoestima y pobre autoconfianza. Duda de su propio juicio. Ansiedad, miedos, e indecisiones. Poco interés en las cosas.

8. – CÓDIGOS DE PERFILES TÍPICOS

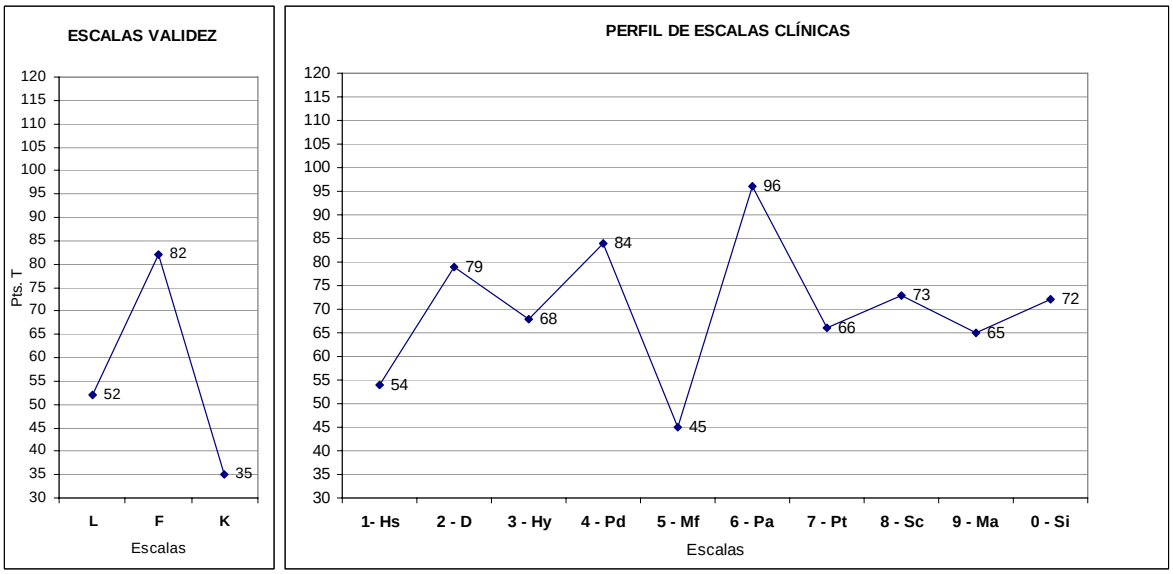
Determinación de la presencia de un Perfil

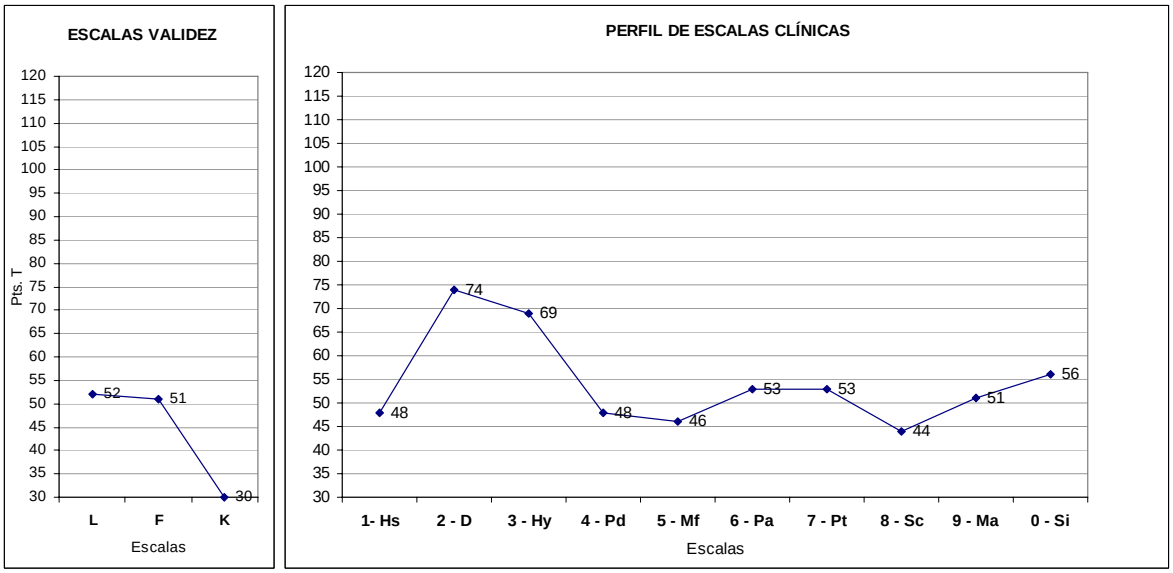
Si una sola escala clínica (de la ***1*** a la ***0***) alcanza o supera los 65 puntos T y se eleva por encima de las otras con diez o más puntos T, se interpreta lo ya indicado para esa escala como el patrón fundamental de funcionamiento de ese sujeto. No obstante, es muy frecuente que se presenten perfiles de dos o tres escalas combinadas, esto es, que existan dos o tres escalas con una elevación igual o mayor a 65 puntos T. En esos casos se identifica al perfil por los números correspondientes a las dos escalas más altas. Así, si las dos escalas más altas con puntuación T igual o mayor a 65 son la ***2*** y la ***8***, entonces el perfil es ***28/82*** (el orden va en función de la elevación, anotándose primero la escala más alta de las dos). La interpretación de tales protocolos está condicionada por la presencia conjunta de características de cada escala. Por ejemplo, si bien la escala ***2*** señala una vivencia depresiva y la escala ***8*** indica problemas cognitivos e interpersonales importantes, la interpretación de un perfil con ambas escalas elevadas se complejiza y lleva a considerar que la depresión es más grave y que varios síntomas psicóticos pueden estar presentes. Existen investigaciones que avalan interpretaciones para perfiles de dos, tres y hasta de cuatro escalas (estos últimos son más raros), pero no de más de cuatro. Por lo tanto, en casos de múltiples elevaciones que no estén contempladas entre los perfiles típicos, se recomienda hacer una cuidadosa integración de las diversas interpretaciones conocidas para cada escala.
En cualquier caso, un perfil se considera ***bien definido*** si la o las escalas más elevadas están a una distancia de ***10 o más puntos T*** de la escala más cercana. En esos casos, la interpretación se basa en un patrón de comportamiento muy estable y es muy segura. Si la distancia está ***entre 5 y 9 puntos T***, el perfil es ***moderadamente definido*** y la interpretación del perfil es probablemente estable y segura. Si las escalas más elevadas están a ***menos de 5 puntos T*** de las otras escalas, el perfil ***no es bien definido*** y su interpretación es menos probable y debe ser cautelosa por la potencial inestabilidad temporal del resultado.

Por ejemplo, el siguiente perfil es identificado como código 3, dado que sólo presenta esa escala elevada significativamente:



En cambio, los dos perfiles que se ilustran abajo tienen más de una escala elevada significativamente. El primero corresponde a un código 64 (escala 6 más elevada, seguida por la escala 4); el segundo a un código 23 (escala 2 más alta, seguida por la escala 3).





Interpretación de Perfiles Típicos de dos o más Escalas Clínicas

Perfil dentro de límites normales (DLN)

Se da cuando todas las escalas clínicas básicas tienen puntuaciones T menores a 65. Es por lejos el más frecuente de encontrar en población general y en el contexto de selección de personal. Incluso también lo es en servicios de salud mental (aproximadamente un 31% de los pacientes derivados a esos servicios pueden dar tal perfil), aunque en este contexto es indicador de pobre pronóstico. El paciente se autodescribe como feliz y saludable. No reporta malestar afectivo y parece haberse ajustado a todos sus problemas y síntomas, que serían crónicos y posiblemente egosintónicos. Si se trata de una evaluación en ámbito clínico, implica baja motivación para iniciar un tratamiento y hasta puede esconder una seria patología. Lo recomendable es matizar esta interpretación con lo que indique cada escala en sí misma con su rango de puntuación, y complementarlo con las escalas adicionales.

Perfiles de dos escalas

Nota: En general, si una de las escalas es un poco más alta que la otra, el orden no afecta la interpretación, a menos que las investigaciones hayan mostrado lo contrario. En esos últimos casos, se hará mención de la salvedad.

12/21

Afectividad

Tensión, ansiedad y disforia. Síntomas físicos que provienen de la ansiedad. Se frustra e irrita fácilmente. No suele reconocer su depresión a pesar de lo evidente que sea. Extrema sensibilidad a las críticas. Se siente incapaz de triunfar en la vida.

Cognición:

Problemas de concentración. Pensamiento concreto y focalizado en sus molestias físicas. Siente que su juicio se ha deteriorado. Pobre insight y tendencia a negar cualquier causa psicológica para sus síntomas.

Relaciones interpersonales:

Introversión y timidez.

Otros aspectos:

Preocupaciones sobre su salud física. Reporta fatiga, dolores y síntomas físicos y neurológicos. Los síntomas somáticos son poco específicos y suelen ser gastrointestinales y dolores abdominales o de espalda. Tiende a exagerar la gravedad de esos síntomas. Duerme mal y se siente con poca energía. Potencial abuso de automedicación. También hay que chequear la presencia de ideación suicida.

Pronóstico:

El pronóstico es malo en cuanto a tratamientos psicológicos por su pobre insight. Se recomienda un tratamiento médico conservador para aliviar sus síntomas. De encarar una psicoterapia, tendrá que ser breve y focalizada en un alivio de los síntomas.

13/31

Nota: se trata de un perfil muy habitual en entornos clínicos y de población general. Si ambas escalas están diez o más puntos T por encima de la escala 2, se dibuja la clásica "V conversiva", que refleja una tendencia a somatizar como respuesta al estrés y para evitar enfrentar los conflictos psicológicos. A mayor distancia con respecto a la escala 2, peor pronóstico por lo rígido de las defensas.

Afectividad

El malestar afectivo es leve y caracterizado por tensión y a veces disforia. Frecuentemente se preocupa por algo. Estos malestares no son expresados abiertamente. Siente fatiga e ineficiencia. Aunque le gustan muchas cosas, percibe que la vida le fue injusta.

Cognición:

Este perfil suele contraindicar psicosis, aún cuando los síntomas puedan parecer bizarros. Pensamiento concreto y focalizado en sus molestias físicas. Memoria, concentración, juicio, y toma de decisiones adecuadamente conservados. Siente confianza en sí mismo y en los otros. Defiende y hace saber sus opiniones.

Relaciones interpersonales:

Es posible que otros perciban en sus quejas somáticas un modo de manipulación pasivo-agresiva. Extroversión y sociabilidad. Estilo convencional y respetuoso de las normas.

Otros aspectos:

Gran preocupación en torno a la salud física, que parece vulnerada. Reporta numerosos síntomas físicos y dolencias: digestivos, respiratorios, dolores varios en el cuerpo, fiebre, y problemas de coordinación. Se fatiga fácilmente. Problemas de sueño. Potencial abuso de la medicación.

Pronóstico:

El pronóstico es malo en cuanto a tratamientos psicológicos por su pobre insight y escasa disposición hacia lo psicológico. Se recomienda un tratamiento médico conservador para aliviar sus síntomas. De encarar una psicoterapia, tendrá que ser breve y focalizada en un alivio de los síntomas.

14/41

Afectividad

Mínimo malestar emocional. Ánimo frecuentemente positivo y calmo.

Cognición:

Memoria, concentración, juicio, y toma de decisiones adecuadamente conservados. Siente confianza en sí mismo. Cree que los demás son egoístas.

Relaciones interpersonales:
Se autopercibe con extroversión y sociabilidad, aunque los otros lo perciben como alguien socialmente inhábil. Conflictos habituales con su familia de origen.
Otros aspectos:
Quejas somáticas específicas y dolores en general. Potencial de consumo de sustancias y de problemas con la ley.
Pronóstico:
El pronóstico es malo en cuanto a tratamientos psicológicos por lo crónico de su sintomatología y escasa motivación. De encarar una psicoterapia, tendrá que ser breve y focalizada en el motivo de consulta.

15/51
Afectividad
Ausencia de malestar significativo. La respuesta al estrés es a través de síntomas físicos, que pueden ir acompañados de irritabilidad.
Cognición:
Memoria, concentración, juicio, y toma de decisiones adecuadamente conservados. Siente confianza en sí mismo. Se aferra a opiniones y convicciones personales inflexibles y siente que es difícil convencer a los demás de la verdad. Muy convencional.
Relaciones interpersonales:
Extroversión. Siente que se lleva bien fácilmente con los otros y que podría ser un líder. Le despreocupa lo que otros piensen. Usa los síntomas físicos como modo de evadir responsabilidades.
Otros aspectos:
Dolencias físicas y problemas de sueño. Improbable abuso de sustancias o de ideación suicida.
Pronóstico:
Pronóstico reservado, a causa de su bajo malestar y escasa motivación para un cambio. De encarar una psicoterapia, tendrá que ser breve y focalizada en el motivo de consulta.

16/61
Afectividad
Leve malestar emocional caracterizado por cavilaciones, rencor, negativismo, y anhedonia. Irritabilidad y tozudez, a veces abiertamente expresadas. Niega su tendencia al enojo y lo justifica por la conducta de otros. Alta sensibilidad emocional. Derrotismo.
Cognición:
Memoria y juicio aparentemente conservados. No obstante, algunos síntomas pueden ser psicóticos o reflejar una condición clínica caracterológica de larga data, lo cual debe ser revisado en su historia. Refiere pensamientos malos de los que prefiere no hablar, pero no cree tener problemas mentales. Elevada sensibilidad a las críticas y pobre insight.
Relaciones interpersonales:
Introversión y alienación social. Conflictos interpersonales y externalización de culpas. Cree que podría ser líder pero que los demás lo malinterpretan.
Otros aspectos:
Síntomas físicos y cansancio crónico. Problemas de sueño. El abuso de sustancias y la ideación suicida no se descartan y deben ser revisados.
Pronóstico:
El pronóstico generalmente es malo, por la cronicidad y lo caracterológico de sus problemas. También es difícil descentrarle de las quejas somáticas y hacerle ver sus dificultades psicológicas. Por su irritabilidad y negativismo es difícil que establezca una alianza terapéutica. De encarar una psicoterapia, tendrá que ser breve y focalizada en el motivo de consulta. Terapia cognitivo-conductual puede ser útil para su enojo, disforia y anhedonia.

17/71
Afectividad
Moderado malestar emocional caracterizado por aprensión generalizada, preocupaciones, y ansiedad. Rumiaciones crónicas. Amplia sintomatología física relacionada con tensión y ansiedad, dolor e incomodidad generalizada. Inseguridad, inhibiciones, culpa y posiblemente estados depresivos. Enojo contenido.

Cognición:
Problemas de concentración y memoria. Pensamientos repetitivos y miedo a volverse loco. Intelectualización.
Relaciones interpersonales:
Introversión y timidez. Inseguridad y escasa iniciativa en los encuentros sociales.
Otros aspectos:
Quejas somáticas, fatiga, y dolores en general. Problemas de sueño. Incremento de los síntomas somáticos en respuesta al estrés. Puede abusar de fármacos tranquilizantes. Es improbable que tenga problemas de conducta.
Pronóstico:
Pronóstico malo por lo caracterológico y estable de sus síntomas, así como su tendencia a focalizar en lo físico más que en lo psicológico. Puede requerir medicación ansiolítica. La terapia cognitivo-conductual para reducir la ansiedad puede ser la opción psicoterápica en su caso.

18/81
Afectividad
Moderado malestar emocional caracterizado por disforia, intranquilidad, y anhedonia. Se siente incapaz de triunfar en la vida. Aprensión y miedos. Irritabilidad y tozudez.
Cognición:
Problemas de concentración y memoria. Fácil distractibilidad y frecuentes confusiones. Pobre autoconfianza. Juicio deteriorado y pensamientos potencialmente bizarros y delirantes. Siente que otros lo miran y hablan de él. Pensamientos intrusivos de orden sexual. Síntomas físicos posiblemente bizarros. deber revisarse la historia clínica para explorar un posible trastorno psicótico.
Relaciones interpersonales:
Introversión y alienación social. Sin conflictos familiares. Desconfianza hacia los otros. Es visto por los demás como alguien raro o bizarro.
Otros aspectos:
Síntomas físicos, neurológicos, y dolores, que pueden ser bizarros. Mal manejo del estrés. Debilidad crónica. Sueño perturbado. Potencial abuso de sustancias y de ideación suicida a evaluar clínicamente.
Pronóstico:
El pronóstico generalmente es malo, por lo caracterológico de sus problemas. También es difícil descentrarle de las quejas somáticas y hacerle ver sus dificultades psicológicas. Por su carácter es difícil que establezca una alianza terapéutica. Puede requerir medicación para su ansiedad y disforia. De encarar una psicoterapia, tendrá que ser breve y focalizada en el motivo de consulta.

19/91
Afectividad
Malestar emocional menor. Se siente generalmente bien, con autoconfianza y le despreocupa lo que otros piensen. Tozudez y oposicionismo. Se siente menos temeroso que la mayoría de la gente.
Cognición:
Memoria y concentración conservados. Cree que los demás son egoístas.
Relaciones interpersonales:
Extroversión y sociabilidad. Disfruta de las reuniones y siente que podría ser líder. No obstante, su conducta se presta a malos entendidos.
Otros aspectos:
Síntomas somáticos y neurológicos que justifican un examen clínico. Potencial abuso de sustancias.
Pronóstico:
Pronóstico reservado. Sus problemas son caracterológicos y no le movilizan como para una demanda de tratamiento. De encarar una psicoterapia, tendrá que ser breve y focalizada en el motivo de consulta.

10/01
Afectividad
Moderado malestar emocional caracterizado por disforia y ansiedad. Se avergüenza con facilidad.

Cognición:
Concentración, memoria, y juicio conservados. Tendencia moderada a las rumiaciones. Falta de asertividad.
Relaciones interpersonales:
Introversión, retraimiento, y timidez. Alta convencionalidad.
Otros aspectos:
Síntomas gastrointestinales y neurológicos, y fatiga frecuente, todo lo cual merece ser examinado médicamente. Es improbable que haya abuso de sustancias o ideación suicida.
Pronóstico:
Pronóstico reservado por el bajo nivel de movilización y lo caracterológico del cuadro. Se recomienda tratamiento breve focalizado.

23/32
Afectividad
Malestar emocional de leve a moderado caracterizado por disforia, preocupación, y anhedonia. Frecuentemente se preocupa por algo. Sentimientos de inadecuación e inseguridad. Alta sensibilidad a la crítica. Dificultad para expresar sentimientos. Sobrecontrol y temor a descontrolarse. Es probable que experimente aumentos de depresión, fatiga y síntomas físicos en respuesta al estrés. No expresa el enojo abiertamente.
Cognición:
Problemas de memoria y concentración. Baja autoestima y pobre autoconfianza. Su razonamiento está deteriorado. Percibe que a veces se puede derrumbar. No analiza las razones de su conducta ni la de otros.
Relaciones interpersonales:
Introversión y poco interés en reuniones. Sensación de inadecuación social y de desamparo. Inmadurez social y dependencia. Sin conflictos familiares evidentes.
Otros aspectos:
Tiene varias quejas somáticas y problemas de sueño, y se cansa fácilmente. Su débil salud física interfiere con su trabajo. Puede presentar disfunciones sexuales a causa de exceso de controles. Reporta varios síntomas físicos y neurológicos que merecen un examen clínico. Su comportamiento es muy convencional y es improbable la existencia de desórdenes de conducta. Es improbable que abuse de sustancias. Se recomienda evaluar la presencia de ideación suicida.
Pronóstico:
Pronóstico malo, por el escaso insight y su pesimismo para ver un cambio en su vida, y por la habituación sobre sus síntomas crónicos. Se concentra más en sus dolencias somáticas. Lo más efectivo es un tratamiento conductual breve focalizado en los motivos de consulta, que podría ayudar a motivarle para un tratamiento prolongado.

24/42
Nota: La interpretación de este perfil debe evaluarse en función del contexto situacional. La elevación de la escala 2 puede ser reactiva a un estresor externo (como ser, un encarcelamiento) o bien a un malestar interno. Si es reactiva a algo externo, indicará la frustración de estar restringido y será aliviada una vez desaparecido el factor de frustración. Esos casos están mejor representados por la interpretación de la escala 4 aislada, y son proclives al acting out. En los otros casos, la elevación de la escala 2 responde a una depresión crónica sin evidencia de acting out. Van a mostrar hostilidad y rencor y conflictos en el hogar. También son personas inmaduras, dependientes y egocéntricas, externalizadores de culpas.
Afectividad
Moderado malestar afectivo caracterizado por anhedonia, disforia, rencor, e intranquilidad. Este humor emerge ante problemas externos. Puede expresar culpa y prometer mejorar su comportamiento, pero no sinceramente. Irritabilidad y tozudez. Arrepentimiento con respecto al pasado y sensación de infelicidad.
Cognición:
Memoria conservada pero razonamiento deteriorado. Pobre autoconfianza. Cree que la gente es egoísta y culpa a otros de sus problemas.
Relaciones interpersonales:
Leve introversión. Extrañeza y malestar con respecto a su familia.
Otros aspectos:

Salud física débil. Sueño perturbado por la ideación. Potencialidad de abuso de sustancias y problemas con la ley. Posibilidad de ideación suicida que debe ser examinada por el riesgo de abuso de sustancias.
Pronóstico:
El pronóstico es generalmente malo para un tratamiento tradicional individual a menos que el desorden afectivo sea el diagnóstico principal. En ese caso, sí conviene una terapia cognitivo-conductual focalizada en el funcionamiento cognitivo depresivo. La medicación antidepresiva también debe ser considerada. Si el diagnóstico principal no es depresión, la terapia de grupo con pacientes de cuadro similar puede ser mejor opción. Se recomienda involucrar cónyuges o familiares en el tratamiento para mayor efecto terapéutico.

25/52
Afectividad
Leve malestar emocional caracterizado por disforia. Tendencia depresiva crónica. Sentimientos de inutilidad y alta sensibilidad a las críticas.
Cognición:
Pobre autoconfianza y preocupaciones sexuales. Cree que la gente es egoísta.
Relaciones interpersonales:
Pasividad, dependencia, timidez, e introversión, aunque no es inhábil socialmente. Muy convencional y baja probabilidad de problemas de conducta.
Otros aspectos:
Buena salud física. Sueño interrumpido.
Pronóstico:
Pronóstico relativamente favorable. Buena respuesta a terapias breves focalizadas en la disforia, pero poca motivación para un tratamiento largo.

26/62
Afectividad
Malestar afectivo moderado caracterizado por cavilaciones, disforia, enojo frecuente consigo mismo y con los demás, y anhedonia. La mayor parte del tiempo se siente deprimido y tiene preocupaciones. Hostilidad abierta. Alta sensibilidad emocional general, y en especial es fácil de herir. Le cuesta olvidar las desilusiones. Se siente menos feliz que los demás, con poca capacidad de éxito, y tiene poca esperanza en el futuro.
Cognición:
Problemas de concentración y juicio deteriorado. Pobre autoconfianza. Hipersensibilidad hacia las críticas y propensión a malos entendidos. Siente que puede perder el control de su mente. Síntomas varios potencialmente psicóticos, que deberían ser revisados con la historia clínica y entrevistas.
Relaciones interpersonales:
Introversión, tendencia al aislamiento y timidez. Sentimientos de soledad aún en compañía de otros. Anticipa en los otros una actitud de rechazo hacia él y sospecha que lo critican. Sensación de no ser comprendido.
Otros aspectos:
Se preocupa por su salud pero no reporta síntomas somáticos específicos. Cansancio frecuente y sueño perturbado por la ideación. Potencial abuso de sustancias y/o ideación suicida.
Pronóstico:
Pronóstico reservado por su patrón crónico de funcionamiento. Su enojo y rencor dificultan la alianza terapéutica. Lo más efectivo es un tratamiento conductual breve focalizado en los motivos de consulta. Terapia cognitivo-conductual focalizada en su enojo y disforia puede ser útil. Puede requerir psicofármacos antidepresivos, especialmente si la escala 2 es muy alta.

27/72
Nota: es un perfil muy común en entornos clínicos. Encierra el riesgo de ideación suicida. Conviene revisar las respuestas a los ítems 150, 303, 506, 520, 524, y 530. Si la escala ***7*** está por encima de los 85 puntos T y es más alta que la escala ***2***, el paciente está tan alterado y

preocupado que probablemente requiera medicación o una intervención situacional urgente, antes de iniciar tratamiento.
Cognición:
Obsesiones y tendencia a centrarse en las propias deficiencias. Problemas de concentración, de razonamiento, y de memoria. Derrotismo, culpa, falta de iniciativa, indecisión, y desesperanza. Su inercia y falta de impulso son reflejo de su cognición depresiva.
Relaciones interpersonales:
Introversión y timidez. Vergüenza e incomodidad al estar con gente. Sensación de extrañeza con respecto a sí y a los demás. Pasividad y dependencia.
Otros aspectos:
Síntomas cardiovasculares producto de la tensión y ansiedad, insomnio, e hiporexia. Potencial suicida. Potencial abuso de sustancias secundario a una depresión encubierta.
Pronóstico:
Generalmente el pronóstico es muy bueno. El paciente acepta su responsabilidad en su conducta y sus síntomas. Tiene potencial introspectivo para aprovechar en cualquier tipo de terapia. Puede requerir psicofármacos para reducir la depresión en los casos más serios.

28/82
Nota: conviene distinguir si alguna de las dos escalas es más alta que la otra. Los pacientes con perfil ***28*** experimentan una depresión severa junto con ansiedad e intranquilidad. Ese cuadro genera normalmente confusión y problemas de memoria, concentración y atención. También incluye rumiaciones y puede llevar a trastornos del pensamiento. Son comunes los síntomas somáticos, la fatiga y el insomnio. Presenta aislamiento social, lo cual empeora su sintomatología. El potencial suicida es elevado y el pronóstico de cambios es malo. Por su parte, los sujetos con perfil ***82*** pueden mostrar características psicóticas (alucinaciones, delirios, síntomas físicos bizarros) acompañando a los síntomas recién descriptos.
Afectividad
Malestar afectivo severo caracterizado por disforia y anhedonia. Se siente intranquilo, deprimido, ansioso, y culpable. Irritabilidad e impaciencia. Pesimismo, resignación, y falta de iniciativa.
Cognición:
Problemas de memoria y concentración. Razonamiento deteriorado. Pobre autoconfianza. Temor a volverse loco. Sensación de ser observado y criticado. Sensación de inadecuación. Derrotismo ante los obstáculos. Muchos de sus síntomas pueden ser psicóticos o una condición crónica caracterológica.
Relaciones interpersonales:
Aislamiento social e introversión que contribuyen a empeorar sus síntomas. Le incomoda la presencia de gente. Sentimientos de soledad aún en compañía. Sensación de extrañeza y malestar con respecto a su familia.
Otros aspectos:
Reporta síntomas físicos asociados con el funcionamiento neurológico, incluyendo problemas de sueño. Potencial abuso de sustancias y de conducta o ideación suicida que requieren cuidadoso control.
Pronóstico:
Pronóstico generalmente malo. El patrón es crónico y posiblemente requiera una internación. Puede requerir psicofármacos para reducir las preocupaciones, sus problemas de sueño, y su disforia. Se recomienda un tratamiento conductual breve focalizado en los motivos de consulta.

29/92
Nota: perfil extremadamente raro.
Afectividad
Leve malestar emocional caracterizado por intranquilidad, cavilaciones, y preocupaciones. Sentimientos fáciles de herir. Impaciencia y tozudez. Infelicidad. En respuesta al estrés, puede generar síntomas físicos, agitarse, o abusar de sustancias.
Cognición:
Pobre autoconfianza. Juicio deteriorado. Cinismo. Férrea defensa de sus ideas.
Relaciones interpersonales:
Extroversión y sociabilidad.

Otros aspectos:
Preocupación por su salud pero sin síntomas definidos. Alto potencial de abuso de sustancias. Potencial ideación suicida.
Pronóstico:
Pronóstico reservado. Debe considerarse la posibilidad de un trastorno del ánimo, incluso un bipolar, en cuyo caso requerirá medicación. Terapias breves focalizadas pueden también resultar útiles.

20/02
Afectividad
Leve malestar emocional caracterizado por cavilaciones crónicas, disforia, y anhedonia. Alta sensibilidad a la crítica. Sentimientos de inutilidad. Irritabilidad e impaciencia. Infelicidad y sensación de no poder tener éxito en la vida.
Cognición:
Pobre autoconfianza, dificultad para comportarse asertivamente por su timidez. Evitación de las dificultades y resignación.
Relaciones interpersonales:
Timidez y evitación. Se siente inhábil socialmente. Es visto como alguien reservado. Sensación de soledad aún en compañía. Sensibilidad hacia el trato de los otros y temor a exponerse.
Otros aspectos:
El perfil contraindica abuso de sustancias y en especial problemas de conducta. Sí es posible la ideación suicida.
Pronóstico:
Pronóstico relativo. Está muy habituado a su patrón de síntomas y conductas y no piensa en cambiar. En particular está adaptado a su depresión y es difícil que llegue a psicoterapia. Su resistencia a exponerse implica un obstáculo para un vínculo terapéutico. De hacer un tratamiento, necesitará entrenamiento en desarrollar asertividad y habilidades sociales. Responde bien a tratamientos directivos. Una terapia cognitivo-conductual focalizada en su cognición depresiva también puede convenir. La terapia grupal es otra alternativa viable.

34/43
Nota: Hay diferencias entre el perfil ***34*** y el ***43***.
El perfil ***34*** describe a alguien inmaduro, egocéntrico, que descarga su hostilidad de manera indirecta. Ofrece la apariencia externa de ser tranquilo y conformista. Puede buscar relacionarse con personas actuadoras. Si el cliente es un hombre, puede manifestar temores de ser homosexual, particularmente si también eleva la escala **5**, pero es improbable que tenga conductas abiertamente homosexuales. Reporta problemas familiares sin comprender su participación en ellos.
El perfil ***43***, por su parte, refiere una tendencia al enojo y hostilidad mal controlados con expresión cíclica. Se corresponde con casos como el de sujetos encarcelados por conducta violenta. Sujetos con este perfil en el test suelen parecer retraídos y calmos, y exhiben súbitos comportamientos explosivos que resultan sorpresivos para los demás. Su juicio se torna pobre cuando está bajo estrés, aunque las conductas explosivas surgen aún en ausencia de estrés. Tales conductas no son irracionales, a menos que esté también elevada la escala ***8***. La alternancia cíclica de comportamientos disrruptivos y períodos de conducta apropiada es un patrón estable y difícil de cambiar en estos sujetos.
Afectividad
Malestar afectivo muy leve caracterizado por una disconformidad difusa ante la vida. Preocupaciones frecuentes y sensación de no haber disfrutado la vida. Ocasionalmente se siente sobrepasado por las dificultades. Expresiones indirectas y pasivas de la agresión.
Cognición:
Memoria y concentración conservados. Se siente capaz de tomar decisiones fácilmente. Actitud defensiva y negación de problemas psicológicos, aún cuando sean evidentes. No analiza causas y consecuencias de su conducta.
Relaciones interpersonales:
Extroversión y sociabilidad. Imperturbabilidad ante las opiniones de los otros. Lazos familiares conflictivos. Preferencia por manejarse solo antes que pedir ayuda.
Otros aspectos:

Preocupaciones por la salud pero sin síntomas específicos. Es probable que tenga abuso de sustancias o problemas de conducta.
Pronóstico:
Pronóstico malo por la estabilidad del cuadro y la escasa motivación. Lo más efectivo es un tratamiento conductual breve focalizado en los motivos de consulta.

35/53
Afectividad
Malestar emocional mínimo.
Cognición:
Buena concentración, memoria y toma de decisiones conservadas. Buena autoconfianza. Expresa sus ideas directamente y sin reparos.
Relaciones interpersonales:
Extroversión y sociabilidad. Es visto como alguien inmaduro, demandante, y manipulador.
Otros aspectos:
Cansancio frecuente. Es improbable que tenga abuso de sustancias o problemas de conducta.
Pronóstico:
Pronóstico reservado por su bajo nivel de malestar. Lo más efectivo es un tratamiento conductual breve focalizado en los motivos de consulta.

36/63
Afectividad
Malestar afectivo leve a moderado caracterizado por disforia y tensión. Siente ansiedad y se preocupa frecuentemente. Miedos y aprensión. Alta sensibilidad emocional. Siente a la vida como algo tensionante. Hostilidad manifiesta pero habitualmente negada. Expresión indirecta y pasiva de la agresividad. Anhedonia.
Cognición:
Capacidad para toma de decisiones bien conservada. Autoconfianza, aunque siente que enfrenta demasiadas dificultades. Negación de cualquier interpretación psicológica de sus problemas. A veces siente que está a punto de "venirse abajo". Cree que hablan de él. No busca explicaciones a la conducta de la gente. Si bien es inusual en este perfil, no debe descartarse la presencia de características psicóticas.
Relaciones interpersonales:
Introversión e incomodidad social. Siente soledad aún en compañía. Su modo de relacionarse se caracteriza por hostilidad, egocentrismo, y falta de actitud colaboradora. Le cuesta entender las reacciones de los demás hacia su conducta, pero percibe sus vínculos como positivos.
Otros aspectos:
Síntomas fisicos (palpitaciones, dolores de cabeza, mareos). Siente fatiga frecuente y tiene problemas de sueño. Potencial abuso de ansiolíticos y sedantes. Potencial ideación suicida, agravado por el consumo de psicofármacos. Es improbable que tenga problemas de conducta.
Pronóstico:
Pronóstico reservado por lo caracterológico de su perfil y su pobre insight. Lo más efectivo es un tratamiento conductual breve focalizado en los motivos de consulta, pero no cabe esperar grandes cambios.

37/73
Afectividad
Moderado malestar caracterizado por preocupaciones, tensión, agitación, y disforia. Ansiedad crónica. Respuesta somática a estresores. Miedos y fobias. Más sensible que lo común y se toma todo seriamente. Fácil de herir en sus sentimientos. Se siente incapaz de triunfar en la vida. Puede tener anhedonia.
Cognición:
Tiene problemas para concentrarse. Siente a veces que está a punto de derrumbarse. Rumiaciones y obsesiones. A pesar de su ansiedad visible, niega problemas psicológicos. Le falta autoconfianza y se siente inútil. Es derrotista ante los obstáculos y las críticas.
Relaciones interpersonales:

Levemente introvertido. Se siente solo incluso cuando está acompañado. No es criticado por sus allegados. Tiende a sentirse bien con la gente, pero es pasivo y dependiente y sensible a lo que otros piensen de él.
Otros aspectos:
Preocupaciones sobre su salud. Es improbable que tenga abuso de sustancias o problemas de conducta. Frecuentes problemas de sueño y cansancio. Posible ideación suicida.
Pronóstico:
Pronóstico reservado o malo por la cronicidad de sus problemas. Sus defensas de tipo histérico bloquean el insight y hacen difícil la intervención. Puede requerir psicofármacos para reducir la ansiedad y la agitación. Lo más efectivo es un tratamiento conductual breve focalizado en los motivos de consulta.

38/83
Afectividad
Presencia de apatía, malestar, miedo, desesperanza, y disforia. Emocionalidad inapropiada. Anhedonia. Se siente incapaz de triunfar en la vida.
Cognición:
Le cuesta concentrarse en tareas. Problemas de memoria. Negación del estrés y el malestar. Tiene ideas raras que prefiere reservarse. Siente que algo no le funciona bien. Hipervigilancia.
Relaciones interpersonales:
Introvertido pero le gusta la gente. Está demasiado concentrado en sus propios problemas por lo que no se dedica tanto a los demás. Está perturbado con respecto a sí y los demás, pero disfruta reuniones. Vida en el hogar displacentera. Es egocéntrico, inmaduro, dependiente.
Otros aspectos:
Respuesta somática al estrés, generalmente dolores de cabeza, cansancio, insomnio, o síntomas bizarros. Puede tener periodos de inconciencia que habría que evaluar clínicamente. Puede tener necesidades de hacer cosas chocantes o dañinas. Posible ideación suicida. Sentimientos de inutilidad y desesperanza.
Pronóstico:
Pronóstico reservado. Puede hacérsele un tratamiento conductual focalizado en los problemas que siente que le apabullan. Puede requerir psicofármacos por su disforia e insomnio. Tratamientos de insight no se recomiendan.

39/93
Afectividad
Mínimo nivel de malestar. Se siente feliz y emocionado con frecuencia. Responde bien cuando otros lo animan con algo. Es visto como alguien irritable y enojadizo, tozudo, emocionalmente inestable.
Cognición:
Puede tomar decisiones rápidamente y su pensamiento es acelerado. Muy seguro de sus opiniones.
Relaciones interpersonales:
Gregario y sociable, extrovertido. Superficial en sus relaciones. Hace amigos rápidamente y le gusta estar con gente y hacerse notar. Se reanima cuando está con amigos.
Otros aspectos:
Proclividad a abuso de sustancias. Síntomas físicos agudos, como dolores de pecho o de cabeza. Puede tener periodos de inconciencia que habría que evaluar clínicamente. A veces se siente con mucha energía e incluso no duerme.
Pronóstico:
Pronóstico reservado. Tiene un patrón estable y caracterológico en sus vínculos que le produce bajo estrés y poca motivación para un cambio. No le interesa analizar su conducta y abandonará el tratamiento una vez cesados los síntomas físicos. Lo más efectivo es un tratamiento conductual breve focalizado en los motivos de consulta. Será muy verborrágico y demandante con su terapeuta.

30/03
Afectividad
Moderado malestar afectivo, temores y posibles fobias. Sentimientos fáciles de herir. Poco feliz.

Cognición:
Pobre autoconfianza. Resignación. Conciencia de sí.
Relaciones interpersonales:
Introversión, tendencia al aislamiento y timidez. Conducta muy convencional.
Otros aspectos:
Es improbable que tenga abuso de sustancias. Tiene algunos síntomas somáticos vagos.
Pronóstico:
Pronóstico reservado. El perfil es muy caracterológico y su desconfianza hacia los otros dificulta un acercamiento terapéutico. Se recomiendan tratamientos breves antes de pasar a un tratamiento de largo plazo para tratar lo crónico.

45/54
Afectividad
Mínimo malestar emocional o preocupación sobre sus circunstancias actuales. Indica un estado de satisfacción habitual.
Cognición:
Capacidad de razonamiento, memoria y concentración conservadas.
Relaciones interpersonales:
Puede estar preocupado por cuestiones homosexuales. Algunos pacientes con este perfil son probablemente homosexuales de hecho. Actitud defensiva con respecto a exponerse o hablar de sí mismo a los demás.
Otros aspectos:
Buena salud física. Posible abuso de sustancias.
Pronóstico:
Pronóstico reservado o malo porque hay poca motivación para un cambio. Lo más efectivo es un tratamiento conductual breve focalizado en los motivos de consulta.

46/64
Afectividad
Leve a moderado malestar afectivo caracterizado por disforia, anhedonia, y preocupación. Tozudez e irritabilidad. Si bien controla sus expresiones hostiles, tiene explosiones episódicas de enojo ante el estrés. Externalización de culpas para justificar su enojo. Rumia frecuentemente quejándose de lo que le pasa. No se siente capaz de conseguir lo que quiere en la vida.
Cognición:
Memoria y concentración conservados. Recuerda bien lo que la gente le dijo o le hizo. Cree que otros hablan mal de él y que la tienen con él. Suspicacia sobre los motivos de los demás.
Si la escala ***8*** está también elevada, será alguien muy evitativo con respecto a admitir problemas psicológicos, y será más probable que presente dificultades en el juicio. Además aumenta la probabilidad de conductas de enojo explosivas y violentas, hostiles y desafiantes. Es muy probable la presencia de un proceso psicótico, a verificar con entrevistas y revisión de H.C.
Relaciones interpersonales:
Sensación de que sus fracasos y problemas se deben a la responsabilidad y acción otros. Alta probabilidad de una historia con importantes desajustes vinculares y laborales. Resentimiento, enojo, y suspicacia en todas sus relaciones. Alienación y desvinculación de su familia y la sociedad.
Otros aspectos:
Buena salud física. Potencial abuso de sustancias. Posible ideación suicida. Apatía y desesperanza, que combinadas con sus cavilaciones y enojo pueden llevar a un acting out contra sí mismo u otros.
Pronóstico:
Pronóstico malo, debido a su patrón crónico de negación de problemas psicológicos y la tendencia a externalizar culpas. Será muy demandante en terapia. Lo más efectivo es un tratamiento conductual breve con intervenciones directas y explícitas.

47/74
Nota: Perfil teóricamente paradojal. Caracteriza un patrón de conductas cíclicas entre dos extremos: insensibilidad hacia las consecuencias del comportamiento y excesiva preocupación por la propia conducta. Por periodos, el sujeto es impulsivo y luego pasa por etapas de culpa, remordimiento y auto-depreciación. En esta segunda fase es en la que más probablemente

consulten, pero el clínico debe tener presente que para intervenir en el ciclo es necesario un tratamiento a largo plazo.
Afectividad
Malestar afectivo leve a moderado caracterizado por ansiedad y agitación. Se lamenta frecuentemente y se frustra e inquieta con facilidad. Impaciencia e irritabilidad. Desmotivación y sensación de incapacidad para arreglárselas.
Cognición:
Patrón cíclico de acting out seguido de remordimiento. Este último no inhibe la repetición de las conductas impulsivas. Derrotismo y pobre autoconfianza. Le cuesta tomar decisiones y espera que otros lo hagan cuando está en problemas. Ve a los otros como egoístas y muestra cinismo en sus interacciones.
Relaciones interpersonales:
Tendencia al conflicto interpersonal y a episodios violentos. Insensibilidad hacia las necesidades de otros. Antecedentes de familia abandónica, desafectivizada, y/o crítica.
Otros aspectos:
Salud física y sueño sin problemas. Potencial acting out sexual y abuso de sustancias. Conviene evaluar ideación suicida.
Pronóstico:
Pronóstico malo para tratamientos breves y reservado para tratamientos de largo plazo. En los periodos de remordimiento puede dar la apariencia de tener insight, pero una vez pasado ese periodo, su motivación para el cambio desaparece.

48/84
Nota: Este perfil devela un patrón crónico de desajuste esquizoide o definitivamente esquizofrénico. Conducta impredecible. Problemas legales por su comportamiento motivado por pensamientos desadaptados y desviados. Es probable que haya antecedentes penales y no es raro que se trate de un abusador de menores o violador. Cualquier tratamiento psicológico tiene alcance limitado en este caso.
Afectividad
Malestar afectivo de moderado a severo caracterizado por disforia, agitación, y anhedonia. Irritabilidad y dificultad para modular la expresión del enojo. En respuesta al estrés, puede o bien retraerse o bien hacer un acting out agresivo. Sensación de inseguridad, de aislamiento, y de ser rechazado. Siente al mundo como hostil. Derrotismo.
Cognición:
Problemas de concentración. Juicio deteriorado, frecuentemente impulsivo e impredecible. Se reserva muchas de sus ideas. El perfil refleja muchos síntomas asociables con un proceso psicótico, que deberá ser chequeado con la H.C.
Relaciones interpersonales:
Introversión y tendencia al aislamiento. Antecedentes de familia desafectivizada o abandónica. Carencia de habilidades sociales. Distancia emocional y sensación de ser incomprendido y rechazado. Esta sensación lo lleva a actitudes hostiles hacia los otros, lo que retroalimenta su sensación de ser rechazado.
Otros aspectos:
Es probable que presente ideación suicida e incluso antecedentes de intentos de suicidio. Su aislamiento y desesperanza incrementan ese riesgo. Probabilidad de abuso de sustancias. Problemas de sueño que exacerban la sintomatología. De cometer crímenes, lo más probable es que sean violentos, bizarros, y no planificados. Probable inadaptación sexual.
Pronóstico:
Pronóstico muy malo por lo caracterológico de sus síntomas. Incluso es probable que los psicofármacos sean poco efectivos. Las psicoterapias conductuales focalizadas en objetivos limitados pueden dar algún resultado. Su dificultad para hacer vínculos afectivos y su renuencia a exponerse obstaculiza cualquier alianza terapéutica. Las terapias de insight están contraindicadas.

49/94
Nota: el perfil representa alguna forma de conducta de acting out. Lo evaluado por la escala ***9*** aporta más energía a las conductas reflejadas por escala ***4***. Es un perfil común en sujetos con conflictos conyugales, o con antecedentes penales (abusadores, criminales, etc.). Si la escala ***F***

está elevada, mayor probabilidad de agresividad. Si también están elevadas las escalas ***6*** y ***8***, y el perfil es ***94***, aumenta la probabilidad de intensa violencia.
Afectividad
Malestar afectivo mínimo o leve. Necesidad de estimulación y actividad. Irritabilidad y tendencia a explosiones episódicas de ira, que aumentan ante la presencia de estresores.
Cognición:
Memoria y concentración conservados. Juicio desviado, con pobre previsión de las consecuencias de sus acciones. Escasa capacidad de aprendizaje a partir de la experiencia. No acepta la responsabilidad de su comportamiento y tiende a perseverar en conductas problemáticas. Cinismo. Además del acting out, otro mecanismo defensivo probable es la racionalización.
Relaciones interpersonales:
Busca activamente relaciones y reuniones. Genera en otros una buena impresión inicial, pero con el tiempo se advierte que esa impresión es superficial y que sus vínculos están impregnados de impulsividad, egocentrismo, desconfianza y carencia de empatía. Oposicionismo y hostilidad, que se advierten en sus relaciones familiares y con figuras de autoridad. Tendencia habitual a meterse en problemas, incluso con actos delictivos.
Otros aspectos:
Buena salud física e infatigabilidad. Potencial abuso de sustancias y/o ideación suicida, agravados por su impulsividad.
Pronóstico:
Pronóstico reservado, a menos que haga un tratamiento desde joven. Suele ser más efectivo un enfoque conductual focalizado en comportamientos específicos o terapia de grupo con sujetos similares.

40/04
Nota: Perfil extremadamente infrecuente y teóricamente paradojal.
Afectividad
Malestar emocional leve caracterizado por disforia y anhedonia. Displacer con respecto a su vida. Carencia de motivación e impulso.
Cognición:
Memoria y concentración conservadas. Duda de la honestidad de los demás. Pobre autoconfianza.
Relaciones interpersonales:
Retraimiento y evitación de las interacciones sociales. Displacer en la vida hogareña. Problemas con la autoridad.
Otros aspectos:
Salud física y sueño conservados. Desesperanza sobre el futuro, que puede derivar en ideación suicida. Potencial de abuso de sustancias.
Pronóstico:
Pronóstico reservado. Se recomiendan tratamientos sobre habilidades sociales. Escasa motivación para un largo plazo.

56/65
Afectividad
Ausencia de malestar emocional. Suele ser visto como alguien irritable, impulsivo y distante.
Cognición:
Creencias religiosas o políticas férreas que está dispuesto a hacer saber a otros. Cree que su juicio está intacto. Culpa a otros de sus problemas.
Relaciones interpersonales:
Incomodidad social. Preferencia por actividades solitarias.
Otros aspectos:
Buena salud física y sueño normal. Improbabilidad de abuso de substancias. Potencial ideación suicida. Preocupaciones sexuales.
Pronóstico:
Pronóstico reservado por su creencia de no estar implicado en sus problemas, así como por su reserva. Lo más efectivo es un tratamiento conductual breve focalizado en los motivos de consulta.

57/75
Afectividad
Malestar afectivo leve a moderado caracterizado por ansiedad crónica y síntomas leves depresivos. Miedos y aprensión. Agitación frecuente, que por lo general interfiere con el sueño. Alta sensibilidad y sentimientos fáciles de herir.
Cognición:
Preocupaciones frecuentes que le vienen a la mente. Pobre autoconfianza.
Relaciones interpersonales:
Timidez y vergüenza.
Otros aspectos:
Buena salud física. Es improbable que tenga abuso de sustancias o problemas de conducta. Posibles preocupaciones sexuales.
Pronóstico:
Si se interesa en un tratamiento, el pronóstico es bueno para largo plazo. Responde bien a terapias de contención.

58/85
Nota: Probable entorno familiar con historia psiquiátrica. El sujeto puede tener antecedentes psiquiátricos desde niño.
Afectividad
Reporta una depresión reactiva, posiblemente leve, con disforia y anhedonia. Miedo y aprensión hacia el entorno.
Cognición:
Problemas de concentración. Reporta preocupaciones religiosas pero cree tener procesos de pensamiento intactos. No obstante, presenta muchos síntomas (posibles alucinaciones, ideas extrañas, desrrealizaciones) potencialmente psicóticos que deben ser chequeados clínicamente.
Relaciones interpersonales:
Es descrito como alguien excéntrico con dificultoso contacto emocional con otros. Conflictos sexuales. Timidez, reserva, y evitación.
Otros aspectos:
Buena salud física pero problemas de sueño. Conviene evaluar posible ideación suicida.
Pronóstico:
Pronóstico reservado por lo caracterológico del cuadro. Posiblemente convenga iniciar tratamiento con un enfoque breve para abrir la continuidad en una terapia a largo plazo.

59/95
Afectividad
Escaso malestar emocional, y sensación habitual placentera. Necesidad de hacer actividades para no aburrirse.
Cognición:
Memoria y concentración conservados. No reporta problemas de pensamiento. Sospechas y dudas con respecto a las intenciones de otros.
Relaciones interpersonales:
Autoconfianza y extraversión. Se relaciona fácilmente con otros y genera buena impresión, aunque no le importa lo que piensen de él. Preferencia por ser líder. Conflictos familiares.
Otros aspectos:
Buena salud física e infatigabilidad. Potencial abuso de sustancias para aliviar la ansiedad y potencial violencia a causa del alcohol.
Pronóstico:
Pronóstico reservado dada la pobre motivación para un cambio. Lo más efectivo es un tratamiento conductual breve focalizado en los motivos de consulta.

50/05
Afectividad
Mínimo malestar emocional. Irritabilidad e impaciencia para con otros.
Cognición:
Derrotismo. Pobre autoconfianza.
Relaciones interpersonales:

Introversión y evitación social. Vergüenza.
Otros aspectos:
Es improbable que tenga abuso de sustancias o problemas de conducta.
Pronóstico:
Pronóstico reservado dada la pobre motivación para un cambio. Lo más efectivo es un tratamiento conductual breve focalizado en los motivos de consulta.

67/76
Afectividad
Malestar afectivo leve a moderado caracterizado por cavilaciones, preocupaciones, y ansiedad. Se siente deprimido y rumia sobre sus problemas y rencores. Expresión indirecta del enojo. Rigidez, hipersensibilidad, y tozudez. Sensación de que la vida es tensionante y escasa esperanza de un cambio para mejor. Vergüenza. Sentimientos fáciles de herir.
Cognición:
Problemas de concentración a causa de sus rumiaciones. Frecuentemente proyecta sus problemas en otros. Pobre autoconcepto y autoconfianza. Se siente criticado y mal mirado. Tiene pensamientos malos de los cuales no quiere hablar. Temor de perder el control de su mente. Varios síntomas reportados pueden reflejar un proceso psicótico, que deberá chequearse clínicamente.
Relaciones interpersonales:
Extrema incomodidad social, y pobre juicio social con tendencia a mantener distancia interpersonal. Sentimientos de soledad incluso en compañía. Escasa apertura al diálogo íntimo. Su hipersensibilidad y tendencia a malinterpretar la conducta de los otros le lleva a tener vínculos volátiles y distantes.
Otros aspectos:
Problemas para dormir a causa de las rumiaciones. Fatiga. Potencial abuso de sustancias e ideación suicida. Improbable presencia de problemas legales. Reporta varios síntomas neurológicos que requieren un examen clínico.
Pronóstico:
Pronóstico reservado por la cronicidad del cuadro, sumado a su pobre disposición a abrirse al diálogo y su incomodidad interpersonal que obstaculizan la alianza terapéutica. Puede requerir psicofármacos para reducir las preocupaciones excesivas y las rumiaciones. Lo más efectivo es un tratamiento conductual breve focalizado en los motivos de consulta.

68/86
Afectividad
Severo malestar emocional caracterizado por disforia, agitación, preocupación, y anhedonia. Afectividad probablemente embotada o inapropiada Es alguien temeroso, fácilmente asustadizo, y comúnmente aprensivo. Pobre esperanza con respecto al futuro. Frecuentemente siente culpa.
Cognición:
Problemas de memoria, atención y concentración. Juicio deficitario. Pobre autoconfianza y sentimientos de inseguridad e inferioridad. Experiencias de desrrealización y preocupaciones y rumiaciones en torno a temáticas religiosas, abstractas, o sexuales. Creencia de intentos de influencia sobre su mente por parte de otros. Es posible que clínicamente ponga en manifiesto conductas regresivas, lógica autista, y asociaciones bizarras. El perfil es típico de pacientes psicóticos, lo que hay que considerar al examinar su historia.
Relaciones interpersonales:
Introversión extrema, tendencia al aislamiento e incomodidad social. Apatía y retraimiento. Sensación de estar solo y no ser comprendido. Evita las relaciones cercanas por su actitud suspicaz y desconfiada, y en general muestra pobres habilidades sociales. Su conducta tiende a ser inapropiada e impredecible, lo que dificulta el trato con él. Las demandas de otros le generan gran malestar.
Otros aspectos:
Potencial ideación suicida, agravada por su desesperanza y apatía. Problemas de sueño que agravan la sintomatología. Potencial abuso de sustancias.
Pronóstico:
Pronóstico generalmente malo por lo crónico y severo del cuadro. Puede requerir psicofármacos para estabilizar los procesos de pensamiento, el sueño, y la afectividad. Las únicas intervenciones

terapéuticas convenientes son las conductuales de corto plazo. Se desaconseja cualquier abordaje de insight.

69/96

Afectividad

Malestar afectivo leve a moderado caracterizado por agitación, tensión y excitación, y a veces leve disforia y anhedonia. Necesidad de estimularse para no aburrirse. Animosidad y felicidad inmotivadas. Dificultad para expresar sus sentimientos y oscilaciones entre un control excesivo y un descontrol emocional. Es impaciente con los demás y es visto como alguien irritable y enojadizo.

Cognición:

La agitación y excitación afectan frecuentemente su poder de concentración y la claridad del pensamiento. Muestra un juicio deteriorado, aunque él cree que lo tiene intacto. Tiene ideas raras que se reserva para sí. Frecuentemente cree que está condenado sin causa. Grandiosidad, egocentrismo, y cinismo en relación a las habilidades de otros. Muchos de sus síntomas reflejan un proceso psicótico, probablemente más asociado a un trastorno afectivo que a un trastorno del pensamiento, o bien asociado a una condición caracterológica crónica.

Relaciones interpersonales:

Actividad y energía en el contacto interpersonal. Cree tener aptitudes de líder. Alienación social y desinterés en las opiniones de otros.

Otros aspectos:

Posibles alteraciones del sueño, con la creencia de que no necesita dormir porque está lleno de energía. Buena salud física. Potencial abuso de sustancias.

Pronóstico:

Pronóstico malo por su escasa preocupación acerca de su comportamiento. Puede requerir psicofármacos para reducir la agitación. Lo más efectivo es un tratamiento conductual breve focalizado en los motivos de consulta.

60/06

Afectividad

Malestar afectivo moderado caracterizado por preocupaciones y disforia. Posible anhedonia. Impaciencia y malhumor. Hipersensibilidad a la crítica y sentimientos fáciles de herir.

Cognición:

Siente que puede pensar con claridad y que tiene la memoria conservada. Pobre autoconfianza.

Relaciones interpersonales:

Timidez y vergüenza. Pasividad y evitación de las confrontaciones. Sentimiento de soledad incluso en compañía. Escasa apertura al diálogo confidente.

Otros aspectos:

Buena salud física. Problemas de sueño. Potencial abuso de sustancias.

Pronóstico:

Pronóstico regular. Puede ser conveniente un entrenamiento en habilidades sociales y asertividad. Su reserva y dificultad para el exponerse obstaculizan la alianza terapéutica. Dado que sus problemas son crónicos, requieren abordarse en un tratamiento a largo plazo, siempre que se haya logrado el vínculo con el terapeuta.

78/87

Nota: Los sujetos con perfil ***78*** muestran señales de resistencia interna y malestar ante la emergencia de ideas o conductas desajustadas; en tanto que los sujetos con perfil ***87*** pueden estar más adaptados a su sintomatología, lo cual es un dato de peor pronóstico.

Afectividad

Moderado nivel de malestar caracterizado por disforia, cavilaciones, e intranquilidad. Estado crónico de estrés que ante aumentos de presiones o estresores se traduce en mayor intranquilidad y retraimiento. Aprensión y temores hacia el entorno. Poco placer en la vida y baja motivación para cambiar. Posiblemente anhedonia.

Cognición:

Le cuesta pensar y concentrarse. Le falta autoconfianza y se rinde fácilmente ante los obstáculos. / tiene ideas raras que prefiere reservarse. siente que algo no le funciona bien. Rumiaciones y obsesiones en torno a sus sentimientos y conflictos. Fantasías sexuales y vida sexual

desajustada. Cínico y suspicaz sobre los otros. Muchos de sus síntomas pueden ser psicóticos, lo cual hay que verificar.
Relaciones interpersonales:
Extremadamente introvertido, con incomodidad social y pobres habilidades interpersonales. Le cuesta formar vínculos cercanos estables. Alienación. Indecisión y pasividad en las relaciones. Suele sentirse solo incluso cuando está acompañado.
Otros aspectos:
Frecuentes problemas de sueño y cansancio. Posible ideación suicida. Algunos de sus síntomas son neuropsicológicos y habría que evaluarlos clínicamente. Proclividad a abuso de sustancias.
Pronóstico:
Pronóstico generalmente malo por lo caracterológico de sus problemas y su baja disposición al tratamiento. La alianza terapéutica es difícil por la patología del carácter así como también por la pobre capacidad para generar vínculos. Puede requerir psicofármacos para disminuir su intranquilidad y sus problemas de sueño. Pueden encararse tratamientos cognitivo-conductuales para modificar su procesamiento cognitivo depresivo y ansioso.

79/97
Afectividad
Nivel moderado de malestar caracterizado por disforia, preocupaciones, anhedonia e intranquilidad. Frecuentemente se inquieta y necesita hacer algo para no aburrirse. Impaciencia para con los demás.
Cognición:
Le cuesta relajarse y cancelar sus rumiaciones obsesivas sobre miedos y problemas. Mayor rumiación como respuesta ante estresores. Periodos alternativos de conducta impulsiva y de arrepentimiento y culpa. Pensamiento desconectado y tangencial. Juicio inadecuado. Tiene ideas que prefiere reservarse. Posibilidad de características maníacas que debe chequearse clínicamente.
Relaciones interpersonales:
Es suspicaz con respecto a las intenciones de los otros. Inmaduro y egocéntrico. Dada su conducta impulsiva y desconsiderada, suele tener problemas para mantener vínculos profundos. Conflictos familiares importantes.
Otros aspectos:
Problemas de sueño a causa de su intranquilidad y excitabilidad. Potencial para abuso de sustancias. Algunos de sus síntomas son neuropsicológicos y habría que evaluarlos clínicamente. Posible ideación suicida, incrementada por el riesgo de impulsividad y abuso de sustancias.
Pronóstico:
Pronóstico reservado por lo crónico de su sintomatología, la dificultad para establecer vínculos, y su poca apertura para hablar de sus problemas. Puede requerir psicofármacos para disminuir su excitabilidad, su intranquilidad y su ansiedad. Lo más efectivo es un tratamiento conductual breve focalizado en los motivos de consulta.

70/07
Afectividad
Malestar afectivo leve caracterizado por disforia, preocupación y culpa. Posible anhedonia. Impaciencia para con los otros. Apatía.
Cognición:
Derrotismo y problemas de autoconfianza. Rumiaciones y obsesiones en torno a cosas que debería haber hecho. Problemas de concentración posiblemente debidos a las rumiaciones.
Relaciones interpersonales:
Timidez, reserva y vergüenza. Es fácil de intimidar. Sensibilidad a las opiniones de los otros. Por su aislamiento y temor social, es improbable que tenga problemas de conducta.
Otros aspectos:
Es improbable que tenga abuso de sustancias. Buena salud física. Potencial ideación suicida.
Pronóstico:
Pronóstico bueno para un tratamiento de largo plazo. Puede ser conveniente un entrenamiento en habilidades sociales y asertividad. Su reserva y dificultad para el exponerse obstaculizan la alianza terapéutica.

89/98
Nota: Perfil psicopatológico serio.
Afectividad
Nivel moderado a severo de malestar afectivo caracterizado por intranquilidad y excitabilidad. Frecuente hiperactividad aguda, acompañada de desorientación y confusión. Labilidad emocional, hostilidad, e irritabilidad. Su comportamiento es imprevisible y con tendencia al acting out.
Cognición:
Le cuesta pensar y concentrarse. Su juicio y examen de la realidad puede ser muy desviado. Como respuesta ante estresores, se puede desorganizar e inquietar mucho más, o bien retraerse excesivamente en la fantasía. Muchos de sus síntomas pueden ser psicóticos, o bien representar una condición caracterológica crónica, lo cual hay que verificar con su historia clínica.
Relaciones interpersonales:
Demandante, evasivo, suspicaz y desconfiado. Conducta impredecible y actuadora. Siente miedo al trato social, por lo cual tiene pocos o ningún vínculo significativo. De haberlo, estará impregnado de enojo y desconfianza. Su conducta afectiva es lábil y egocéntrica.
Otros aspectos:
Pobre ajuste en la vida sexual. Potencial para abuso de sustancias. Posible ideación suicida, incrementada por el riesgo de impulsividad y abuso de sustancias.
Pronóstico:
Pronóstico generalmente malo. Puede requerir psicofármacos para disminuir su intranquilidad. Su mala predisposición al vínculo atenta contra una alianza terapéutica. Lo más efectivo es un tratamiento conductual breve focalizado en los motivos de consulta.

80/08
Afectividad
Malestar afectivo leve caracterizado por disforia, culpa, y ansiedad. Pobre capacidad de disfrute. Fobias o temores. Irritabilidad e impaciencia. Se rinde fácilmente y evita conflictos.
Cognición:
Problemas para la toma de decisiones. Pobre autoconfianza y sensación de no ser comprendido. Creencia de que la gente es egoísta y desconfianza sobre las intenciones de los otros. Cinismo.
Relaciones interpersonales:
Introversión extrema, tendencia al aislamiento y timidez. Evitación social. Sentimientos de soledad aún en compañía. Posibles características esquizoides.
Otros aspectos:
Es improbable que tenga abuso de sustancias. Buena salud física y sueño normal.
Pronóstico:
Pronóstico bueno para un tratamiento conductual breve focalizado en los motivos de consulta. El entrenamiento para la asertividad y habilidades sociales también puede ser conveniente. Su restringido contacto verbal limita la posibilidad de una alianza terapéutica para largo plazo.

90/09
Afectividad
Moderado nivel de malestar, pero sensación habitual de ser feliz
Cognición:
Tiene autoconfianza, y puede llegar al egocentrismo y la grandiosidad.
Relaciones interpersonales:
Socialmente introvertido a pesar de tener buenas habilidades sociales. Se siente alienado con respecto a su familia, generadora de muchas críticas para con él.
Otros aspectos:
Buena capacidad de trabajo y salud física. Es improbable que abuse de sustancias o que tenga problemas legales.
Pronóstico:
Relativamente favorable. Se recomiendan terapias breves centradas en su motivo de consulta. Hay baja motivación para iniciar un tratamiento de largo plazo.

Perfiles de tres o cuatro escalas

La combinación de más de dos escalas no es infrecuente pero, por darse con menos asiduidad que los perfiles de dos, han sido en mayoría menos investigadas. En consecuencia, se dispone de menos correlatos empíricos que apoyen las interpretaciones. Algunas pocas tríadas se han destacado en la literatura y son la excepción a ello. A continuación se resumen las principales observaciones de los perfiles de tríadas o tétradas más salientes y conocidas.

123/213
Al perfil ***12/21*** se le agregan las defensas histéricas características de la escala ***3***. Indica una fuerte tendencia a la somatización en respuesta al estrés, junto con depresión y ansiedad. Comparado con el perfil ***12/21***, muestra mayor represión e inhibición, y una actitud de aceptación y resignación con respecto a los síntomas físicos. Estos últimos son crónicos y variados, como dolores abdominales, debilidad, fatiga, y problemas de sueño. Es común la consulta exagerada a médicos. Pueden mostrarse irritables y quejosos, pero socialmente suelen ser pasivo-dependientes, especialmente si la escala ***4*** está baja. En hombres, implica también sentimientos de inadecuación sexual. Si la escala ***L*** está elevada, es probable que tenga muchos conflictos maritales o sexuales por su moral rígida sumada a su carencia de insight y baja energía. El perfil contraindica procesos psicóticos, ideación suicida y desórdenes OC. El pronóstico es malo.

1234/2134
Al perfil ***123/213*** se le agrega el potencial de episodios impulsivos, hostilidad, desconfianza y alienación de la escala ***4***. Esto implica un patrón complejo y cíclico, en el que aparecen períodos explosivos cuando el sobre-control y las somatizaciones resultan insuficientes. También agrega alto egocentrismo, potenciales manipulaciones, excesivas demandas, y propensión a las adicciones (aún cuando no esté elevada la escala ***MAC-R***). En hombres, suele indicar hostilidad hacia las mujeres, incluso tendencia al abuso, particularmente cuando sus necesidades de dependencia se frustran. El pronóstico es malo.

1237/2137
Al perfil ***123/213***, la escala ***7*** le adiciona mayor ansiedad, tensiones, miedo, inhabilidad para ser asertivo, sentimientos de inadecuación, y dependencia. Implica internalización de la ansiedad y el conflicto. Se los suele ver como personas incapaces de afrontar las presiones de la vida cotidiana, particularmente si las escalas ***K*** y ***Es*** están disminuidas por debajo de 50 puntos T. Puede haber inactividad laboral y dependencia al alcohol. El tratamiento que requieren es de contención, pero el pronóstico es reservado.

128/218
A lo típico del perfil ***12/21*** se le agregan las perturbaciones cognitivas (del pensamiento, memoria, y concentración) y sensación de alienación propias de la escala ***8***. Es un perfil fundamentalmente depresivo serio con síntomas físicos y psicóticos. Lo bizarro de las quejas somáticas refleja lo grave de la depresión y la pobre autoestima. También se acompaña de fatiga, debilidad, tensión, e insomnio. En algunos casos, se advierten tendencias dependientes graves. Algunos pacientes psicóticos agudos o pre-psicóticos con delirios somáticos elevan esta tríada, pero típicamente el perfil se corresponde con severas depresiones con sentimientos de desintegración. El pronóstico es malo a reservado, se trata de pacientes que requieren medicación antidepresiva y tratamientos de contención. Las terapias de insight están contraindicadas.

129/219
El perfil refleja una gran inestabilidad de los estados de ánimo. Si las tres escalas están dentro de puntajes similares, no es fácil diferenciar si se trata de un trastorno afectivo con inestabilidad del ánimo que genera síntomas psicosomáticos secundarios, o bien si es una depresión con somatizaciones que secundariamente se acompaña de agitación. Las preocupaciones en torno al funcionamiento físico son grandes y cualquier síntoma es considerado por el paciente como una emergencia. Malestar agudo, tensión, inquietud y ausencia de descanso son características comunes y muy marcadas. A veces se acompañan de dolores de cabeza e insomnio. Se han observado pacientes lesionados cerebrales con este perfil. El pronóstico es reservado porque a las defensas somáticas se le agrega el desequilibrio anímico. Si no hay antecedentes de episodios maníacos, el tratamiento farmacológico principal será con antidepresivos, pero siempre hay que examinar cuidadosamente la historia clínica porque este perfil indica riesgo de desorden bipolar.

120/210

Si las tres escalas están elevadas al mismo nivel, se hace necesario distinguir si se trata de un patrón de somatización en una persona introvertida, o bien si es un paciente esquizoide introvertido y deprimido con síntomas somáticos. Tanto el perfil ***12/21*** como el ***20/02*** son muy estables, con lo cual esta tríada marca un patrón de funcionamiento crónico con depresión, retraimiento, indecisiones, evitación social, y sentimientos de inadecuación y culpa. Estas características son acompañadas por quejas somáticas y una actitud derrotista. Si las escalas ***6*** y ***8*** están relativamente elevadas, acentúan la condición esquizoide y misántropa del caso. El pronóstico es reservado, requieren tratamiento para la asertividad y reestructuración cognitiva para modificar su pesimismo, y a veces medicación antidepresiva para reducir la disforia.

132/312
La interpretación básica es la misma que para el perfil ***13/31***, con una depresión enmascarada por los síntomas somáticos y la negación, pero que suele manifestarse con episodios de tensión, angustia, debilidad, y fatiga. En algunos casos, el cliente niega la depresión a pesar de ser evidente. En otros, los periodos de defensas histéricas se alternan con síntomas depresivos. El perfil conformista y pasivo del código ***13/31*** se mantiene, y si se adiciona la escala ***7***, aumenta la preocupación por lo convencional, las aprensiones, y la necesidad de ser aprobado.

134/314
Si bien presentan síntomas somáticos, lo más prominente es un patrón de comportamiento presuntuoso, hostil, y discutidor. El agregado de la escala ***4*** implica que al perfil característico del código ***13/31*** se le suma un alto enojo, dependencia manipuladora, impulsividad ocasional, y desconfianza emocional. Puede mostrar algunas de las características del perfil ***34/43***, como ser explosivo y manipulador. El sobre-control de las emociones puede notarse también con la escala ***O-H*** elevada. Los síntomas somáticos pueden ser usados para manipular a los demás. Pueden presentar conflictos entre sus deseos de independencia y su miedo al abandono, con lo cual sus relaciones interpersonales serán difíciles de sostener. Puede mostrar la hostilidad con explosiones episódicas y con modos pasivo-agresivos. Es raro que el cliente muestre insight sobre sus conductas, ya que generalmente acusa a los otros de su malestar. El pronóstico es malo.

136/316
El agregado de la escala ***6*** indica que al perfil del código ***13/31*** se le suma una extrema sensibilidad hacia la crítica y contra las demandas de los otros. Presenta algunas características del perfil ***36/63***, como las defensas paranoides y la inclinación a proyectar su enojo en los demás. Curiosamente, también ostentan una rígida moral. A pesar de sus síntomas físicos, presentan un patrón competitivo, a fin de mantener el control de las cosas. Si la escala ***6*** está por encima de la ***3***, hay riesgo de una posible esquizofrenia paranoide en ciernes. La relación inversa, en cambio, implica más síntomas somáticos y menos características paranoides. El pronóstico es malo y en cualquier tratamiento debe tenerse en cuenta lo sensibles que son estos pacientes a los juicios y críticas de otros.

137
Indica un patrón de severa ansiedad y es común la presencia de ataques de pánico acompañados de molestias cardíacas, como la taquicardia, especialmente si también se eleva la escala ***9***. Bajo estrés, el cliente genera muchas respuestas somáticas, pero más aún desórdenes de ansiedad, miedos en torno a enfermedades, y sentimientos de culpa. A diferencia del código ***13/31***, estas personas son más ansiosas y socialmente dependientes y manipulables, hasta el punto del servilismo. Suelen buscar una pareja dominante. Les cuesta adaptarse a los cambios. Para el terapeuta, este perfil debe considerarse como el de un niño dependiente y sumamente ansioso. Si bien tiende a agradar, su búsqueda continua de reaseguro puede resultar fastidiosa para el clínico. Se recomiendan tratamientos para reducir la ansiedad.

138/318
Es un perfil mixto entre el ***13/31*** y el ***38/83***, propio de personas con creencias extrañas acerca de temáticas sexuales y/o religiosas, y varias quejas somáticas inespecíficas y bizarras. Muchas de estas quejas pueden obedecer a daños neurológicos. Puede implicar periodos de afectividad achatada o resignación con respecto a sus síntomas físicos, y periodos de reacción ansiosa extrema. Afirmarse en torno a preocupaciones hipocondríacas e incluso en creencias religiosas puede servirle de obturación para evitar brotes psicóticos francos, aunque no se descartan delirios místicos. Tanto su sistema de creencias como sus estados anímicos pueden ser muy inestables.

Tiende a tener confusiones y dificultades para mantener el flujo de asociaciones. Es posible la presencia de un desorden de personalidad límite. El pronóstico es reservado. El tratamiento debe ser muy estructurado y lento, estos pacientes suelen tener historias familiares de privación afectiva y necesidades de dependencia no resueltas.

1382
Se agrega a lo descripto para el código ***138/318*** una experiencia depresiva, pensamiento confusional, posible abuso de alcohol, e ideación suicida. Es común una mala o escasa experiencia de vida de pareja y de actividad laboral.

139
Es un perfil que muestra una gran necesidad de aprobación y escasa conciencia de sí, con defensas maníacas. Dificultades para expresar el enojo, que frecuentemente se acumula hasta explotar, y con tendencia a negar las consecuencias de tales ataques. Presenta numerosos síntomas físicos pero niega relación alguna con problemas emocionales. Los síntomas físicos pueden reflejar el exceso de control y negación sobre las emociones negativas. Baja tolerancia a la frustración e irritabilidad. Es común la vida interpersonal conflictiva y los divorcios. En algunos casos, el perfil puede deberse a una lesión cerebral. En el tratamiento, se recomienda revisar la historia familiar, en la que probablemente el paciente hubiese tenido padres dominantes. exigentes y perfeccionistas.

243/423
La adición de la escala ***3*** al perfil ***24/42*** inyecta defensas histéricas a este patrón de personalidad irritable y derrotista. El perfil sugiere sobrecontrol emocional a través de represión y negación, especialmente en cuanto a la expresión del enojo o el rechazo de otros. El enojo puede llegar a ser expresado indirectamente, por conductas pasivo-agresivas. En algunos casos, puede tratarse de alguien que tenga episodios súbitos de ira, que luego niega (esto es especialmente probable cuando también se eleva la escala suplementaria ***O-H*** por encima de 17 puntos brutos). Puede haber dependencia oral, abuso de sustancias, trastornos alimentarios y manipulación. Inmadurez, egocentrismo, y carencia de insight.

247/427/472/742
Perfil que combina ansiedad, culpa, y tendencias impulsivas. Es alguien hiper-responsable pero derrotista; ansioso y culposo pero actuador; y dependiente pero distante. Tiende a reaccionar exageradamente con preocupaciones y ansiedad ante mínimos estímulos percibidos como amenazantes. Puede haber síntomas OC. Sufre extremadamente los fracasos y vicisitudes, autocriticándose. Ante elevaciones de la tensión puede hacer un acting out que derive en periodos posteriores de culpa y remordimiento. Por temor a la cercanía emocional, tiende a exhibir patrones de vínculo pasivo-dependiente manipulador. Le cuesta expresar el enojo por temor al abandono, por lo que termina produciendo conductas pasivo-agresivas. Es proclive a usar la culpa para manipular. Puede incluir depresiones, fobias, dolencias físicas, ansiedad, tensión, preocupaciones, y sentimientos de inadecuación social. Es probable el consumo y hasta la dependencia de alcohol u otras sustancias. El pronóstico es reservado, necesita un tratamiento de contención, pero tiende a desconfiar.

248
El perfil presenta una combinación grave de depresión, ira, y problemas de pareja. El acting out es menos factible que un código ***24/42*** puro. En cambio, es más probable que tienda a retraerse en fantasías hostiles, sienta desconfianza, y alienación con respecto a la sociedad. Siente miedo de perder el control y se preocupa por ideas extrañas. Es visto como alguien malhumorado e impredecible. Se caracteriza por la desconfianza interpersonal, hasta el punto de la paranoia difusa. Lo que vive como depresión es probablemente más un sentimiento de vacío y soledad que tristeza real. Hay alto riesgo de ideación e intentos de suicidio, así como de consumo de sustancias. Se desaconsejan las terapias de insight por ser demasiado desorganizantes para este tipo de casos.

273/723
A la interpretación básica del código **27/72** se le agrega lo siguiente: Es un sujeto crónicamente pasivo y dependiente, que se presenta como víctima del destino y que espera protección, un patrón clínico difícil de modificar.

274/724
A la interpretación básica del código **27/72** se le agrega lo siguiente: Hay una depresión crónica con sentimientos de inadecuación, inferioridad, y culpa. También muestra una dependencia que no admite. Reporta problemas económicos, conyugales o familiares, y con el alcohol. Dada la cronicidad de este patrón, el pronóstico de cambios significativos es malo. Lo recomendable es un tratamiento breve para los síntomas depresivos.

275/725 (en hombres) y 27 con 5 disminuida (en mujeres)
A lo detallado para el código ***27/72***, se le agrega un incremento de la pasividad y sumisión. Si la escala ***4*** está además disminuida, tendrá carencia de asertividad, baja libido, y mayor adherencia a las reglas que el código ***27/72***. Tiende a anticipar fracasos amorosos, lo que lo lleva a dificultades con el sexo opuesto. La terapia y educación sexual puede ser de ayuda, así como terapias que apunten a lo interpersonal.

278/728
A la interpretación básica del código **27/72** se le agrega lo siguiente: El perfil refleja un cuadro neurótico crónico con nerviosidad, depresión y obsesiones. Implica rumiaciones, preocupaciones, indecisión, y problemas para concentrarse y pensar. Retraimiento social y posibles pensamientos suicidas. Si el cuadro es muy grave, puede enmascarar un trastorno psicótico. Suele requerir medicación y se contraindica cualquier tratamiento de insight.

284/824
Al perfil ***28/82***, el agregado de la escala ***4*** le incorpora sentimientos de alienación, desafiliación, desconfianza, hostilidad hacia otros, rebeldía, y derrotismo. Incrementa el riesgo de suicidio y el potencial de abuso de sustancias. Severos conflictos sexuales. Tenencia a mezclar sexo y agresión. En algunos casos, puede tratarse de una personalidad esquizoide o esquizofrénica. Es un paciente difícil de tratar por su desconfianza. Su posición es la de un hijo no deseado, que resultó en consecuencia alguien alienado y rabioso, que necesita contención pero no confía en la que le dan.

287/827
Es un perfil similar al ***278/728*** pero con las siguientes diferencias: Al estar la escala ***8*** en segundo lugar, implica más problemas de identidad, alienación, confusión, y probabilidad de desarrollar episodios psicóticos. Muestra depresión, ansiedad, y procesos de pensamiento tangencial. Es desconfiado, sensible a la crítica, y con ineficacia mental general (fallas de concentración, confusión, mareos, insomnio, e incapacidad para asumir responsabilidades). Puede tener emocionalidad lábil o inapropiada, delirios, y alucinaciones. Posiblemente tiene ideación suicida, en particular si la escala ***K*** está debajo de T=50 y se elevan las escalas ***4*** y ***9***. Suele requerir medicación y se contraindica cualquier tratamiento de insight.

346/436
Al perfil típico ***34/43*** se le agregan las características resentimiento racionalizado, negación del enojo, y externalización de las culpas. Extrema sensibilidad hacia el rechazo y desaprobación. Es una persona habitualmente conformista con las normas, de rígida adherencia a lo que "es correcto", pero ocasionalmente genera episodios de extremo acting out seguidos de periodos de hiper-autocontrol. Tiende a usar el juicio moral como modo de manipular a los demás. El tratamiento es muy dificultoso, por su sensibilidad al juicio crítico de otros, que a su vez le justifica su hipervigilancia.

462/642
Al cuadro de ***46/64*** se le adiciona un sentimiento de estar atrapado, derrotado, enojado y amargado, y quejas gran malestar y ansiedad. Estas quejas son manipuladoras para obtener atención y controlar. Clínicamente aparece una actitud negativista que encubre depresión, aunque lo predominante del funcionamiento se debe a lo caracterológico del cuadro, más que a la depresión propiamente dicha.

468/648
Este es un código serio, que refleja muy probablemente un trastorno grave y posiblemente crónico. Puede tratarse de un desorden emocional, y si es un paciente internado, puede ser esquizofrénico paranoide. También puede incluir características antisociales o un trastorno de

personalidad antisocial. Es alguien crítico, desconfiado, hipersensible, y discutidor. Rumiaciones enojosas en torno a injusticias que siente haber sufrido, sean reales o imaginarias. Puede presentar delirios e ideas de referencia y grandiosidad. El pronóstico es malo. Frecuentemente requiere medicación.

478
El paciente presenta comportamiento muy alterado con impulsividad y/o compulsiones como modo de reducir sus tensiones. La combinación de las escalas ***4*** y ***7*** sugiere conductas de acting out seguidas de culpa y remordimiento. Con el agregado de la escala ***8***, el sujeto muestra además una baja autoestima y antecedentes de vivencias dañinas para su autoconcepto. Esto predice mayores dificultades para los vínculos y la confianza. Busca reaseguro en su terapeuta, pero su desconfianza básica impide que los intentos de dárselo sean exitosos. Es manipulador y selecciona lo que quiere hacer saber y lo que no.

482/842/824
El cliente se caracteriza por desconfianza y alienación, que se presentan con un estado anímico depresivo, ansioso, tenso, e irritable. A veces presenta afectividad inapropiada e ideas de referencia. Su paranoia tiende a ser difusa, y no fija y racionalizada. Tiende a hacer acting out bajo estresores y es visto como alguien manipulador. Suelen existir historias de malestar en la pareja y conflictos en general con respecto la dependencia, la sexualidad, y la cercanía afectiva. Es común la ideación suicida y hasta los intentos francos de suicidio.

486/846
A lo dicho para el código ***468/648***, se le agrega que los desórdenes de pensamiento y el pobre examen de realidad son más frecuentes, y se incrementa la severidad del cuadro.

489/849
Es un perfil muy serio, con gran probabilidad de conductas de acting out bizarras, antisociales, y agresivas. Es común la agitación y la violencia, especialmente si la escala ***K*** es baja. Superficialmente, puede ser visto como alguien aventurero y sociable (más si la escala ***0*** está baja) que vive una vida emocionante sin normas, pero la probabilidad de episodios explosivos bizarros es alta. Es muy posible el consumo de sustancias.

493/943
Al perfil ***49/94***, la elevación de la escala ***3*** predice periodos de autocontrol temporal con conducta social superficialmente amable y adecuada. Estos periodos se van a alternar con conductas impulsivas. El conflicto principal reside entre su necesidad de aprobación y su autonomía. Siendo la escala ***3*** la tercera en orden, especialmente si está a más de 5 puntos T de las otras dos, su necesidad de reducir las tensiones impulsivamente predominará sobre su necesidad de aprobación. Si no es así, y las tres escalas están muy parejas, el perfil se parece más al ***34/43***. Es común la tendencia a guardarse la furia y acumularla hasta llegar a períodos de conductas explosivas, lo cual también se verá con la elevación de la escala ***O-H***.

469/496/946
La escala ***6*** le otorga más organización y mayor sensibilidad paranoide al código ***49/94***. Puede ser un sujeto con tendencia a atacar, destruir, e incluso ser un homicida, actuando en represalia ante quienes él sienta que le faltan el respeto. Su actitud tiene más determinación y racionalización que en el código ***49/94***. Si es alguien de buen nivel educativo, es discutidor, racionalizador, y externalizador de culpas. Si es de bajo nivel, a esas características se le suma una mayor probabilidad de acting out. Si además se eleva la escala ***8***, los actings vengativos pueden ser bizarros. El pronóstico es reservado y suele requerir medicación.

9. – ESCALAS SUPLEMENTARIAS

Estas escalas fueron pensadas para complementar y enriquecer la interpretación que se extrae del perfil de las escalas básicas. Es necesario administrar los 567 ítems para puntuarlas. Lo que se resume a continuación es la interpretación de los puntajes altos en cada una de estas escalas.

A - Ansiedad (primer factor)
Es la primera fuente básica que eleva los perfiles psicopatológicos. Implica una medición de malestar general. Su simple elevación indica el reconocimiento que el cliente hace de sentir malestar.

R - Represion (segundo factor)
Es la segunda fuente de variación de los perfiles. Representa la supresión y el hipercontrol sobre las emociones, así como la evitación de situaciones afectivamente movilizadoras, y poco insight. Comparada con la escala ***A***, permite ver en qué medida el cliente reconoce malestar y en qué medida indica que puede controlarlo o lo niega. Elevaciones excesivas de esta escala junto con disminuciones de la ***A***, pueden indicar sub-reporte de síntomas.

Es - Fortaleza del yo
Es una escala que fue diseñada para predecir éxito terapéutico. Implica capacidad para tolerar el estrés, ausencia de problemas crónicos, estabilidad emocional, autoconfianza, inteligencia y recursos, sentimientos de ser aceptado por los demás, intereses varios, determinación, y tolerancia a las confrontaciones en una psicoterapia.

MAC-R - Escala McAndrew de Alcoholismo
Es una de las mejores escalas para evaluar sutilmente problemas de control. Indica tendencias a la impulsividad, baja tolerancia a la frustración, y potencial de abuso de sustancias. Puntajes T moderados (60-64) indican características que pueden llevar a un consumo de sustancias. Esta escala no determina el tipo de sustancias (alcohol o drogas) ni si el cliente está consumiendo ahora, sino solamente detecta el potencial de algún consumo posible. Si es un paciente que consume pero con puntaje bajo en esta escala, el pronóstico para la rehabilitación es mejor. Los puntajes muy bajos (<45) sugieren una personalidad evitativa de riesgos y de interacciones sociales, y posiblemente deprimida.

O-H - Hostilidad Sobrecontrolada
Altos puntajes indican una tendencia dinámica a sentir elevada hostilidad, a controlar excesivamente esos impulsos hostiles, a negarlos, y a sentirse socialmente alienado. Niega esos impulsos y cualquier síntoma psicológico, aún si es psicótico. Es rígido y no manifiesta ansiedad.

Do – Dominancia
Tendencias interpersonales a ser dominante, seguro de sí, optimista, orientado a las tareas, y cumplidor para con los otros. Realista y con seguridad para afrontar problemas.

Re – Responsabilidad Social
Aceptación rígida de valores. Buena autoconfianza. Sentido fuerte de la justicia. Altas auto-exigencias y responsabilidad para con los otros. Puntajes moderados (60-64) indican aceptación de las consecuencias de su conducta.

Mt – Inadaptación universitaria
Indica malestar general, estrés, ansiedad, y baja autoconfianza. Puede haber impulsividad.

GM – Rol y género –masculino
Buena autoconfianza, y fácil toma de decisiones. Tiene pocos miedos y bajo malestar. Elige actividades e intereses típicamente masculinos. Puntajes bajos marcan miedo, introversión, malestar y cinismo.

GF – Rol y género –femenino
Elige actividades e intereses típicamente femeninos. Interactúa fácilmente con otros y es socialmente responsable. Es improbable el abuso de sustancias. Puntajes bajos pueden indicar abuso de sustancias.

PK – PTSD Keane (Estrés postraumático) y PS – PTSD Schlenger (Estrés postraumático)
Intenso malestar emocional, ansiedad y problemas de sueño. Culpa, depresión, pensamientos intrusivos. Sensación de descontrol del pensamiento. Creencia de ser malentendido o maltratado.

MDS - Malestar conyugal
Se aplica solamente a clientes que estén o hayan estado en convivencia con una pareja. Indica muchos antecedentes y/o problemas actuales de pareja y malestar en la relación. Puntajes moderados (60-64) indican algunos de estos problemas.

APS - Potencial de Adicción
El cliente muestra un estilo de vida compatible con el desarrollo de un trastorno adictivo. Si el puntaje es moderado (60-64) sugiere la presencia de varias características del estilo de vida de un adicto. Esta escala no determina el tipo de sustancias (alcohol o drogas) ni si el cliente está consumiendo ahora, sino solamente detecta el potencial de algún consumo posible. Si es un paciente que consume pero con puntaje bajo en esta escala, el pronóstico para la rehabilitación es mejor.

AAS - Reconocimiento de Adicción
El cliente reconoce tener serios problemas en el consumo de drogas o alcohol. Si el puntaje es moderado (60-64), el cliente admite algunos problemas de este tipo. Los puntajes bajos (<60) solamente indican que el cliente *no admite* tener esa clase de problemas, pero no implica necesariamente que no los tenga. Las escalas ***MAC-R*** y ***APS***, de estar elevadas, son más sensibles al potencial real.

10. – ESCALAS DE CONTENIDO

Estas escalas suelen ser bastante más breves que las básicas (la mayoría tiene entre 20 y 35 ítems) y su característica esencial es que se puede intuir fácilmente lo que están evaluando con leer el contenido de sus ítems. Por ese motivo, tienen que ser tomadas en cuenta en la medida en que el cliente haya contestado el cuestionario sin intenciones claras de manipular la imagen (por ejemplo, en algunas pericias o selección de personal). Si el cliente contestó sinceramente, el resultado es un número de escalas con alta predicción clínica que auxilian mucho la interpretación.
Lo que se resume a continuación es la interpretación de los puntajes altos en cada una de estas escalas.

ANX – Ansiedad
Es posiblemente la mejor medida de ansiedad del MMPI-2. Indica una gran preocupación en torno a tensión nerviosa, perturbaciones del sueño, y problemas de atención y concentración. La ansiedad es generalizada y cercana al pánico, especialmente si su puntaje es más alto que el de otras escalas marcadoras de malestar (***A, DEP, TRT, WRK, 7***). Se asocia con buen insight.

FRS – Miedos
Es bastante independiente de las escalas clínicas y muy sensible a la presencia de fobias, ya específicas o ya generalizadas. Indica miedos excesivos y preocupaciones fóbicas que pueden ser en torno a amenazas naturales, accidentes, animales, etc.

OBS – Obsesividad
A pesar de su nombre, indica fundamentalmente indecisión. Hay una actividad cognitiva intensa pero ineficaz. Este patrón parece darse en un trasfondo de timidez o pavor ante la necesidad de llegar a la acción práctica.

DEP – Depresión
Apatía, anhedonia, malestar generalizado, y emociones negativas. Visión de sí mismo como desvalorizado, impotente, inadecuado, e inferior. A diferencia de su par entre las escalas clínicas, la ***2*** (*Depresión*) esta escala no tiene componentes fisiológicos (pérdida de peso y del apetito, debilidad, etc.), por lo cual refleja fundamentalmente el carácter psicológico de la depresión. Si su valor es mayor que el de la escala ***2***, implica un perfil depresivo más crónico y caracterológico, y en el caso opuesto implica mayor sintomatología física y un cuadro menos complicado.

HEA – Preocupaciones sobre la Salud
Es una medida muy robusta de síntomas somáticos y se superpone en parte con la escala clínica ***1***. Reporta dolencias en la cabeza, problemas gástricos, y defectos sensoriales y motores. Si conjuntamente se elevan la escala ***ANX*** y/o ***DEP***, pueden indicar el malestar del cliente ante estos síntomas, y mejor pronóstico.

BIZ – Ideación bizarra
Es una medida de procesamiento cognitivo psicótico y representa entre las escalas de contenido a la contrapartida del perfil ***68/86***. Si bien no es conveniente utilizar esta escala para diagnosticar psicosis, sí es de mucha ayuda para ver en qué medida contribuyen temáticas o preocupaciones psicóticas a elevar las escalas ***F*** y ***8***. También indica pobre insight.

ANG – Enojo
Indica enojo mal controlado. El cliente no regula la emoción cruda, es irritable, intolerante ante la frustración, y puede manifestar episodios destructivos. Siente necesidad de descargar su ira y encuentra constreñida la expresión por límites externos, de modo que busca modos más controlados de manifestación como burlas irónicas, exigencias, discusiones innecesarias, menosprecio, etc.

CYN – Cinismo
Convicción de que los otros son indignos de confianza, malintencionados, deshonestos y en el fondo corruptos. Supone que la mayoría de la gente sigue las normas sólo por temor a las

consecuencias. Ve al mundo como una selva en la que hay que cuidarse de la gente. Con estas creencias justifica sus propias actitudes de engaño, hipocresía, y manipulación.

ASP – Prácticas Antisociales
Indica un desprecio por las leyes, una tendencia a aprovechar las oportunidades, simpatía por quienes saben aprovecharse de otros, y sentimientos de venganza hacia quienes lo descubren cuando hace algo indebido. Muestra una problemática implícita de falta de empatía. Esta escala no está necesariamente asociada con conductas antisociales manifiestas.

TPA – Personalidad Tipo A
Estilo de personalidad competitivo y hostil. Es una persona activa, rápida, y orientada al trabajo, con proclividad a enfadarse y tornarse impaciente cuando es demorado o desviado de sus objetivos. Su modo de dirigirse a los demás es tosco y autoritario.

LSE – Baja Autoestima
El cliente tiene una pobre opinión sobre sí mismo, duda que otros puedan apreciarlo, se siente poco importante, inútil y hasta una molestia para otros. Tiene pobre autoconfianza y se abruma de tantos defectos que ve en sí mismo.

SOD – Incomodidad Social
Le cuesta mucho estar con otros, y en general se siente cómodo solo. Se ve tímido y le disgustan las reuniones grandes.

FAM - Problemas Familiares
Sentimientos negativos hacia familiares. Siente que en su niñez sufrió malos tratos y en su vida conyugal hay infelicidad y falta de atención.

WRK - Interferencia Laboral
Conductas y actitudes personales que perjudican el rendimiento laboral. Algunos problemas tienen que ver con pobre autoconfianza, dificultades de concentración, obsesividad, tensiones, presiones, e indecisión. Puede haber también sentimientos de falta de apoyo por parte de su entorno y problemas con compañeros de trabajo.

TRT - Indicadores Negativos para Tratamiento
Dudas con respecto a ser entendido y ayudado por otros. El cliente admite problemas psicológicos pero no se dispone a hablar de ellos. Duda que sea posible cambiar su vida o no siente deseos de hacer cambios. Tiende a resignarse antes que a encarar la situación.

CUARTA PARTE

Procesamiento para la obtención de puntuaciones

11. – CLAVES DE CORRECCIÓN PARA OBTENCIÓN DE PUNTAJES BRUTOS

ESCALAS MMPI-2: ITEMS COMPONENTES

Nota: súmese un punto por cada ítem que haya sido respondido en el sentido indicado. La F antecediendo el número de ítem significa que debe sumarse si fue contestado como Falso, y la V indica que debe sumarse si fue contestado como Verdadero.

ESCALAS BÁSICAS

L

F16 F29 F41 F51 F77 F93 F102 F107 F123 F139 F153 F183 F203 F232 F260

F

V18 V24 V30 V36 V42 V48 V54 V60 V66 V72 V84 V96 V114 V138 V144 V150 V156 V162 V168 V180 V198 V216 V228 V234 V240 V246 V252 V258 V264 V270 V282 V288 V294 V300 V306 V312 V324 V336 V349 V355 V361 F6 F12 F78 F90 F102 F108 F120 F126 F132 F174 F186 F192 F204 F210 F222 F276 F318 F330 F343

K

V83 F29 F37 F58 F76 F110 F116 F122 F127 F130 F136 F148 F157 F158 F167 F171 F196 F213 F243 F267 F284 F290 F330 F338 F339 F341 F346 F348 F356 F365

Escala 1

V18 V28 V39 V53 V59 V97 V101 V111 V175 V149 V247 F2 F3 F8 F10 F20 F45 F47 F57 F91 F117 F141 F143 F152 F164 F173 F176 F179 F208 F224 F249 F255 (sumar **escala K** multiplicado por 0,5)

Escala 2

V5 V15 V18 V31 V38 V39 V46 V56 V73 V92 V117 V127 V130 V146 V147 V170 V175 V181 V215 V233 F2 F9 F10 F20 F29 F33 F37 F43 F45 F49 F55 F68 F75 F76 F95 F109 F118 F134 F140 F141 F142 F143 F148 F165 F178 F188 F189 F212 F221 F223 F226 F238 F245 F248 F260 F267 F330

Escala 3

V11 V18 V31 V39 V40 V44 V65 V101 V166 V172 V175 V218 V230 F2 F3 F7 F8 F9 F10 F14 F26 F29 F45 F47 F58 F76 F81 F91 F95 F98 F110 F115 F116 F124 F125 F129 F135 F141 F148 F151 F152 F157 F159 F161 F164 F167 F173 F176 F179 F185 F193 F208 F213 F224 F241 F243 F249 F253 F263 F265

Escala 4

V17 V21 V22 V31 V32 V35 V42 V52 V54 V56 V71 V82 V89 V94 V99 V105 V113 V195 V202 V219 V225 V259 V264 V288 F9 F12 F34 F70 F79 F83 F95 F122 F125 F129 F143

F157 F158 F160 F167 F171 F185 F209 F214 F217 F226 F243 F261 F263 F266 F267 (sumar **escala K** multiplicado por 0,4)

Escala 5

Hombres
V4 V25 V62 V64 V67 V74 V80 V112 V119 V122 V128 V137 V166 V177 V187 V191 V196 V205 V209 V219 V236 V251 V256 V268 V271 F1 F19 F26 F27 F63 F68 F69 F76 F86 F103 F104 F107 F120 F121 F132 F133 F163 F184 F193 F194 F197 F199 F201 F207 F231 F235 F237 F239 F254 F257 F272
Mujeres
V4 V25 V62 V64 V67 V74 V80 V112 V119 V121 V122 V128 V137 V177 V187 V191 V196 V205 V219 V236 V251 V256 V271 F1 F19 F26 F27 F63 F68 F69 F76 F86 F103 F104 F107 F120 F132 F133 F163 F166 F184 F193 F194 F197 F199 F201 F207 F209 F231 F235 F237 F239 F254 F257 F268 F272

Escala 6

V16 V17 V22 V23 V24 V42 V99 V113 V138 V144 V145 V146 V162 V234 V259 V271 V277 V285 V305 V307 V333 V334 V336 V355 V361 F81 F95 F98 F100 F104 F110 F244 F255 F266 F283 F284 F286 F297 F314 F315

Escala 7

V11 V16 V23 V31 V38 V56 V65 V73 V82 V89 V94 V130 V147 V170 V175 V196 V218 V242 V273 V275 V277 V285 V289 V301 V302 V304 V308 V309 V310 V313 V316 V317 V320 V325 V326 V327 V328 V329 V331 F3 F9 F33 F109 F140 F165 F174 F293 F321 (sumar **escala K**)

Escala 8
V16 V17 V21 V22 V23 V31 V32 V35 V38 V42 V44 V46 V48 V65 V85 V92 V138 V145 V147 V166 V168 V170 V180 V182 V190 V218 V221 V229 V233 V234 V242 V247 V252 V256 V268 V273 V274 V277 V279 V281 V287 V291 V292 V296 V298 V299 V303 V307 V311 V316 V319 V320 V322 V323 V325 V329 V332 V333 V355 F6 F9 F12 F34 F90 F91 F106 F165 F177 F179 F192 F210 F255 F276 F278 F280 F290 F295 F343 (sumar **escala K**)

Escala 9

V13 V15 V21 V23 V50 V55 V61 V85 V87 V98 V113 V122 V131 V145 V155 V168 V169 V182 V190 V200 V205 V206 V211 V212 V218 V220 V227 V229 V238 V242 V244 V248 V250 V253 V269 F88 F93 F100 F106 F107 F136 F154 F158 F167 F243 F263 (sumar **escala K** multiplicado por 0,2)

Escala 0

V31 V56 V70 V100 V104 V110 V127 V135 V158 V161 V167 V185 V215 V243 V251 V265 V275 V284 V289 V296 V302 V308 V326 V328 V337 V338 V347 V348 V351 V352 V357 V358 V364 V367 V368 V369 F25 F32 F49 F79 F86 F106 F112 F131 F181 F189 F207 F209 F231 F237 F255 F262 F267 F280 F321 F335 F340 F342 F344 F345 F350 F353 F354 F359 F360 F362 F363 F366 F370

ESCALAS SUPLEMENTARIAS

Escala A

V31 V38 V56 V65 V82 V127 V135 V215 V233 V243 V251 V273 V277 V289 V301 V309 V310 V311 V325 V328 V338 V339 V341 V347 V390 V391 V394 V400 V408 V411 V415 V421 V428 V442 V448 V451 V464 V469 F388

Escala R

F1 F7 F10 F14 F37 F45 F69 F112 F118 F120 F128 F134 F142 F168 F178 F189 F197 F199 F248 F255 F256 F297 F330 F346 F350 F353 F354 F359 F363 F365 F422 F423 F430 F432 F449 F456 F465

Es

V2 V33 V45 V98 V141 V159 V169 V177 V179 V189 V199 V209 V213 V230 V245 V323 V385 V406 V413 V425 F23 F31 F32 F36 F39 F53 F60 F70 F82 F87 F119 F128 F175 F196 F215 F221 F225 F229 F236 F246 F307 F310 F316 F328 F391 F394 F441 F447 F458 F464 F469 F471

MAC-R

V7 V24 V36 V49 V52 V69 V72 V82 V84 V103 V105 V113 V115 V128 V168 V172 V202 V214 V224 V229 V238 V257 V280 V342 V344 V387 V407 V412 V414 V422 V434 V439 V445 V456 V473 V502 V506 V549 F73 F107 F117 F137 F160 F166 F251 F266 F287 F299 F325

O-H

V67 V79 V207 V286 V305 V398 V471 F1 F15 F29 F69 F77 F89 F98 F116 F117 F129 F153 F169 F171 F293 F344 F390 F400 F420 F433 F440 F460

Do

V55 V207 V232 V245 V386 V416 F31 F52 F70 F73 F82 F172 F201 F202 F220 F227 F243 F244 F275 F309 F325 F399 F412 F470 F473

Re

V100 V160 V199 V266 V440 V467 F7 F27 F29 F32 F84 F103 F105 F145 F169 F201 F202 F235 F275 F358 F412 F417 F418 F430 F431 F432 F456 F468 F470

Mt

V15 V16 V28 V31 V38 V71 V73 V81 V82 V110 V130 V215 V218 V233 V269 V273 V299 V302 V325 V331 V339 V357 V408 V411 V449 V464 V469 V472 F2 F3 F9 F10 F20 F43 F95 F131 F140 F148 F152 F223 F405

GM

V8 V20 V143 V152 V159 V163 V176 V199 V214 V237 V321 V350 V385 V388 V401 V440 V462 V467 V474 F4 F23 F44 F64 F70 F73 F74 F80 F100 F137 F146 F187 F289 F331 F351 F364 F392 F395 F435 F438 F441 F469 F471 F498 F509 F519 F532 F536

GF

V62 V67 V119 V121 V128 V203 V263 V266 V353 V384 V426 V449 V456 V473 V552 F1 F27 F63 F68 F79 F84 F105 F123 F133 F155 F197 F201 F220 F231 F238 F239 F250 F257 F264 F272 F287 F406 F417 F465 F477 F487 F510 F511 F537 F548 F550

PK

V16 V17 V22 V23 V30 V31 V32 V37 V39 V48 V52 V56 V59 V65 V82 V85 V92 V94 V101 V135 V150 V168 V170 V196 V221 V274 V277 V302 V303 V305 V316 V319 V327 V328 V339 V347 V349 V367 F2 F3 F9 F49 F75 F95 F125 F140

PS

V17 V21 V22 V31 V32 V37 V38 V44 V48 V56 V59 V65 V85 V94 V116 V135 V145 V150 V168 V170 V180 V218 V221 V273 V274 V277 V299 V301 V304 V305 V311 V316 V319 V325 V328 V377 V386 V400 V463 V464 V469 V471 V475 V479 V515 V516 V565 F3 F9 F45 F75 F95 F141 F165 F208 F223 F280 F372 F405 F564

MDS

V21 V22 V135 V195 V219 V382 V484 V563 F12 F83 F95 F125 F493 F494

APS

V7 V29 V41 V89 V103 V113 V120 V168 V183 V189 V196 V217 V242 V260 V267 V341 V342 V344 V377 V422 V502 V523 V540 F4 F43 F76 F104 F137 F157 F220 F239 F306 F312 F349 F440 F495 F496 F500 F504

AAS

V172 V264 V288 V362 V387 V487 V489 V511 V527 V544 F266 F429 F501

ESCALAS DE CONTENIDO

ANX

V15 V30 V31 V39 V170 V196 V273 V290 V299 V301 V305 V339 V408 V415 V463 V469 V509 V556 F140 F208 F223 F405 F496

FRS

V154 V317 V322 V329 V334 V392 V395 V397 V435 V438 V441 V447 V458 V468 V471 V555 F115 F163 F186 F385 F401 F453 F462

OBS

V55 V87 V135 V196 V309 V313 V327 V328 V394 V442 V482 V491 V497 V509 V547 V553

DEP

V38 V52 V56 V65 V71 V82 V92 V130 V146 V215 V234 V246 V277 V303 V306 V331 V377 V399 V400 V411 V454 V506 V512 V516 V520 V539 V546 V554 F3 F9 F75 F95 F388

HEA

V11 V18 V28 V36 V40 V44 V53 V59 V97 V101 V111 V149 V175 V247 F20 F33 F45 F47 F57 F91 F117 F118 F141 F142 F159 F164 F176 F179 F181 F194 F204 F224 F249 F255 F295 F404

BIZ

V24 V32 V60 V96 V138 V162 V198 V228 V259 V298 V311 V316 V319 V333 V336 V355 V361 V466 V490 V508 V543 V551 F427

ANG

V29 V37 V116 V134 V302 V389 V410 V414 V430 V461 V486 V513 V540 V542 V548 F564

CYN

V50 V58 V76 V81 V104 V110 V124 V225 V241 V254 V283 V284 V286 V315 V346 V352 V358 V374 V399 V403 V445 V470 V538

ASP

V26 V35 V66 V81 V84 V104 V105 V110 V123 V227 V240 V248 V250 V254 V269 V283 V284 V374 V412 V418 V419 F266

TPA

V27 V136 V151 V212 V302 V358 V414 V419 V420 V420 V423 V430 V437 V507 V510 V523 V531 V535 V541 V545

LSE

V70 V73 V130 V235 V326 V369 V376 V380 V411 V421 V450 V457 V475 V476 V483 V485 V503 V504 V519 V526 V562 F61 F78 F109

SOD

V46 V158 V167 V185 V265 V275 V281 V337 V349 V367 V479 V480 V515 F49 F86 F262 F280 F321 F340 F353 F359 F360 F363 F370

FAM

V21 V54 V145 V190 V195 V205 V256 V292 V300 V323 V378 V379 V382 V413 V449 V478 V543 V550 V563 V567 F83 F125 F217 F383 F455

WRK

V15 V17 V31 V54 V73 V98 V135 V233 V243 V299 V302 V339 V364 V368 V394 V409 V428 V445 V464 V491 V505 V509 V517 V525 V545 V554 V559 V566 F10 F108 F318 F521 F561

TRT

V22 V92 V274 V306 V364 V368 V373 V375 V376 V377 V391 V399 V482 V488 V491 V495 V497 V499 V500 V504 V528 V539 V554 F493 F494 F501

SUBESCALAS DE LAS ESCALAS CLÍNICAS

Harris & Lingoes

D1

V31 V38 V39 V46 V56 V73 V92 V127 V130 V146 V147 V170 V175 V215 V233 F2 F9 F43 F49 F75 F95 F109 F118 F140 F148 F178 F188 F189 F223 F260 F267 F330

D2

V38 V46 V170 V233 F9 F29 F37 F49 F55 F76 F134 F188 F189 F212

D3

V18 V117 V175 V181 F2 F20 F45 F141 F142 F143 F148

D4

V15 V31 V38 V73 V92 V147 V170 V233 F9 F10 F43 F75 F109 F165 F188

D5

V38 V56 V92 V127 V130 V146 V170 V215 F75 F95

Hy1

F129 F161 F167 F185 F243 F265

Hy2

V230 F26 F58 F76 F81 F98 F110 F124 F151 F213 F241 F263

Hy3

V31 V39 V65 V175 V218 F2 F3 F9 F10 F45 F95 F125 F141 F148 F152

Hy4

V11 V18 V40 V44 V101 V172 F8 F47 F91 F159 F164 F173 F176 F179 F208 F224 F249

Hy5

F7 F14 F29 F115 F116 F135 F157

Pd1

V21 V54 V195 V202 V288 F83 F125 F214 F217

Pd2

V35 V105 F34 F70 F129 F160 F263 F266

Pd3

F70 F129 F158 F167 F185 F243

Pd4

V17 V22 V42 V56 V82 V99 V113 V219 V225 V259 F12 F129 F157

Pd5

V31 V32 V52 V56 V71 V82 V89 V94 V113 V264 F9 F95

Pa1

V17 V22 V42 V99 V113 V138 V144 V145 V162 V234 V259 V305 V333 V336 V355 V361 F314

Pa2

V22 V146 V271 V277 V285 V307 V334 F100 F244

Pa3

V16 F81 F98 F104 F110 F283 F284 F286 F315

Sc1

V17 V21 V22 V42 V46 V138 V145 V190 V221 V256 V277 V281 V291 V292 V320 V333 F90 F276 F278 F280 F343

Sc2

V65 V92 V234 V273 V303 V323 V329 V332 F9 F210 F290

Sc3

V31 V32 V147 V170 V180 V299 V311 V316 V325 F165

Sc4

V31 V38 V48 V65 V92 V233 V234 V273 V299 V303 V325 F9 F210 F290

Sc5

V23 V85 V168 V182 V218 V242 V274 V320 V322 V329 V355

Sc6

V23 V32 V44 V168 V182 V229 V247 V252 V296 V298 V307 V311 V319 V355 F91 F106 F177 F179 F255 F295

Ma1

V131 V227 V248 V250 V269 F263

Ma2

V15 V85 V87 V122 V169 V206 V218 V242 V244 F100 F106

Ma3

V155 V200 V220 F93 F136 F158 F167 F243

Ma4

V13 V50 V55 V61 V98 V145 V190 V211 V212

SUBESCALAS Si (Escala 0)

Si1

V158 V161 V167 V185 V243 V265 V275 V289 F49 F262 F280 F321 F342 F360

Si2

V337 V367 F86 F340 F353 F359 F363 F370

Si3

V31 V56 V104 V110 V135 V284 V302 V308 V326 V328 V338 V347 V348 V358 V364 V368 V369

ESCALAS ADICIONALES DE VALIDEZ

Fb back

V281 V291 V303 V311 V317 V319 V322 V323 V329 V332 V333 V334 V387 V395 V407 V431 V450 V454 V463 V468 V476 V478 V484 V489 V506 V516 V517 V520 V524 V525 V526 V528 V530 V539 V540 V544 V555 F383 F404 F501

F(p)

V66 V114 V162 V193 V216 V228 V252 V270 V282 V291 V294 V322 V323 V336 V371 V387 V478 V555 F51 F77 F90 F93 F102 F126 F192 F276 F501

DS - Dissimulation

V11 V17 V18 V19 V22 V28 V30 V31 V40 V42 V44 V54 V61 V72 V81 V85 V92 V111 V166 V190 V195 V205 V221 V252 V258 V268 V274 V287 V292 V294 V300 V307 V310 V320 V329 V362 V362 V395 V412 V419 V421 V431 V433 V435 V436 V451 V458 V463 F57 F75 F83 F108 F125 F188 F278 F318 F404 F429

DS-r - Dissimulation-Revised

V11 V18 V22 V28 V30 V31 V40 V44 V81 V85 V92 V111 V205 V221 V274 V292 V300 V320 V329 V362 V395 V419 V433 V451 V458 V463 F57 F75 F83 F108 F278 F318

S - Superlative

V121 V148 V184 V194 V534 V560 F15 F50 F58 F76 F81 F87 F89 F104 F110 F120 F123 F154 F196 F205 F213 F225 F264 F279 F284 F290 F302 F337 F341 F346 F352 F373 F374 F403 F420 F423 F428 F430 F433 F442 F445 F449 F461 F486 F487 F523 F538 F542 F545 F547

Sd – Wiggins Social Desirability

V25 V49 V80 V100 V131 V133 V184 V194 V201 V206 V207 V211 V220 V249 V257 V263 V345 V351 V354 V356 V366 V402 V416 V439 F29 F41 F77 F93 F183 F203 F232 F326 F341

So – Edwards Social Desirability

V8 V20 V78 V95 V152 V186 V318 V335 F31 F39 F48 F54 F127 F136 F146 F158 F168 F172 F221 F238 F243 F270 F273 F288 F289 F299 F300 F301 F306 F320 F324 F338 F349 F368 F415 F420 F469

VRIN – Variable Response Inconsistency

Sumar un punto por cada par asociado coincidente:

V3-V39	V6-F90	F6-V90	F9-F56
V28-F59	V31-F299	F32-V316	V40-V176
V46-F265	V48-V184	V49-F280	V73-F377
V81-F284	F81-V284	V83-V288	V84-F105
V86-F359	F95-V388	F99-V138	V103-F344
V110-F374	F110-V374	V116-F430	V125-V195
F125-F195	F135-V482	V136-F507	F136-V507
F152-F464	V161-F185	F161-V185	F165-F565
V166-F268	F166-V268	V167-F243	F167-V243
F196-V415	V199-F467	F199-V467	V226-F267
F259-V333	F262-F275	V290-F556	F290-V556
F339-V394	V349-F515	F349-V515	F350-V521
V353-F370	F353-V370	F364-V554	F369-V421
V372-F405	F372-V405	V380-F562	V395-F435
F395-V435	V396-F403	F396-V403	V411-F485
F411-V485	V472-F533	F472-V533	V491-F509
V506-F520	F506-V520	V513-F542	

TRIN – True Response Inconsistency

Sumar un punto por cada par asociado coincidente:

V3-V39	V12-V166	V40-V176
V48-V184	V63-V127	V65-V95
V73-V239	V83-V288	V99-V314
V125-V195	V209-V351	V359-V367
V377-V534	V556-V560	

Restar un punto por cada par asociado coincidente:

F9-F56	F65-F95	F125-F195
F140-F196	F152-F464	F165-F565
F262-F275	F265-F360	F359-F367

Finalmente, sumar 9 puntos al resultado.

12. – TABLAS DE CONVERSIÓN DE PUNTAJES BRUTOS A PUNTAJES

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE PSICOLOGIA
Cátedra I de Teoría y Técnica de Exploración y Diagnóstico Mod. I. (Prof. Dra. Mikulic)

Escala básicas (nota: M = Masculino, F = Femenino)

	L		F		K		1-Hs		2-D		3-Hy		4-Pd		5-Mf		6-Pa		7-Pt		8-Sc		9-Ma		0-Si	
pts brutos	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
0	35	33	36	37																						
1	39	38	39	41																						
2	43	43	42	44			30										30	30								
3	48	47	45	48			31										31	31								
4	52	52	48	51			31										32	32								
5	56	57	51	55			32										34	34								
6	61	62	55	58	30	30	33	30									37	37								
7	65	66	58	61	33	32	35	33								120	39	39							30	
8	70	71	61	65	35	35	37	35			30					118	42	42							31	30
9	74	76	64	68	37	37	39	38	30		31	30				116	46	45					30	30	32	31
10	78	81	67	72	39	39	42	40	32	30	32	31				114	49	49					31	31	33	32
11	83	86	70	75	41	41	45	43	34	32	33	32	30			111	53	52					33	33	34	33
12	87	90	73	79	43	43	48	46	36	34	34	32	31	30		109	57	56			30		35	35	36	34
13	91	95	76	82	45	46	51	49	38	36	35	34	33	32		106	61	59			31	30	36	37	37	35
14	96	100	79	85	47	48	54	51	40	38	37	35	34	34		104	64	63	30		32	31	38	39	38	36
15	100	105	82	89	49	50	57	54	42	40	38	36	35	36		101	68	67	31		33	32	39	41	39	37
16			85	92	51	52	59	57	45	42	40	38	37	37	30	99	72	70	32	30	34	33	41	43	40	38
17			89	96	54	54	62	59	47	44	42	39	39	39	32	96	75	74	33	31	35	34	43	45	41	40
18			92	99	56	56	64	61	50	46	43	41	40	41	34	94	79	78	34	32	36	36	45	47	42	41
19			95	103	58	59	66	63	52	47	45	43	42	43	36	92	83	81	36	34	37	37	47	49	44	42
20			98	106	60	61	68	65	54	49	47	45	44	45	38	89	86	85	37	35	39	39	49	51	45	43
21			101	109	62	63	70	67	57	51	50	47	46	47	40	87	90	89	39	37	40	41	51	53	46	44
22			104	113	64	65	73	69	59	53	52	49	48	49	42	84	94	92	41	39	42	42	53	56	47	45
23			107	116	66	67	75	71	61	55	54	51	50	51	44	82	97	96	43	40	44	44	56	59	48	46
24			110	120	68	70	77	74	62	57	57	54	52	53	46	79	101	100	44	42	45	46	59	62	49	47
25			113		70	72	79	76	64	59	59	56	54	55	48	77	105	103	47	44	47	48	62	65	50	48
26			116		72	74	81	78	66	62	61	58	57	58	50	74	108	107	49	47	49	50	65	68	51	49
27			119		75	76	84	80	68	64	64	61	59	60	52	72	112	111	51	49	51	52	69	71	53	50
28			120		77	78	86	82	70	66	66	63	62	63	54	69	116	114	53	51	53	53	72	74	54	51
29					79	81	88	84	72	68	69	65	64	66	56	67	119	118	55	53	55	55	75	76	55	52
30					81	83	90	86	74	70	71	68	67	68	58	65	120	120	57	55	56	57	78	79	56	53
31							92	88	76	72	74	70	69	71	60	62			59	57	58	59	81	82	57	54
32							94	90	78	75	76	73	72	73	62	60			62	59	60	60	85	85	58	55
33							97	92	80	77	79	75	74	76	64	57			64	61	62	62	88	88	59	56
34							99	95	81	79	81	77	77	79	66	55			66	62	63	63	91	91	60	58
35							101	97	83	81	84	80	79	81	68	52			68	64	65	65	94	94	62	59
36							103	99	85	83	86	82	82	84	70	50			70	66	67	66	98	97	63	60
37							105	101	87	86	89	84	84	87	72	47			72	68	69	67	101	100	64	61
38							108	103	89	88	91	87	87	89	74	45			74	70	70	69	104	103	65	62
39							110	105	91	90	94	89	90	92	76	43			77	72	72	70	107	106	66	63
40							112	107	93	92	96	92	92	94	78	40			79	73	74	72	110	109	67	64
41							114	109	95	94	99	94	95	97	79	38			81	75	75	73	114	112	68	65
42							116	111	97	96	101	96	97	100	81	35			83	77	77	75	117	115	70	66
43							119	113	98	99	104	99	100	102	83	33			85	79	79	76	120	118	71	67
44							120	116	100	101	106	101	102	105	85	30			87	81	81	78		120	72	68
45								118	102	103	109	104	105	107	87				89	83	82	79			73	69
46								120	104	105	111	106	107	110	89				91	84	84	81			74	70
47									106	107	114	108	110	113	91				94	86	86	82			75	71
48									108	109	116	111	112	115	93				96	88	87	84			76	72
49									110	112	119	113	115	118	95				98	90	89	85			77	73
50									112	114	120	115	117	120	97				100	92	91	87			79	74
51									114	116		118	120		99				102	94	93	88			80	75
52									115	118		120			101				104	95	94	90			81	77
53									117	120					103				106	97	96	91			82	78
54									119						105				109	99	98	93			83	79
55									120						107				111	101	99	94			84	80
56															109				113	103	101	96			85	81
57																			115	105	103	97			86	82
58																			117	106	105	99			88	83
59																			119	108	106	100			89	84
60																			120	110	108	102			90	85
61																				112	110	103			91	86
62																				114	111	105			92	87
63																				115	113	106			93	88
64																				117	115	108			94	89
65																				119	117	109			96	90
66																				120	118	111			97	91
67																					120	112			98	92
68																						113			99	93
69																						115			100	95
70																						116				
71																						118				
72																						119				
73																						120				

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE PSICOLOGIA
Cátedra I de Teoría y Técnica de Exploración y Diagnóstico Mod. I. (Prof. Dra. Mikulic)

	Escalas adicionales de validez								Escalas suplementarias																													
	Fb		F(p)		VRIN		TRIN		A		R		Es		MAC-R		O-H		Do		Re		Mt		GM		GF		PK		PS		MDS		APS		AAS	
pts brutos	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
0	42	42	41	41	31	30	114F	118F	36	35													32	32					37	37	37	37	37	38	30	30	36	39
1	46	46	48	49	34	34	107F	111F	37	37													34	34					38	39	38	38	42	42	30	30	41	44
2	51	50	56	57	38	38	99F	103F	39	38													36	35					40	40	39	39	46	46	30	30	46	50
3	55	54	63	65	42	42	92F	95F	40	39													37	37					42	42	41	40	51	50	30	30	51	56
4	59	58	70	73	46	46	85F	88F	42	40													39	38					43	43	42	41	56	55	30	30	56	61
5	63	62	77	81	50	50	78F	80F	43	42													40	40					45	45	43	42	60	59	30	30	60	67
6	67	66	84	89	54	54	71F	73F	44	43	30						30						42	41					47	46	44	43	65	63	30	30	65	73
7	71	70	94	97	57	58	64F	65F	46	44	32						31						43	42					48	48	46	45	69	68	30	30	70	78
8	75	74	99	105	61	62	57F	58F	47	45	34	30					35	30					45	44					50	49	47	46	74	72	30	30	75	84
9	79	77	106	113	65	66	50	50	49	47	36	31					38	33					46	45					52	51	48	47	79	76	30	30	80	90
10	83	81	113	120	69	70	57T	58T	50	48	39	33					41	37	30	30			48	47					53	52	49	48	83	80	30	30	85	95
11	87	85	120	120	73	74	65T	65T	51	49	41	36				30	45	41	31	32			50	48					55	54	51	49	88	85	30	30	90	101
12	92	89			76	78	72T	73T	53	50	43	39			30	31	48	44	34	35	30		51	50					57	55	52	50	92	89	30	30	95	107
13	96	93			80	82	79T	80T	54	52	45	41			32	34	52	48	38	39	32		53	51					58	57	53	51	97	93	30	30	100	112
14	100	97			84	86	86T	88T	56	53	47	44			34	37	55	52	41	42	34	30	54	52					60	58	54	52	102	98	30	30		
15	104	101			88	90	93T	95T	57	54	50	46			37	40	59	55	45	46	37	32	56	54					62	60	56	54			30	30		
16	108	105			92	94	100T	103T	58	56	52	49			39	42	62	59	48	49	39	35	57	55					63	61	57	55			30	31		
17	112	108			96	98	107T	111T	60	57	54	52			41	45	65	63	51	53	42	38	59	57		31			65	63	58	56			33	33		
18	116	112			99	102	114T	118T	61	58	56	54			44	48	69	66	55	56	45	41	60	58		32	30		67	64	59	57			35	36		
19	120	116			103	106	120T	120T	63	59	58	57			46	50	72	70	58	59	47	44	62	60		34	32		68	66	61	58			38	39		
20		120			107	110			64	61	61	60			48	53	76	74	61	63	50	47	64	61		36	34		70	68	62	59			41	42		
21					111	114			65	62	63	62			50	56	79	77	65	66	52	50	65	62		37	37		72	69	63	60			44	44		
22					115	118			67	63	65	65			53	59	82	81	68	70	55	53	67	64		39	39		73	71	64	61			46	47		
23					118	120			68	64	67	67			55	61	86	85	72	73	57	56	68	65		41	41		75	72	66	62			49	50		
24					120				70	66	69	70		30	57	64	89	88	75	77	60	59	70	67		42	43		77	74	67	63			52	52		
25									71	67	72	73		31	60	67	93	92	78	80	63	62	71	68		44	45		78	75	68	64			54	55		
26									73	68	74	75		33	62	69	96	96			65	65	73	70		45	47		80	77	69	66			57	58		
27									74	69	76	78		35	64	72	99	99			68	68	74	71		47	49		82	78	71	67			60	60		
28									75	71	78	81	30	37	66	75	103	103			70	71	76	72	30	49	51		83	80	72	68			63	63		
29									77	72	81	83	31	39	69	78					73	74	77	74	31	50	54	30	85	81	73	69			65	66		
30									78	73	83	86	34	41	71	80					76	77	79	75	34	52	56	32	87	83	74	70			68	69		
31									80	75	85	88	36	43	73	83							81	77	36	54	58	35	88	84	76	71			71	71		
32									81	76	87	91	38	45	76	86							82	78	38	55	60	37	90	86	77	73			73	74		
33									82	77	89	94	40	47	78	88							84	80	40	57	62	40	92	87	78	74			76	77		
34									84	78	92	96	42	49	80	91							85	81	42	58	64	43	93	89	79	75			79	79		
35									85	80	94	99	45	51	82	94							87	82	45	60	66	45	95	90	81	76			82	82		
36									87	81	96	102	47	53	85	96							88	84	47	62	68	48	97	92	82	77			84	85		
37									88	82	98	104	49	55	87	99							90	85	49	63	71	50	98	93	83	78			87	87		
38									89	83			51	57	89	102							91	87	51	65	73	53	100	95	84	79			90	90		
39									91	85			54	59	92	105							93	88	53	67	75	56	102	96	86	80			92	93		
40													56	61	94	107							95	90	56	68	77	58	103	98	87	81						
41													58	64	96	110							96	91	58	70	79	61	105	100	88	83						
42													60	66	98	113									60	71	81	63	107	101	89	84						
43													63	68	101	115									62	73	83	66	108	103	91	85						
44													65	70	103	118									64	75	85	69	110	104	92	86						
45													67	72	105	120									66	76	88	71	112	106	93	87						
46													69	74	108										69	78	90	74	113	107	94	88						
47													72	76	110										71	80					96	89						
48													74	78	112																97	90						
49													76	80	114																98	92						
50													78	82																	99	93						
51													81	84																	101	94						
52													83	86																	102	95						
53																															103	96						
54																															104	97						
55																															106	98						
56																															107	99						
57																															108	100						
58																															110	102						
59																															111	103						
60																															112	104						

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE PSICOLOGIA
Cátedra I de Teoría y Técnica de Exploración y Diagnóstico Mod. I. (Prof. Dra. Mikulic)

Escalas de contenido

	ANX		FRS		OBS		DEP		HEA		BIZ		ANG		CYN		ASP		TPA		LSE		SOD		FAM		WRK		TRT	
pts brutos	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
0	35	34	35	31	33	32	36	34	33	32	39	39	32	31	32	32	30	33	30	30	35	35	32	32	33	32	33	31	35	35
1	39	37	41	35	37	37	41	39	37	36	46	47	36	36	35	35	34	36	32	33	41	40	35	35	37	36	36	34	39	39
2	42	40	45	38	41	41	45	42	41	40	51	52	40	39	38	38	37	39	36	36	45	44	39	39	41	39	39	37	43	43
3	45	43	48	41	44	44	48	45	44	43	54	56	43	42	40	40	40	42	38	38	48	47	41	41	44	42	41	40	47	46
4	47	45	51	43	47	46	51	48	48	46	57	58	46	45	41	42	42	45	41	41	51	49	43	44	47	45	44	43	49	49
5	50	47	54	46	50	48	53	50	51	49	60	61	48	47	43	44	44	47	43	43	53	51	45	46	50	47	46	45	52	51
6	52	49	57	48	53	50	55	52	53	51	63	64	50	50	44	46	46	49	44	45	55	52	47	48	52	50	48	46	54	53
7	53	51	60	51	56	53	56	54	56	53	67	67	53	53	46	47	47	52	46	48	57	54	49	49	55	52	50	48	56	55
8	55	53	64	53	59	56	58	55	58	55	70	70	56	56	47	48	49	54	48	50	59	55	50	51	57	55	52	50	59	57
9	57	55	67	56	63	59	59	57	60	57	74	73	59	60	48	50	51	56	50	53	62	57	52	52	60	57	54	51	61	59
10	60	56	70	59	66	63	61	58	62	59	77	76	63	64	49	51	53	59	53	56	64	60	54	54	63	60	56	52	64	61
11	62	59	74	62	70	67	63	60	64	61	81	79	67	68	51	53	55	63	56	60	67	62	55	56	66	62	57	54	66	64
12	65	61	77	65	73	71	65	62	66	63	84	81	70	72	52	54	58	66	60	64	70	65	58	58	68	65	59	55	69	67
13	67	64	80	68	77	75	66	63	68	64	88	84	74	76	54	56	62	69	64	69	72	68	60	60	71	68	61	57	71	69
14	70	66	84	72	80	79	68	65	70	66	91	87	78	80	56	58	65	72	68	73	75	70	63	63	74	70	63	59	74	72
15	72	69	87	75	84	83	70	67	72	68	94	90	82	84	59	61	69	75	72	77	77	73	65	65	77	73	65	61	76	74
16	75	71	90	78	87	87	71	68	74	70	98	93	86	88	62	64	72	79	77	81	80	76	68	68	80	75	67	63	79	77
17	77	74	93	81			73	70	76	72	101	96			65	67	76	82	81	86	83	78	71	70	82	78	68	65	81	79
18	80	76	97	85			75	72	78	74	105	99			68	69	79	85	85	90	85	81	73	72	85	81	70	67	84	82
19	82	79	100	88			77	73	80	76	108	102			71	72	83	88	89	94	88	84	76	75	88	83	72	69	86	84
20	85	81	103	91			78	75	81	77	112	105			74	75	87	91			91	86	78	77	91	86	74	71	89	87
21	87	84	107	94			80	77	83	79	115	108			77	77	90	94			93	89	81	80	94	89	76	73	91	89
22	90	86	110	98			82	78	85	81	119	110			80	80	94	98			96	92	84	82	97	91	78	76	94	92
23	92	89	113	101			83	80	87	83	120	113			83	83					98	94	86	84	99	94	79	78	96	95
24							85	82	89	85											101	97	89	87	102	96	81	80	99	97
25							87	83	91	87															105	99	83	82	101	100
26							88	85	93	89																	85	84	104	102
27							90	87	95	90																	87	86		
28							92	88	97	92																	89	88		
29							94	90	99	94																	90	90		
30							95	92	101	96																	92	92		
31							97	93	103	98																	94	95		
32							99	95	105	100																	96	97		
33							100	97	106	101																	98	99		
34									108	103																				
35									110	105																				
36									112	107																				

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - FACULTAD DE PSICOLOGIA
Cátedra I de Teoría y Técnica de Exploración y Diagnóstico Mod. I. (Prof. Dra. Mikulic)

Subescalas de las escalas básicas

	D1		D2		D3		D4		D5		Hy1		Hy2		Hy3		Hy4		Hy5		Pd1		Pd2		Pd3		Pd4		Pd5	
pts brutos	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
0	32	32			30	30	38	38	40	37	30	30			38	39	38	37	30	30	38	38	30	30	30	30	30	30	34	34
1	35	34	30		35	34	43	43	45	42	34	35	30		43	43	43	41	33	31	45	44	33	38	33	35	35	33	38	39
2	37	37	32	30	43	41	48	48	51	47	40	40	32	30	48	47	48	45	40	39	51	50	40	46	39	41	40	38	43	43
3	40	39	37	35	51	48	53	52	57	53	45	45	36	34	52	51	52	49	48	46	58	56	47	53	45	47	45	44	48	48
4	42	41	43	41	59	56	58	57	62	58	51	51	40	38	57	55	57	53	55	54	65	62	53	61	51	52	50	49	53	53
5	45	44	48	46	67	63	62	61	68	63	56	56	43	42	61	59	62	57	63	62	71	68	60	69	57	58	56	54	58	58
6	48	46	54	51	75	70	67	66	74	68	61	61	47	46	66	63	67	61	71	70	78	74	67	77	63	64	61	60	63	63
7	50	48	59	57	83	78	72	70	79	73			51	50	70	67	72	65	78	77	84	80	73	84			66	65	67	68
8	53	51	65	62	91	85	77	75	85	78			55	55	75	71	77	69			91	86	80	92			71	70	72	73
9	56	53	70	68	100	93	82	79	91	83			59	59	79	75	82	73			98	92					77	75	77	77
10	58	56	76	73	108	100	86	84	96	89			63	63	84	79	86	77									82	81	82	82
11	61	58	81	79	116	107	91	88					67	67	88	83	91	81									87	86	87	87
12	64	60	87	84			96	93					71	71	93	87	96	85									92	91	91	92
13	66	63	92	90			101	97							97	91	101	89									98	97		
14	69	65	98	95			105	102							102	95	106	93												
15	71	67					110	106							106	99	111	97												
16	74	70															115	101												
17	77	72															120	105												
18	79	75																												
19	82	77																												
20	85	79																												
21	87	82																												
22	90	84																												
23	93	86																												
24	95	89																												
25	98	91																												
26	100	94																												
27	103	96																												
28	106	98																												
29	108	101																												
30	111	103																												
31	114	105																												
32	116	108																												

	Pa1		Pa2		Pa3		Sc1		Sc2		Sc3		Sc4		Sc5		Sc6		Ma1		Ma2		Ma3		Ma4		Si1		Si2		Si3	
pts brutos	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
0	40	39	34	34	30	30	39	38	40	40	42	43	39	39	40	40	41	41	35	37			30	30	30	31	36	36	37	37		
1	46	45	41	40	32	31	43	42	50	49	48	49	44	44	47	46	46	45	42	45	30	30	35	37	37	37	39	38	41	42	38	38
2	52	51	48	46	36	36	47	46	59	58	54	55	49	49	54	53	51	50	50	54	34	35	41	43	43	43	42	41	45	47	41	41
3	58	57	55	53	41	41	51	50	69	67	60	61	55	54	61	59	55	54	58	62	39	40	47	50	50	49	45	44	49	51	44	44
4	64	63	62	59	46	45	55	53	78	76	66	67	60	59	68	65	60	59	66	70	44	45	53	56	56	56	48	46	54	56	47	47
5	70	69	69	65	51	50	59	57	88	86	72	74	65	65	75	72	65	63	74	79	49	50	59	62	63	62	51	49	58	60	50	49
6	76	75	76	72	56	55	64	61	98	95	78	80	71	70	82	78	70	68	81	87	53	55	65	69	69	68	53	52	62	65	53	52
7	82	81	82	78	60	60	68	65	107	104	84	86	76	75	89	85	75	72			58	60	71	75	76	74	56	55	67	69	56	55
8	88	87	89	84	65	65	72	69	117	113	90	92	82	80	96	91	80	77			63	65	77	82	82	80	59	57	71	74	59	58
9	94	93	96	91	70	69	76	73	120	120	96	98	87	85	103	97	85	81			68	70			89	86	62	60			62	60
10	100	99					80	77			103	104	92	90	110	104	90	86			73	75					65	63			65	63
11	106	105					84	81					98	95	117	110	95	91			78	80					68	65			68	66
12	112	111					88	84					103	100			99	95									71	68			71	69
13	118	117					92	88					109	106			104	100									74	71			74	72
14	120	120					97	92					114	111			109	104									77	73			77	74
15							101	96									114	109													80	77
16							105	100									119	113													83	80
17							109	104									120	118													86	83
18							113	108										120														
19							117	111																								
20							120	115																								
21								119																								

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Archer, R.P., Buffington-Vollum, J.K., Vauter Stredny, R., Handel, R.W. (2006). A Survey of Psychological Test Use Patterns Among Forensic Psychologists. *Journal of Personality Assessment, Vol. 87, No. 1*, 84-94.

- Archer, R.P. (2006). *Forensic Uses of Clinical Assessment Instruments*. Mahwah, New Jersy: LEA, Inc.

- Bow, J.N., Flens, J.R., Gould, J.W., Greenhut, D. (2005). Testing in Child Custody Evaluations- Selection, Usage, and Daubert Admissibility. A Survey of Psychologists. *Journal of Forensic Psychology Practice, Vol. 6, 2*, 17-38.

- Brenlla, M.E., Maristany, M.P., y Diuk, L.W. (1992). *Evaluación de la personalidad. Aportes del MMPI-2*. Buenos Aires: Lugar Editorial.

- Butcher, J. N., Dahlstrom, W. G., Graham, J. R., Tellegen, A., & Kaemmer, B. (1989). *Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2): Manual for administration and scoring*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

- Butcher, J. N. & Williams, C. L. (2000). *Essentials of MMPI-2 and MMPI-A interpretation* (2nd ed.) Minneapolis: University of Minnesota Press.

- Casullo, M.M. (1999). *Aplicaciones del MMPI-2 en los ámbitos clínico, forense y laboral.* Buenos Aires: Paidós.

- Friedman, A., Lewak, R., Nichols, D., Webb, J. (2001). *Psychological Assessment with the MMPI-2*. Hillsdale, NJ: LEA, Inc.

- Gómez Dupertuis, D. (1998). *La evaluación de la personalidad: El MMPI – II. (Hathaway, S.; McKinley, J. MMPI-2 Inventario Multifacético de Personalidad de Minnesota; Traducción Gómez Dupertuis, D.) Ficha Nº 17.* Buenos Aires: Departamento de Publicaciones Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires.

- Graham, J.R. (2005). *MMPI-2: Assessing Personality and Psychopathology*. Oxford: Oxford University Press.

- Greene, R. (2000). *The MMPI-2: An interpretive manual*. Needham Heights: Allyn and Bacon.

- Hathaway, S.R., & McKinley, J.C. (1940). A multiphasic personality schedule (Minnesota): I. Construction of the schedule. *Journal of Psychology, 10*, 249-254.

- Hathaway, S.R., & McKinley, J.C. (1942). *The Minnesota Multiphasic Personality Schedule*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

- Watkins, C.E., Campbell, V.L., Nieberding, R., y Hallmark, R. (1995). *Professional Psychological Research and Practice*, *26*, 54-60.

ANEXO

CUADERNILLO Y HOJA DE RESPUESTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL MMPI-2

Versión revisada por Isidro Sanz (2008)

NO HAGA MARCAS EN ESTE CUADERNILLO

RESPONDA EN SU HOJA DE RESPUESTAS

INVENTARIO MMPI-2

Este cuadernillo contiene una serie de frases. Lea cada una y conteste si, **aplicada a Usted mismo, esa frase es Verdadera o Falsa**. Para contestar, **rellene el círculo** V (verdadero) o F (falso) correspondiente a cada frase **en su hoja de respuestas**.

Por ejemplo, supongamos que a Ud. le disguste la música rock, y le diviertan los teleteatros, y supongamos que las dos primeras frases dijeran:

1. *No me gusta la música rock.*
2. *Me aburren los teleteatros.*

Ud. contestaría en su hoja de respuestas poniendo Verdadero a la primera (rellenando el círculo izquierdo del número 1), y Falso a la segunda, (rellenando el círculo derecho del número 2), así:

	V	**F**
1	●	o
2	o	●

Si lo que dice una frase describe cómo es o cómo piensa Usted, entonces es Verdadera.

TRATE DE CONTESTAR **TODAS** LAS FRASES.

Fíjese bien en el número de la frase al contestar en la hoja de respuestas.

No hay respuestas correctas ni incorrectas.

---

1. Me gustan las revistas de mecánica.

2. Tengo buen apetito.

3. Me despierto fresco/a y descansado/a casi todas las mañanas.

4. Creo que me gustaría el trabajo de bibliotecario/a.

5. Me despierto fácilmente con el ruido.

6. Mi padre es un buen hombre, o (si su padre murió) mi padre era un buen hombre.

7. Me gusta leer artículos sobre crímenes en el periódico.

8. Por lo general mis manos y pies están lo suficientemente calientes.

9. Mi vida diaria está llena de cosas que me resultan interesantes.

10. Actualmente tengo tanta capacidad de trabajo como antes.

11. Me parece tener un nudo en la garganta la mayor parte del tiempo.

12. Mi vida sexual es satisfactoria.

13. La gente debería tratar de comprender sus sueños y guiarse por ellos o tomarlos como avisos.

14. Me gustan los cuentos de detectives o de misterio.

15. Trabajo bajo una tensión muy grande.

16. De vez en cuando pienso en cosas demasiado malas como para hablar de ellas.

17. Estoy seguro/a de que la vida es dura para mí.

18. Sufro de ataques de náuseas y vómitos.

19. Cuando acepto un nuevo empleo me gusta averiguar a quién debo "caerle bien".

20. Muy raras veces sufro de estreñimiento (sequedad de vientre).

21. A veces he sentido muchísimos deseos de abandonar mi hogar.

22. Nadie parece comprenderme.

23. A veces me dan ataques de risa y llanto que no puedo controlar.

24. A veces espíritus malos se posesionan de mí.

25. Me gustaría ser cantante.

26. Cuando estoy en problemas creo que lo mejor es callarme la boca.

27. Cuando alguien me hace un mal, siento que debo devolvérselo si es que puedo, sólo por cuestión de principios.

28. Tengo problemas del estómago varias veces a la semana.

29. A veces siento ganas de decir malas palabras.

30. Frecuentemente tengo pesadillas.

31. Me cuesta concentrarme en una tarea o trabajo.

32. He tenido experiencias muy peculiares y extrañas.

33. Raras veces me preocupo por mi salud.

34. Nunca me he visto envuelto/a en problemas a causa de mi conducta sexual.

35. Algunas veces cuando era joven robé cosas.

36. Tengo tos la mayor parte del tiempo.

37. A veces me dan ganas de destrozar cosas.

38. He tenido períodos de días, semanas, o meses en los cuales no podía ocuparme de nada por no tener el ánimo para hacerlo.

39. Mi sueño es sobresaltado e intranquilo.

40. La mayor parte del tiempo parece dolerme toda la cabeza.

41. No siempre digo la verdad.

42. Si la gente no se la hubiera agarrado conmigo, yo habría tenido mucho más éxito.

43. Mi habilidad para tomar decisiones es ahora mejor que nunca.

44. Una vez por semana o con más frecuencia, siento de pronto calor por todo el cuerpo sin razón aparente.

45. Me encuentro en tan buenas condiciones de salud física como la mayoría de mis amigos.

46. Prefiero hacerme el /la desentendido/a con amigos de la escuela o con personas conocidas a quienes no he visto por mucho tiempo, a menos que ellos me hablen primero.

47. Casi nunca siento dolor en el corazón o en el pecho.

48. En muchos momentos preferiría sentarme a soñar despierto/a que hacer cualquier otra cosa.

49. Soy una persona muy sociable.

50. Con frecuencia he tenido que recibir órdenes de alguien que no sabía tanto como yo.

51. No leo todos los editoriales del periódico diariamente.

52. No he llevado un tipo de vida adecuado y correcto.

53. Con frecuencia siento como un ardor, hormigueo, o adormecimiento en partes de mi cuerpo.

54. A mi familia no le gusta el trabajo que he elegido (o el que pienso elegir) como ocupación principal para toda mi vida.

55. A veces insisto tanto en algo, que los demás pierden la paciencia conmigo.

56. Quisiera poder ser tan feliz como otros parecen serlo.

57. Muy raras veces siento dolor en la nuca.

58. Creo que muchísimas personas exageran sus desgracias para ganarse la compasión y ayuda de los demás.

59. Sufro de malestares en la boca del estómago varias veces a la semana o con más frecuencia.

60. Cuando estoy con otras personas, me molestan cosas muy extrañas que oigo.

61. Soy una persona importante.

62. A menudo he deseado ser mujer. (O si usted es mujer: nunca me ha molestado ser mujer.)

63. Mis sentimientos no son heridos con facilidad.

64. Me gusta leer novelas de amor.

65. Casi siempre me siento triste.

66. Sería mejor si casi todas las leyes fueran eliminadas.

67. Me gusta la poesía.

68. De vez en cuando mortifico a los animales.

69. Creo que me gustaría el tipo de trabajo que hace un guardabosques.

70. Soy vencido/a fácilmente en una discusión.

71. En estos días me es difícil mantener la esperanza de llegar a ser alguien.

72. Mi alma a veces abandona mi cuerpo.

73. Ciertamente me falta confianza en mí mismo/a.

74. Me gustaría ser florista.

75. Por lo general siento que la vida vale la pena.

76. Se necesita discutir mucho para convencer a la mayoría de la gente de la verdad.

77. De vez en cuando dejo para mañana lo que debería hacer hoy.

78. Le agrado a la mayoría de las personas que me conocen.

79. No me importa si la gente se burla de mí.

80. Me gustaría ser enfermero/a.

81. Creo que la mayoría de la gente mentiría para salir adelante.

82. Hago muchas cosas de las que después me arrepiento (me arrepiento más que los demás de las cosas).

83. Tengo muy pocas peleas con miembros de mi familia.

84. Me suspendieron de la escuela una o más veces por mala conducta.

85. A veces siento un fuerte impulso de hacer algo dañino o chocante.

86. Me gusta ir a fiestas y a otras reuniones donde hay mucha alegría y ruido.

87. He encontrado problemas tan llenos de posibilidades que me ha sido imposible tomar una decisión.

88. Creo que la mujer debe tener tanta libertad sexual como el hombre.

89. Mis luchas más difíciles son conmigo mismo/a.

90. Quiero a mi padre, o (si su padre murió) quise a mi padre.

91. Tengo poca o ninguna molestia a causa de espasmos o contracciones musculares.

92. No parece importarme lo que me suceda.

93. A veces, cuando no me siento bien, me pongo irritable.

94. La mayor parte del tiempo me siento como si hubiera hecho algo malo o malvado.

95. Soy feliz la mayor parte del tiempo.

96. Veo cosas, animales o gente a mi alrededor que otros no ven.

97. Parece que mi cabeza o nariz están congestionadas la mayor parte del tiempo.

98. Algunas personas son tan mandonas que siento el deseo de hacer lo contrario de lo que me piden, aunque sepa que tienen razón.

99. Alguien me la tiene jurada.

100. Nunca he hecho algo peligroso sólo por la emoción de hacerlo.

101. A menudo siento como si tuviera una venda apretada alrededor de mi cabeza.

102. Me enojo algunas veces.

103. Disfruto más de una carrera o de un juego cuando hago apuestas.

104. La mayoría de la gente es honrada principalmente por temor a ser descubierta.

105. En la escuela a veces me llevaron ante el director por mala conducta.

106. Mi manera de hablar es como ha sido siempre (ni más rápida, ni más lenta, ni atropellada, ni con carraspera).

107. Mis modales en la mesa no son tan correctos en casa como cuando salgo a comer afuera en compañía de otras personas.

108. Cualquier persona capaz y dispuesta a trabajar duro tiene una buena probabilidad de obtener éxito.

109. Me parece que soy tan capaz e inteligente como la mayoría de las personas que me rodean.

110. La mayoría de la gente haría cosas algo injustas para no perderse una ganancia o ventaja.

111. Tengo muchos trastornos estomacales.

112. Me gustan las artes dramáticas.

113. Sé quien es el responsable de la mayoría de mis problemas.

114. Algunas veces siento tal atracción por los artículos personales de otras personas, como zapatos, guantes, etc., que me dan ganas de manosearlos o robarlos aunque a mí no me sirvan.

115. Ver sangre no me asusta ni me enferma.

116. A menudo no puedo comprender por qué he estado tan malhumorado/a e irritable.

117. Nunca he vomitado sangre o tosido sangre.

118. No me preocupa contagiarme de enfermedades.

119. Me gusta recoger flores o cultivar plantas decorativas.

120. Con frecuencia encuentro necesario defender lo que creo que es justo.

121. Nunca me he entregado a prácticas sexuales fuera de lo común.

122. A veces mis pensamientos han pasado por mi mente con más rapidez de lo que he podido expresarlos en palabras.

123. Si pudiera entrar a un cine sin pagar y estuviera seguro de no ser visto, probablemente lo haría.

124. A menudo pienso qué razón oculta puede tener otra persona cuando tiene una amabilidad conmigo.

125. Creo que mi vida de hogar es tan agradable como la de la mayoría de las personas que conozco.

126. Creo que la ley debe hacerse cumplir.

127. Las críticas o los retos me hieren terriblemente.

128. Me gusta cocinar.

129. Mi conducta está mayormente controlada por el comportamiento de los que me rodean.

130. Verdaderamente a veces siento que no sirvo para nada.

131. Cuando era chico/a tenía un grupo de amigos que tratábamos de mantenernos leales en todo tipo de problemas.

132. Creo en otra vida después de ésta.

133. Me gustaría ser soldado.

134. A veces siento el deseo de empezar una pelea a puñetazos con alguien.

135. Con frecuencia he perdido oportunidades porque no he podido decidirme a tiempo.

136. Me impacienta que me pidan consejos o que me interrumpan cuando estoy trabajando en algo importante.

137. Acostumbraba llevar un diario de mi vida.

138. Creo que se trama algo contra mí.

139. Preferiría ganar a perder en un juego.

140. Casi todas las noches me voy a dormir sin pensamientos o ideas que me causen molestia.

141. Durante los últimos años he estado bien la mayor parte del tiempo.

142. Nunca he tenido ataques o convulsiones.

143. No estoy subiendo ni bajando de peso.

144. Creo que me están siguiendo.

145. Siento que frecuentemente he sido castigado/castigada sin motivo.

146. Lloro con facilidad.

147. No puedo entender lo que leo tan bien como lo hacía antes.

148. Nunca en mi vida me he sentido mejor que ahora.

149. A veces siento dolores en la parte superior de la cabeza.

150. Algunas veces siento como si tuviera que herirme a mí mismo/a o a otra persona.

151. Me molesta cuando alguien me engaña tan hábilmente que tengo que admitir haber caído en su trampa.

152. No me canso con facilidad.

153. Me gusta conocer alguna gente importante porque eso me hace sentir importante.

154. Siento miedo cuando miro hacia abajo desde un lugar alto.

155. No me sentiría nervioso/a si algún miembro de mi familia tuviera problemas con la ley.

156. Nunca me siento feliz a menos que esté deambulando o viajando de un lado a otro.

157. No me preocupa lo que otros piensen de mi.

158. Me siento incómodo/a cuando tengo que hacer una payasada en una fiesta, aun si otros estén haciendo lo mismo.

159. Nunca he tenido un desmayo.

160. Me gustaba la escuela.

161. Frecuentemente tengo que esforzarme para no demostrar que soy tímido/a.

162. Alguien ha estado tratando de envenenarme.

163. No les tengo mucho miedo a las serpientes.

164. Rara vez o nunca tengo mareos.

165. Mi memoria parece estar bien.

166. Me preocupa el sexo.

167. Me es difícil entablar conversación con personas recién conocidas.

168. He tenido períodos en los cuales he realizado actividades sin saber más tarde lo que he estado haciendo.

169. Cuando estoy aburrido me gusta promover algo excitante.

170. Tengo miedo de perder el juicio.

171. Estoy en contra de dar dinero a los mendigos.

172. Con frecuencia noto que mi mano tiembla cuando trato de hacer algo.

173. Puedo leer por largo rato sin que se me canse la vista.

174. Me gusta leer y estudiar acerca de las cosas en que estoy trabajando.

175. Siento debilidad general la mayor parte del tiempo.

176. Muy pocas veces me duele la cabeza.

177. Mis manos no se han puesto torpes o poco hábiles.

178. Algunas veces, cuando siento vergüenza, empiezo a transpirar, lo cual me molesta muchísimo.

179. No he tenido dificultad en mantener el equilibrio al caminar.

180. Hay algo que no anda bien en mi mente.

181. No tengo ataques de alergia ni de asma.

182. He tenido ataques durante los cuales no podía controlar mis movimientos ni el habla pero me daba cuenta de lo que ocurría a mi alrededor.

183. No me agradan todas las personas que conozco.

184. Muy pocas veces sueño despierto/a.

185. Desearía no ser tan tímido/a.

186. No me da miedo manejar dinero.

187. Si yo fuera periodista me gustaría mucho escribir noticias del teatro.

188. Me gustan muchas distintas clases de diversiones y recreaciones.

189. Me gusta flirtear (coquetear).

190. Mi familia me trata más como a un niño que como a un adulto.

191. Me gustaría ser periodista.

192. Mi madre es una buena mujer, o (si su madre murió) mi madre era una buena mujer.

193. Cuando camino por la vereda tengo mucho cuidado de no pisar baldosas flojas.

194. Nunca he tenido erupciones en la piel que me hayan preocupado.

195. Hay muy poco amor y compañerismo en mi familia en comparación con otros hogares.

196. Frecuentemente me encuentro preocupado/a por algo.

197. Creo que me gustaría el trabajo de contratista de obras.

198. A menudo oigo voces sin saber de dónde vienen.

199. Me gusta la ciencia.

200. No me es difícil pedir ayuda a mis amigos, aunque no pueda devolverles el favor.

201. Me gusta mucho cazar.

202. Con frecuencia a mis padres les molestaba el tipo de gente con quienes andaba.

203. A veces soy un poco chismoso.

204. Aparentemente oigo tan bien como la mayoría de las personas.

205. Algunos miembros de mi familia tienen hábitos que me molestan e incomodan muchísimo.

206. A veces siento que puedo tomar decisiones con una facilidad fuera de lo común.

207. Me gustaría pertenecer a varios clubes.

208. Raras veces noto mi corazón palpitar y muy pocas veces me falta la respiración.

209. Me gusta hablar sobre el sexo.

210. Me gusta visitar lugares donde nunca he estado.

211. He sido inspirado/a hacia un modo de vida basado en el deber, el cual he seguido cuidadosamente desde entonces.

212. Algunas veces traté de impedir que algunas personas hicieran algo, no porque eso importara mucho, sino por cuestión de principios.

213. Me enojo con facilidad, pero se me pasa pronto.

214. He sido bastante independiente y libre de la dominación de mi familia.

215. Me preocupo muchísimo.

216. Alguien ha estado tratando de robarme.

217. Casi todos mis parientes simpatizan conmigo.

218. Tengo períodos de tanta intranquilidad que no puedo permanecer sentado/a en una silla por mucho tiempo.

219. He sido desilusionado/a en el amor.

220. Nunca me preocupo por mi apariencia personal.

221. Sueño frecuentemente con cosas que mejor las guardo para mí.

222. Se debe enseñar a los niños lo principal acerca del sexo.

223. Creo que no soy más nervioso/a que la mayoría de las personas.

224. Tengo pocos o ningún dolor.

225. Mi modo de hacer las cosas tiende a ser mal entendido por los demás.

226. A veces, sin razón alguna o incluso cuando las cosas andan mal, me siento sumamente feliz, "flotando entre nubes".

227. No culpo a nadie por tratar de apoderarse de todo lo que pueda en

este mundo.

228. Hay personas que están tratando de apoderarse de mis ideas y pensamientos.

229. He tenido momentos en los cuales mi mente quedó en blanco, mis actividades se interrumpieron y no sabía lo que pasaba a mi alrededor.

230. Puedo ser amistoso/a con personas que hacen cosas que considero incorrectas.

231. Me gusta estar en un grupo en el que se hagan bromas unos a otros.

232. A veces en las elecciones, voto por candidatos que conozco muy poco.

233. Me cuesta empezar a hacer cualquier cosa.

234. Creo que soy una persona condenada.

235. En la escuela era lento/a para aprender.

236. Si fuera artista me gustaría dibujar flores.

237. No me molesta ser poco pintón (o poco bonita).

238. Sudo muy fácilmente, aun en días fríos.

239. Tengo absoluta confianza en mí mismo/a.

240. A veces no pude evitar robar o llevarme algo de un negocio.

241. Es más seguro no confiar en nadie.

242. Una o varias veces por semana me pongo muy inquieto/a.

243. Cuando estoy en un grupo de personas me cuesta pensar en cosas apropiadas para hablar.

244. Cuando estoy bajoneado/a, algo emocionante me saca casi siempre de ese estado.

245. Cuando salgo de casa no me preocupa si las puertas y ventanas quedan bien cerradas.

246. Creo que mis pecados son imperdonables.

247. Tengo adormecida una o más partes de la piel.

248. No culpo a la persona que se aprovecha de la gente que se deja.

249. Mi vista es tan buena ahora como lo ha sido por años.

250. A veces me ha divertido tanto la astucia de algunos criminales que he deseado que se salgan con la suya.

251. Con frecuencia he sentido que desconocidos me estaban mirando con ojos críticos.

252. Todo tiene el mismo sabor.

253. Todos los días tomo una cantidad extraordinaria de agua.

254. La mayoría de la gente hace amigos porque es probable que les sean útiles.

255. No noto que me zumben o silben los oídos con frecuencia.

256. De vez en cuando siento bronca hacia familiares a quienes normalmente quiero.

257. Si fuera periodista me gustaría mucho escribir noticias deportivas.

258. Puedo dormir de día pero no de noche.

259. Estoy seguro/a de que la gente habla de mi.

260. De vez en cuando me río de chistes verdes.

261. Comparado con mis amigos, tengo muy pocos miedos.

262. No me perturbaría si, en un grupo de personas, se me pidiera iniciar una discusión o dar una opinión sobre algo que conozco bien.

263. Siempre siento disgusto con la ley cuando un criminal queda libre gracias a la habilidad de un abogado astuto.

264. He bebido alcohol en exceso.

265. Por lo general no le hablo a las personas hasta que ellas me hablan a mí.

266. Nunca he tenido problemas con la ley.

267. Tengo períodos en los que me siento demasiado alegre sin que exista una razón especial.

268. Quisiera no ser molestado/a por pensamientos sexuales.

269. Si varias personas se hallan en problemas, lo mejor que pueden hacer es ponerse de acuerdo sobre lo que van a decir y mantenerse firmes en ello.

270. No me molesta en particular ver sufrir a los animales.

271. Creo que tengo una sensibilidad más intensa que la mayoría de las personas.

272. En ningún momento de mi vida me gustó jugar con muñecas.

273. La mayor parte del tiempo la vida es una carga pesada para mí.

274. Soy tan susceptible con algunos asuntos que ni siquiera puedo hablar de ellos.

275. En la escuela me costaba mucho hablar en frente de la clase.

276. Quiero a mi madre, o (si su madre murió) quise a mi madre.

277. Aun cuando estoy con gente, me siento solo/a la mayor parte del tiempo.

278. Recibo toda la simpatía que debo recibir.

279. Me niego a participar en algunos juegos porque no soy hábil en ellos.

280. Me parece que hago amistades tan rápidamente como los demás.

281. No me gusta tener gente a mi alrededor.

282. Me han dicho que camino cuando estoy dormido/a.

283. La persona que provoca la tentación dejando algo valioso sin proteger es tan culpable del robo como quien lo roba.

284. Creo que casi todo el mundo diría una mentira para evitarse un problema.

285. Soy más sensible que la mayoría de la gente.

286. A la mayoría de la gente, interiormente, le desagrada esforzarse para ayudar a los demás.

287. Muchos de mis sueños son acerca del sexo.

288. Mis padres y familiares me encuentran más defectos de los que deberían.

289. Me avergüenzo fácilmente.

290. El dinero y los negocios me preocupan.

291. Nunca he estado enamorado/a de nadie.

292. Las cosas que han hecho algunos de mis familiares me han asustado.

293. Casi nunca sueño.

294. Con frecuencia me salen manchas rojas en el cuello.

295. Nunca he estado paralizado/a ni he sufrido de ninguna debilidad muscular fuera de lo común.

296. A veces pierdo o me cambia la voz, incluso sin estar resfriado/a.

297. Mi madre o mi padre frecuentemente me obligaron a obedecer, aun cuando yo creía que eso no era razonable.

298. A veces percibo olores extraños.

299. No puedo concentrarme en una sola cosa.

300. Tengo razones para sentirme celoso/a de uno o más de mis familiares.

301. Siento ansiedad por algo o por alguien casi todo el tiempo.

302. Me impaciento fácilmente con la gente.

303. La mayor parte del tiempo quisiera estar muerto/a.

304. Algunas veces estoy tan inquieto/a que me cuesta dormirme.

305. Sin duda alguna, he tenido más preocupaciones que las que me correspondían.

306. A nadie le importa mucho lo que le suceda a uno.

307. A veces oigo tan bien que me molesta.

308. Se me olvida enseguida lo que la gente me dice.

309. Generalmente tengo que detenerme y pensar antes de actuar, aun en asuntos sin importancia.

310. A menudo cruzo la calle para no encontrarme con alguien que veo venir.

311. Con frecuencia siento como si las cosas no fueran reales.

312. La única parte interesante del diario es la página de los chistes.

313. Tengo la costumbre de contar cosas sin importancia, tales como las lamparitas de un cartel luminoso, etc.

314. No tengo enemigos que realmente deseen hacerme daño.

315. Tiendo a ponerme en guardia con la gente que es algo más amable de lo que yo esperaba.

316. Tengo pensamientos extraños y peculiares.

317. Me pongo ansioso/a y me inquieto cuando tengo que hacer un viaje corto lejos de casa.

318. Por lo general espero tener éxito en las cosas que hago.

319. Oigo cosas extrañas cuando estoy solo/a.

320. He tenido miedo a cosas o personas que sabía que no podían hacerme daño.

321. No me da miedo entrar solo/a a un lugar donde haya gente reunida hablando.

322. Tengo miedo de usar un cuchillo o cualquier otra cosa muy afilada o puntiaguda.

323. Algunas veces disfruto hiriendo a las personas que amo.

324. Con facilidad puedo infundirle miedo a otros y a veces lo hago por diversión.

325. Tengo más dificultad para concentrarme que la que parecen tener los demás.

326. Varias veces he dejado de hacer algo porque he dudado de mi habilidad.

327. Se me ocurren palabras feas, muchas veces palabras horribles, y no me las puedo sacar de la cabeza.

328. Algunas veces algún pensamiento sin importancia me viene a la mente y me molesta por días.

329. Casi todos los días sucede algo que me asusta.

330. A veces estoy lleno/a de energía.

331. Me inclino a tomar las cosas muy en serio.

332. A veces he disfrutado al ser herido/a por un ser querido.

333. La gente dice cosas insultantes y vulgares acerca de mí.

334. Me siento incómodo/a cuando estoy "bajo techo" (dentro de una habitación, casa o edificio, etc.).

335. No soy extraordinariamente consciente de mí mismo/a.

336. Alguien tiene control sobre mi mente.

337. En reuniones sociales o fiestas, es más probable que me siente solo/a o con una sola persona, en vez de unirme al grupo.

338. La gente me desilusiona a menudo.

339. Algunas veces he sentido que las dificultades se acumulaban de tal modo que no podía superarlas.

340. Me encanta ir a bailes.

341. A veces mi mente parece trabajar más lentamente que de costumbre.

342. En los trenes, colectivos, etc., muchas veces hablo con desconocidos.

343. Me gustan los niños.

344. Me divierte apostar cuando se trata de poco dinero.

345. Si me dieran la oportunidad, podría hacer cosas que beneficiarían mucho al mundo.

346. A menudo he conocido personas a quienes se suponía expertas y que no eran mejores que yo.

347. Me siento un/a fracasado/a cuando me hablan del éxito de alguien que conozco bien.

348. A menudo pienso: "quisiera volver a ser niño/a".

349. Nunca me siento más feliz que cuando estoy solo/a.

350. Si me dieran la oportunidad sería un buen líder.

351. Me avergüenzan los cuentos verdes.

352. Generalmente la gente exige más respeto para sus propios derechos, que lo que está dispuesta a concederle a los demás.

353. Me agradan las reuniones sociales nada más que por estar con gente.

354. Trato de recordar cuentos divertidos para contárselos a otras personas.

355. Una o más veces en mi vida he sentido que alguien me hacía hacer cosas, hipnotizándome.

356. Me es difícil abandonar una tarea que empecé, aun cuando sea por poco tiempo.

357. Frecuentemente no me entero de los chismes del grupo al que pertenezco.

358. A menudo he encontrado personas envidiosas de mis buenas ideas, sólo porque a ellas no se les habían ocurrido antes.

359. Gozo con la exaltación de una multitud.

360. No me molesta conocer gente desconocida.

361. Alguien ha estado tratando de influir mi mente.

362. Recuerdo haber fingido estar enfermo/a para zafar de algo.

363. Mis preocupaciones parecen desaparecer cuando estoy con un grupo de amigos animados.

364. Me dan ganas de darme por vencido/a rápidamente cuando las cosas me salen mal.

365. Me gusta hacerle saber a la gente mi punto de vista acerca de las cosas.

366. He tenido períodos en que me sentía tan lleno/a de energía que no necesitaba dormir por varios días.

367. Siempre que me es posible, evito estar en una multitud.

368. Trato de evitar una situación de crisis o de dificultad.

369. Tiendo a dejar algo que quería hacer si otros creen que no vale la pena hacerlo.

370. Me gustan las fiestas y las reuniones sociales.

371. A menudo he deseado pertenecer al sexo opuesto.

372. No me enojo con facilidad.

373. He hecho algunas cosas malas en el pasado que nunca le cuento a nadie.

374. Casi toda la gente recurre a medios algo injustos para salir adelante en la vida.

375. Me pongo nervioso/a cuando la gente me hace preguntas personales.

376. Siento que no puedo planear mi propio futuro.

377. No estoy contento/a con mi forma de ser.

378. Me enojo cuando mis amigos o familiares me aconsejan cómo debo vivir mi vida.

379. Recibí muchas palizas de niño/a.

380. Me molesta cuando la gente me elogia.

381. No me gusta oír a la gente opinar sobre la vida.

382. A menudo tengo serios desacuerdos con personas cercanas.

383. Cuando las cosas se ponen mal, sé que puedo contar con la ayuda de mi familia.

384. Me gustaba jugar al "papá" o a la "mamá" cuando era niño/a.

385. No le tengo miedo al fuego.

386. A veces me mantuve alejado/a de alguna persona por temor a hacer o decir algo de lo que pudiera arrepentirme después.

387. Sólo puedo expresar mis verdaderos sentimientos cuando bebo.

388. Muy rara vez tengo momentos de bajoneo.

389. Con frecuencia me han dicho que tengo mal carácter.

390. Quisiera poder dejar de preocuparme por cosas que he dicho y que puedan haber herido los sentimientos de otras personas.

391. Me siento incapaz de contarle a alguien todo acerca de mí.

392. Le tengo miedo a los relámpagos.

393. Me gusta que los demás estén intrigados sobre lo que voy a hacer.

394. Frecuentemente mis planes han parecido estar tan llenos de dificultades que he tenido que abandonarlos.

395. Me da miedo estar solo/a en la obscuridad.

396. Muchas veces me he sentido mal al no ser comprendido/a cuando trataba de evitar que alguien cometiese un error.

397. Las tormentas con mucho viento me aterran.

398. Frecuentemente pido consejo a la gente.

399. El futuro es demasiado incierto como para que una persona haga planes serios.

400. Con frecuencia, aun cuando todo me va bien, siento que nada me importa.

401. No le tengo miedo al agua.

402. Frecuentemente tengo que "consultar con la almohada" antes de tomar una decisión.

403. A menudo la gente ha interpretado mal mis intenciones cuando trataba de ayudarla y corregirla.

404. No tengo dificultad al tragar.

405. Por lo general soy una persona tranquila y no me altero fácilmente.

406. Ciertamente me gustaría ganarle a un criminal con sus propias armas.

407. Merezco un castigo severo por mis pecados.

408. Me tomo tan en serio los disgustos que no puedo sacármelos de la cabeza.

409. Me molesta que alguien me observe cuando trabajo, aunque sepa que puedo hacerlo bien.

410. A menudo me molesta tanto que alguien trate de "colarse" delante de mí en una cola, que le tengo que decir algo.

411. A veces pienso que no sirvo para nada.

412. Cuando era chico/a, me hacía "la rabona" o "la rata" en la escuela.

413. Uno o varios de mis familiares son muy nerviosos.

414. A veces he tenido que ser duro/a con personas groseras o molestas.

415. Me preocupo bastante por posibles desgracias.

416. Tengo opiniones políticas bien definidas.

417. Me gustaría ser corredor/a de autos.

418. Está bien bordear los límites de la ley, siempre que realmente uno no la viole.

419. Hay ciertas personas que me desagradan tanto, que me alegro interiormente cuando están pagando las consecuencias por algo que han hecho.

420. Me pone nervioso/a tener que esperar.

421. Tiendo a dejar algo que deseo hacer porque otros piensan que no lo estoy haciendo bien.

422. Cuando era joven me gustaba lo emocionante.

423. Con frecuencia estoy dispuesto/a a causarme una inconveniencia para ganarle a alguien que me ha llevado la contraria.

424. Me molesta que me esté mirando la gente en las calles, negocios, etc..

425. El hombre que más tuvo que ver conmigo cuando era niño/a (mi padre, padrastro, etc.) fue muy estricto conmigo.

426. Me gustaba jugar a "la rayuela" y saltar a la soga.

427. Nunca he tenido una "visión".

428. Varias veces he cambiado de opinión acerca de mi trabajo o carrera.

429. Excepto por orden del médico, nunca tomo drogas o pastillas para dormir.

430. Frecuentemente me siento mal por ser tan irritable y protestón.

431. En la escuela, generalmente sacaba mala nota en conducta.

432. Me fascina el fuego.

433. Cuando estoy acorralado/a, digo sólo aquella parte de la verdad que es probable que no me perjudique.

434. Si me hallara en dificultades junto a varios amigos que fueran tan culpables como yo, preferiría echarme toda la culpa encima antes que delatarlos.

435. A menudo le tengo miedo a la obscuridad.

436. Cuando un hombre está con una mujer, generalmente está pensando cosas relacionadas con el sexo de ella.

437. Generalmente soy bien directo/a con la gente a quien estoy tratando de corregir o mejorar.

438. Me aterroriza la idea de un terremoto.

439. En seguida me convenzo por completo de una buena idea .

440. Generalmente resuelvo las cosas por mí mismo/a en vez de buscar a alguien que me diga cómo hacerlas.

441. Siento miedo si estoy en un lugar pequeño y cerrado.

442. Tengo que admitir que a veces me he preocupado sin motivo por algo que realmente no importaba.

443. No trato de disimular mi mala opinión o lástima sobre algunas personas.

444. Soy una persona muy nerviosa y tensa.

445. Frecuentemente he trabajado bajo las órdenes de personas que parecen arreglar las cosas de tal modo, que ellas reciben el reconocimiento de una buena labor, y sin embargo le atribuyen los errores a sus subordinados.

446. A veces me es difícil defender mis derechos por ser tan reservado/a.

447. La suciedad me espanta o me repugna.

448. Tengo una vida de ensueños de la cual no le cuento a nadie.

449. Algunos de mis familiares se enojan muy fácilmente.

450. No puedo hacer nada bien.

451. A menudo me siento culpable porque finjo mayor sufrimiento del que realmente siento acerca de algo.

452. Por regla general defiendo firmemente mis propias opiniones.

453. No le tengo miedo a las arañas.

454. El futuro me parece sin esperanzas.

455. Mis familiares y parientes más cercanos se llevan bastante bien.

456. Me gustaría usar ropa cara.

457. La gente puede hacerme cambiar de opinión con bastante facilidad aun cuando ya haya tomado una decisión.

458. Me ponen nervioso/a ciertos animales.

459. Puedo soportar tanto dolor como los demás.

460. Varias veces he sido la última persona en darme por vencido/a al tratar de hacer algo.

461. Me hace enojar que la gente me apure.

462. No tengo miedo a los ratones.

463. Varias veces por semana siento como si fuera a suceder algo espantoso.

464. Me siento cansado/a una buena parte del tiempo.

465. Me gusta arreglar las cerraduras de las puertas.

466. A veces estoy seguro/a de que la gente puede saber lo que estoy pensando.

467. Me gusta leer sobre temas científicos.

468. Me da miedo estar solo/a en un sitio amplio al descubierto.

469. Algunas veces me siento a punto de derrumbarme.

470. Muchas personas tienen mala conducta sexual.

471. Con frecuencia he sentido miedo en medio de la noche.

472. Me molesta mucho que se me olvide dónde pongo las cosas.

473. La persona por quien sentía más afecto y admiración cuando era niño/a, fue una mujer (madre, hermana, tía u otra mujer).

474. Me gustan más las historias de aventuras que las románticas.

475. Muchas veces me confundo y me olvido lo que quiero decir.

476. Soy torpe y poco agradable.

477. Me gusta jugar deportes fuertes (como el rugby o el fútbol).

478. Odio a mi familia entera.

479. Cierta gente cree que es difícil llegar a conocerme.

480. Paso la mayor parte de mi tiempo libre a solas.

481. Cuando la gente hace algo que me enoja, les hago saber cómo me siento.

482. Por lo general me cuesta decidir qué hacer.

483. La gente no me ve atractivo/a.

484. La gente no es muy amable conmigo.

485. A menudo me parece que no soy tan bueno/a como los demás.

486. Soy muy "cabeza dura".

487. Me gustó fumar marihuana.

488. La enfermedad mental es signo de debilidad.

489. Tengo problemas con las drogas o con el alcohol.

490. Los fantasmas o los espíritus pueden influenciar a la gente para bien o para mal.

491. Me siento incapacitado/a cuando tengo que tomar decisiones importantes.

492. Siempre trato de ser agradable aun cuando los demás estén molestos o sean críticos.

493. Cuando tengo un problema me ayuda el contárselo a alguien.

494. Mis principales proyectos de vida están a mi alcance.

495. Creo que la gente debería guardarse sus problemas personales para sí misma.

496. No estoy sintiendo mucha presión o tensión últimamente.

497. Me molesta tremendamente pensar en hacer cambios en mi vida.

498. Mis mayores problemas son causados por el comportamiento de alguien cercano a mí.

499. Odio ir al médico aun cuando estoy enfermo/a.

500. Aunque no estoy feliz con mi vida, ahora no hay nada que pueda hacer al respecto.

501. Discutir los problemas y preocupaciones con alguien es a menudo más útil que tomar drogas o medicinas.

502. Tengo ciertos hábitos que son verdaderamente dañinos.

503. Cuando hay que resolver problemas, por lo general dejo que otros tomen el mando.

504. Reconozco que tengo varios defectos que no podré cambiar.

505. Estoy tan harto/a de lo que tengo que hacer cada día que quisiera dejar de hacerlo.

506. Recientemente he pensado matarme.

507. A menudo me enojo mucho cuando interrumpen mi trabajo.

508. A menudo siento que puedo leerle la mente a la gente.

509. Me pone nervioso/a tener que tomar decisiones importantes.

510. La gente me dice que como demasiado rápido.

511. Por lo menos una vez a la semana me drogo o me emborracho.

512. He sufrido una pérdida trágica en mi vida de la que sé que nunca me recuperaré.

513. A veces me enojo tanto que no sé lo que digo o lo que hago.

514. Cuando la gente me pide que haga algo, me cuesta decir que no.

515. Nunca me siento más feliz que cuando estoy solo/a.

516. Mi vida es vacía y sin sentido.

517. Me cuesta conservar un trabajo.

518. He cometido muchos errores graves en mi vida.

519. Me enojo conmigo mismo/a por ceder tanto a los demás

520. Ultimamente he pensado mucho en suicidarme.

521. Me gusta tomar decisiones y asignar trabajo a los demás.

522. Aunque me quedara sin mi familia sé que siempre habrá alguien que me ayude.

523. En los cines, restaurantes, o eventos deportivos, odio tener que hacer colas.

524. Nadie lo sabe pero he intentado matarme.

525. Todo está sucediendo muy rápido alrededor mío.

526. Sé que soy una carga para los demás.

527. Al final de un mal día, por lo general necesito tomar unos tragos para relajarme.

528. La mayoría de los problemas que tengo se deben a la mala suerte.

529. A veces parece que no puedo parar de hablar.

530. A veces me corto o me hago daño a propósito sin saber por qué.

531. Trabajo largas horas aun cuando mi empleo no lo requiere.

532. Por lo general me siento mejor después de llorar.

533. Se me olvida dónde dejo las cosas.

534. Si pudiera vivir mi vida de nuevo, no cambiaría mucho.

535. Me irrita mucho cuando las personas con quienes trabajo no hagan las cosas a tiempo.

536. Cuando estoy enojado me duele la cabeza.

537. Me gusta negociar una compra.

538. La mayoría de los hombres le son infieles a sus esposas de ver en cuando.

539. Ultimamente he perdido el deseo de resolver mis problemas.

540. Me he enojado y he roto muebles o platos cuando estaba bebiendo.

541. Trabajo mejor cuando tengo una fecha de límite precisa.

542. Me he enojado tanto con alguien que he sentido como si fuera a explotar.

543. A veces me vienen a la mente pensamientos terribles acerca de mi familia.

544. La gente me dice que tengo problemas con el alcohol pero yo no estoy de acuerdo.

545. Nunca tengo tiempo para terminar las cosas.

546. Últimamente, pienso mucho en la muerte y la vida en el más allá.

547. Muchas veces guardo cosas que probablemente nunca usaré.

548. He estado tan enojado/a a veces que he llegado a golpear y lastimar a otra persona.

549. Ultimamente me parece que estoy bajo prueba en todo lo que hago.

550. Estoy bastante alejado de mis familiares actualmente.

551. A veces me parece oír mis pensamientos en voz alta.

552. Cuando estoy triste, siempre me hace bien visitar a mis amigos/as.

553. Me parece que mucho de lo que me está pasando ahora ya me sucedió antes.

554. Cuando mi vida se pone difícil, me dan ganas de darme por vencido/a.

555. No puedo entrar en un cuarto oscuro ni siquiera en mi propia casa.

556. Me preocupo mucho por el dinero.

557. El hombre debe ser el jefe de la familia.

558. En el único lugar donde me siento relajado/a es en mi casa.

559. Mis compañeros de trabajo entienden muy poco mis problemas.

560. Estoy conforme con el dinero que gano.

561. Por lo general tengo energía suficiente para hacer mi trabajo.

562. Me cuesta aceptar elogios.

563. En la mayoría de los matrimonios, uno o los dos cónyuges no son felices.

564. Casi nunca pierdo el control.

565. Hoy en día me cuesta mucho esfuerzo recordar lo que me dicen.

566. Cuando estoy triste, mi trabajo es el que se perjudica.

567. La mayoría de las personas casadas no se demuestran mucho cariño mutuo.

HOJA DE RESPUESTAS
INVENTARIO MMPI-2

APELLIDO:…… NOMBRES: …….
SEXO:……EDAD: …… FECHA DE HOY:……../……/……..

Para contestar el cuestionario, rellene el círculo **V** (verdadero) o **F** (falso) correspondiente al número de cada frase**.** Trate de responder **todas** las frases. Fíjese bien en el número de la frase al contestar en esta hoja.

	V F		V F		V F		V F		V F		V F		V F		V F		V F		V F
1.	0 0	61.	0 0	121.	0 0	181.	0 0	241.	0 0	301.	0 0	361.	0 0	421.	0 0	481.	0 0	541.	0 0
2.	0 0	62.	0 0	122.	0 0	182.	0 0	242.	0 0	302.	0 0	362.	0 0	422.	0 0	482.	0 0	542.	0 0
3.	0 0	63.	0 0	123.	0 0	183.	0 0	243.	0 0	303.	0 0	363.	0 0	423.	0 0	483.	0 0	543.	0 0
4.	0 0	64.	0 0	124.	0 0	184.	0 0	244.	0 0	304.	0 0	364.	0 0	424.	0 0	484.	0 0	544.	0 0
5.	0 0	65.	0 0	125.	0 0	185.	0 0	245.	0 0	305.	0 0	365.	0 0	425.	0 0	485.	0 0	545.	0 0
6.	0 0	66.	0 0	126.	0 0	186.	0 0	246.	0 0	306.	0 0	366.	0 0	426.	0 0	486.	0 0	546.	0 0
7.	0 0	67.	0 0	127.	0 0	187.	0 0	247.	0 0	307.	0 0	367.	0 0	427.	0 0	487.	0 0	547.	0 0
8.	0 0	68.	0 0	128.	0 0	188.	0 0	248.	0 0	308.	0 0	368.	0 0	428.	0 0	488.	0 0	548.	0 0
9.	0 0	69.	0 0	129.	0 0	189.	0 0	249.	0 0	309.	0 0	369.	0 0	429.	0 0	489.	0 0	549.	0 0
10.	0 0	70.	0 0	130.	0 0	190.	0 0	250.	0 0	310.	0 0	370.	0 0	430.	0 0	490.	0 0	550.	0 0
11.	0 0	71.	0 0	131.	0 0	191.	0 0	251.	0 0	311.	0 0	371.	0 0	431.	0 0	491.	0 0	551.	0 0
12.	0 0	72.	0 0	132.	0 0	192.	0 0	252.	0 0	312.	0 0	372.	0 0	432.	0 0	492.	0 0	552.	0 0
13.	0 0	73.	0 0	133.	0 0	193.	0 0	253.	0 0	313.	0 0	373.	0 0	433.	0 0	493.	0 0	553.	0 0
14.	0 0	74.	0 0	134.	0 0	194.	0 0	254.	0 0	314.	0 0	374.	0 0	434.	0 0	494.	0 0	554.	0 0
15.	0 0	75.	0 0	135.	0 0	195.	0 0	255.	0 0	315.	0 0	375.	0 0	435.	0 0	495.	0 0	555.	0 0
16.	0 0	76.	0 0	136.	0 0	196.	0 0	256.	0 0	316.	0 0	376.	0 0	436.	0 0	496.	0 0	556.	0 0
17.	0 0	77.	0 0	137.	0 0	197.	0 0	257.	0 0	317.	0 0	377.	0 0	437.	0 0	497.	0 0	557.	0 0
18.	0 0	78.	0 0	138.	0 0	198.	0 0	258.	0 0	318.	0 0	378.	0 0	438.	0 0	498.	0 0	558.	0 0
19.	0 0	79.	0 0	139.	0 0	199.	0 0	259.	0 0	319.	0 0	379.	0 0	439.	0 0	499.	0 0	559.	0 0
20.	0 0	80.	0 0	140.	0 0	200.	0 0	260.	0 0	320.	0 0	380.	0 0	440.	0 0	500.	0 0	560.	0 0
21.	0 0	81.	0 0	141.	0 0	201.	0 0	261.	0 0	321.	0 0	381.	0 0	441.	0 0	501.	0 0	561.	0 0
22.	0 0	82.	0 0	142.	0 0	202.	0 0	262.	0 0	322.	0 0	382.	0 0	442.	0 0	502.	0 0	562.	0 0
23.	0 0	83.	0 0	143.	0 0	203.	0 0	263.	0 0	323.	0 0	383.	0 0	443.	0 0	503.	0 0	563.	0 0
24.	0 0	84.	0 0	144.	0 0	204.	0 0	264.	0 0	324.	0 0	384.	0 0	444.	0 0	504.	0 0	564.	0 0
25.	0 0	85.	0 0	145.	0 0	205.	0 0	265.	0 0	325.	0 0	385.	0 0	445.	0 0	505.	0 0	565.	0 0
26.	0 0	86.	0 0	146.	0 0	206.	0 0	266.	0 0	326.	0 0	386.	0 0	446.	0 0	506.	0 0	566.	0 0
27.	0 0	87.	0 0	147.	0 0	207.	0 0	267.	0 0	327.	0 0	387.	0 0	447.	0 0	507.	0 0	567.	0 0
28.	0 0	88.	0 0	148.	0 0	208.	0 0	268.	0 0	328.	0 0	388.	0 0	448.	0 0	508.	0 0		
29.	0 0	89.	0 0	149.	0 0	209.	0 0	269.	0 0	329.	0 0	389.	0 0	449.	0 0	509.	0 0		
30.	0 0	90.	0 0	150.	0 0	210.	0 0	270.	0 0	330.	0 0	390.	0 0	450.	0 0	510.	0 0		
31.	0 0	91.	0 0	151.	0 0	211.	0 0	271.	0 0	331.	0 0	391.	0 0	451.	0 0	511.	0 0		
32.	0 0	92.	0 0	152.	0 0	212.	0 0	272.	0 0	332.	0 0	392.	0 0	452.	0 0	512.	0 0		
33.	0 0	93.	0 0	153.	0 0	213.	0 0	273.	0 0	333.	0 0	393.	0 0	453.	0 0	513.	0 0		
34.	0 0	94.	0 0	154.	0 0	214.	0 0	274.	0 0	334.	0 0	394.	0 0	454.	0 0	514.	0 0		
35.	0 0	95.	0 0	155.	0 0	215.	0 0	275.	0 0	335.	0 0	395.	0 0	455.	0 0	515.	0 0		
36.	0 0	96.	0 0	156.	0 0	216.	0 0	276.	0 0	336.	0 0	396.	0 0	456.	0 0	516.	0 0		
37.	0 0	97.	0 0	157.	0 0	217.	0 0	277.	0 0	337.	0 0	397.	0 0	457.	0 0	517.	0 0		
38.	0 0	98.	0 0	158.	0 0	218.	0 0	278.	0 0	338.	0 0	398.	0 0	458.	0 0	518.	0 0		
39.	0 0	99.	0 0	159.	0 0	219.	0 0	279.	0 0	339.	0 0	399.	0 0	459.	0 0	519.	0 0		
40.	0 0	100.	0 0	160.	0 0	220.	0 0	280.	0 0	340.	0 0	400.	0 0	460.	0 0	520.	0 0		
41.	0 0	101.	0 0	161.	0 0	221.	0 0	281.	0 0	341.	0 0	401.	0 0	461.	0 0	521.	0 0		
42.	0 0	102.	0 0	162.	0 0	222.	0 0	282.	0 0	342.	0 0	402.	0 0	462.	0 0	522.	0 0		
43.	0 0	103.	0 0	163.	0 0	223.	0 0	283.	0 0	343.	0 0	403.	0 0	463.	0 0	523.	0 0		
44.	0 0	104.	0 0	164.	0 0	224.	0 0	284.	0 0	344.	0 0	404.	0 0	464.	0 0	524.	0 0		
45.	0 0	105.	0 0	165.	0 0	225.	0 0	285.	0 0	345.	0 0	405.	0 0	465.	0 0	525.	0 0		
46.	0 0	106.	0 0	166.	0 0	226.	0 0	286.	0 0	346.	0 0	406.	0 0	466.	0 0	526.	0 0		
47.	0 0	107.	0 0	167.	0 0	227.	0 0	287.	0 0	347.	0 0	407.	0 0	467.	0 0	527.	0 0		
48.	0 0	108.	0 0	168.	0 0	228.	0 0	288.	0 0	348.	0 0	408.	0 0	468.	0 0	528.	0 0		
49.	0 0	109.	0 0	169.	0 0	229.	0 0	289.	0 0	349.	0 0	409.	0 0	469.	0 0	529.	0 0		
50.	0 0	110.	0 0	170.	0 0	230.	0 0	290.	0 0	350.	0 0	410.	0 0	470.	0 0	530.	0 0		
51.	0 0	111.	0 0	171.	0 0	231.	0 0	291.	0 0	351.	0 0	411.	0 0	471.	0 0	531.	0 0		
52.	0 0	112.	0 0	172.	0 0	232.	0 0	292.	0 0	352.	0 0	412.	0 0	472.	0 0	532.	0 0		
53.	0 0	113.	0 0	173.	0 0	233.	0 0	293.	0 0	353.	0 0	413.	0 0	473.	0 0	533.	0 0		
54.	0 0	114.	0 0	174.	0 0	234.	0 0	294.	0 0	354.	0 0	414.	0 0	474.	0 0	534.	0 0		
55.	0 0	115.	0 0	175.	0 0	235.	0 0	295.	0 0	355.	0 0	415.	0 0	475.	0 0	535.	0 0		
56.	0 0	116.	0 0	176.	0 0	236.	0 0	296.	0 0	356.	0 0	416.	0 0	476.	0 0	536.	0 0		
57.	0 0	117.	0 0	177.	0 0	237.	0 0	297.	0 0	357.	0 0	417.	0 0	477.	0 0	537.	0 0		
58.	0 0	118.	0 0	178.	0 0	238.	0 0	298.	0 0	358.	0 0	418.	0 0	478.	0 0	538.	0 0		
59.	0 0	119.	0 0	179.	0 0	239.	0 0	299.	0 0	359.	0 0	419.	0 0	479.	0 0	539.	0 0		
60.	0 0	120.	0 0	180.	0 0	240.	0 0	300.	0 0	360.	0 0	420.	0 0	480.	0 0	540.	0 0		